

Raport Vjetor 2024



FONDI
I SIGURIMIT
TË DETYRUESHËM
TË KUJDESIT
SHËNDETËSOR

PARATHËNIE

Raporti vjetor është një botim i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

Synimi i këtij botimi është informimi i publikut mbi menaxhimin e skemës së sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, në përputhje me politikat kombëtare të kujdesit shëndetësor të paraqitura përgjatë aktivitetit vjetor të institucionit.

Materialet në këtë botim mbrohen nga e drejta e autorit dhe nuk mund të riprodhohen pa bërë të ditur me saktësi burimin dhe autorësinë.

Mars 2025

TABELA E PËRMBAJTJES

Shkurtime e përdorura	5
1. Rreth Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.....	7
1.1 Vizioni.....	7
1.2 Misioni	7
1.3 Baza Ligjore	7
2. Menaxhimi i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor	8
2.1 Drejtimi i Fondit.....	8
2.2 Struktura organizative e Fondit gjatë vitit 2024.....	9
2.3 Vendimet e Këshillit Administrativ gjatë vitit 2024	10
3. Zbatimi i Skemës së Sigurimeve Shëndetësore.....	12
3.1 Panoramë e përgjithshme e skemës së sigurimeve shëndetësore	12
3.2 Parimet e skemës së sigurimeve shëndetësore në Shqipëri	12
3.3 Kategoritë përfituese nga skema e sigurimeve.....	13
3.4 Sigurimi vullnetar.....	13
3.5 Baza për llogaritjen e kontributeve	13
3.6 Masa e kontributit	14
4. Burimet Financiare.....	14
4.1 Burimet financiare të skemës gjatë vitit 2024	14
4.2 Të ardhurat nga kontributi i sigurimeve shëndetësore (DPT, ISSH).....	17
4.3 Transferta nga buxheti i shtetit.....	17
4.4 Të ardhura të tjera	17
5. Financimi i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor.....	18
5.1 Financimi i listës së barnave të rimbursueshme dhe pajisjeve	20
5.2 Financimi i shërbimit të kujdesit shëndetësor parësor	21
5.3 Financimi i shërbimit spitalor	21
6. Shpenzime të tjera të Fondit.....	23
6.1 Shpenzimet administrative	23
6.2 Shpenzimet për investime	23
7. Përfitimet e Popullatës	23
7.1 Paketa e shërbimeve në kujdesin shëndetësor parësor	24
7.2 Kontrolli mjekësor bazë	27
7.3 Paketa e shërbimeve në shërbimin spitalor	31
7.4 Paketat shëndetësore	48
7.5 Shërbimi i sterilizimit të instrumenteve kirurgjikalë.....	55

7.6	Lista e barnave të rimbursueshme dhe e pajisjeve mjekësore të rimbursueshme	58
8.	Zhvillimi i sistemit të informacionit.....	66
8.1	Sistemi elektronik për formularët e vizitave të mjekut të familjes.....	66
8.2	Përditësim i sistemit të menaxhimit të Depove Farmaceutike	68
8.3	Sistemi i recetës elektronike.....	69
8.4	Zbatimi i sistemit eKontroll: sistemi i kontrollit të subjekteve që kanë kontratë me Fondin.....	69
8.5	Sistemi Regjistri i të Siguruarve.....	70
8.6	Përmirësimi i rrjetit të FSDKSH	70
9.	Monitorimi i Kontratave me Dhënësit e Shërbimeve Shëndetësore	70
9.1	Monitorimi i zbatimit të kontratave	71
9.2	Monitorimi i zbatimit të kontratave nga Qendrat Shëndetësore.....	71
9.3	Monitorimi i zbatimit të kontratave nga Farmacitë dhe Depot Farmaceutike.....	72
9.4	Monitorimi i zbatimit të kontratave me Spitalet	75
9.5	Problematikat Kryesore.....	77
10.	Përmirësimi i Administrimit të Fondit	77
10.1	Misioni i auditimit të brendshëm	78
10.2	Aktiviteti i auditimit të brendshëm të Fondit	78
10.3	Fushat me risk të lartë dhe trajtimi i tyre.....	78
10.4	Rekomandime	80
10.5	Konkluzione	81
11.	Komunikimi dhe Informimi i Publikut.....	82
12.	Bashkëpunimi me Institucionet.....	84
12.1	Bashkëpunimi ndërinstitucional	84
12.2.	Marrëveshjet Ndërkombëtare.....	85
13.	Prioritetet Strategjike dhe Objektivat	87
13.1	Prioritetet strategjike	87
13.2	Objektivat vjetore 2025.....	88

Shkurtime e përdorura

FSDKSH	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
FONDI	Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
MSHMS	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
MFE	Ministria e Financave dhe Ekonomisë
ISSH	Instituti i Sigurimeve Shoqërore
DPT	Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
BSH	Banka e Shqipërisë
VKM	Vendim i Këshillit të Ministrave
AKSHI	Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
SHISH	Shërbimi Informativ i Shtetit
INSTAT	Instituti i Statistikave
KA	Këshilli Administrativ i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
LBR	Lista e Barnave të Rimbursueshme
QSH	Qendër Shëndetësore
MPF	Mjek i Përgjithshëm dhe i Familjes
QSUNT	Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë
INN	Klasifikimi Ndërkombëtar i Barnave
ATC	Klasifikimi Anatomik Terapeutik Kimik
RMI	Rezonanca magnetike
EKG	Elektrokardiogramë
IEVP	Institucione të Ekzekutimit të Vendimeve Penale
PSK	Person me Sëmundje Kronike
PAK	Person me Aftësi të Kufizuara
DRF	Drejtori Rajonale e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
PKI	Infrastruktura e Çelësit Publik
e-RX	Receta Elektronike
e-RM	Sistemi i Raportit Elektronik
SISHP	Sistemi i Formularit të Vizitës
AHIS	Sistemi i Regjistrat Elektronik i të Siguruarve
RSS	Nënshkrimi Elektronik Online
KSH	Karta e Shëndetit
PKIE	Plani Kombëtar për Integrimin European
SHISH	Shërbimi Informativ i Shtetit
HAP	Health for All Project
SQDNE	Sistemi i Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik

KDI	Koordinatori për të Drejtën e Informimit
PB	Platforma e Bashkëqeverisjes
SMP	Spektori i Marrëdhënieve me Publikun
FB	Facebook

1. Rreth Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

1.1 Vizioni

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH), ka si vizion krijimin e ndjenjës së sigurisë në përmbushjen e nevojave të popullatës për shërbime shëndetësore dhe për të bërë skemën e shërbimeve shëndetësore më të aksesueshme.

E drejta për kujdes shëndetësor sanksionohet në ligjet ndërkombëtare dhe sigurisht edhe në ligjin themeltar të shtetit shqiptar. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e njeh të drejtën për kujdes shëndetësor për të gjithë shtetasit e saj, duke sanksionuar parimet e mbulimit universal. Më konkretisht, në nenin 55 të saj thuhet: *“Shtetasit gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejtën për kujdes shëndetësor nga shteti. Kushdo ka të drejtë për sigurim shëndetësor sipas procedurës së caktuar me ligj”*.

FSDKSH-ja në funksion të rritjes së aksesit dhe përmirësimit të cilësisë së shërbimit shëndetësor për popullatën, fokusohet në prirje të rëndësishme që lidhen me ndryshimet demografike dhe epidemiologjike, zhvillimet teknologjike, si dhe pritshmëritë në rritje të konsumatorit për akses në trajtimet mjekësore cilësore dhe bashkëkohore.

1.2 Misioni

FSDKSH është i vetmi organ autonom publik, i cili administron dhe zhvillon skemën e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë. Nisur nga kompetencat e parashikuara nga ligji, FSDKSH-ja, menaxhon skemën e sigurimeve shëndetësore, duke synuar në mbulimin e popullsisë në përfitimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor, të financuara nga sektori publik dhe privat, në bazë të legjislacionit, duke siguruar fleksibilitet në financimin e shërbimeve shëndetësore, transparencë në administrim dhe besueshmëri maksimale të popullatës, në përputhje me politikat kombëtare të kujdesit shëndetësor. FSDKSH-ja, garanton përfitimet e sigurimeve shëndetësore për popullatën dhe qëndrueshmërinë e skemës së sigurimeve, e cila vepron në bazë të parimit të solidaritetit dhe barazisë.

1.3 Baza Ligjore

FSDKSH ushtron veprimtarinë e tij në bazë të ligjit nr. 10383, datë 24.02.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, i cili përcakton statusin ligjor, strukturën, funksionet dhe veprimtarinë e Fondit.

Gjithashtu FSDKSH organizohet dhe funksionon në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 124, datë 5.3.2014, “Për miratimin e statutit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

FSDKSH menaxhon financimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor në skemën e sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor, në përputhje me politikat kombëtare të kujdesit shëndetësor, të vendosura nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Legjislacioni parashikon se sigurimi i detyrueshëm shëndetësor bazohet në pagesën e kontributeve përkatëse për të gjithë personat ekonomikisht aktivë me banim të përhershëm në Shqipëri dhe kategorinë e personave ekonomikisht joaktivë, pagesa e kontributeve të cilëve financohet nga Buxheti i Shtetit ose burime të tjera të përcaktuara me ligj.

FSDKSH menaxhon veprimtarinë e tij brenda burimeve të vlefshme financiare dhe nuk hyn në borxhe. Nëpërmjet organeve të saj drejtuese, FSDKSH ka të drejtë të hartojë dhe të nxjerrë vendime, udhëzime, urdhëresa, rregullore dhe akte të tjera administrative, në mbështetje dhe zbatim të akteve ligjore e nënligjore si dhe të kompetencave që i janë dhënë.

2. Menaxhimi i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

2.1 Drejtimi i Fondit

Drejtimi i FSDKSH-së organizohet dhe funksionon mbi bazën e statutit të tij, të miratuar nga Këshilli i Ministrave. Organet drejtuese të Fondit janë: Këshilli Administrativ dhe Drejtori i Përgjithshëm.

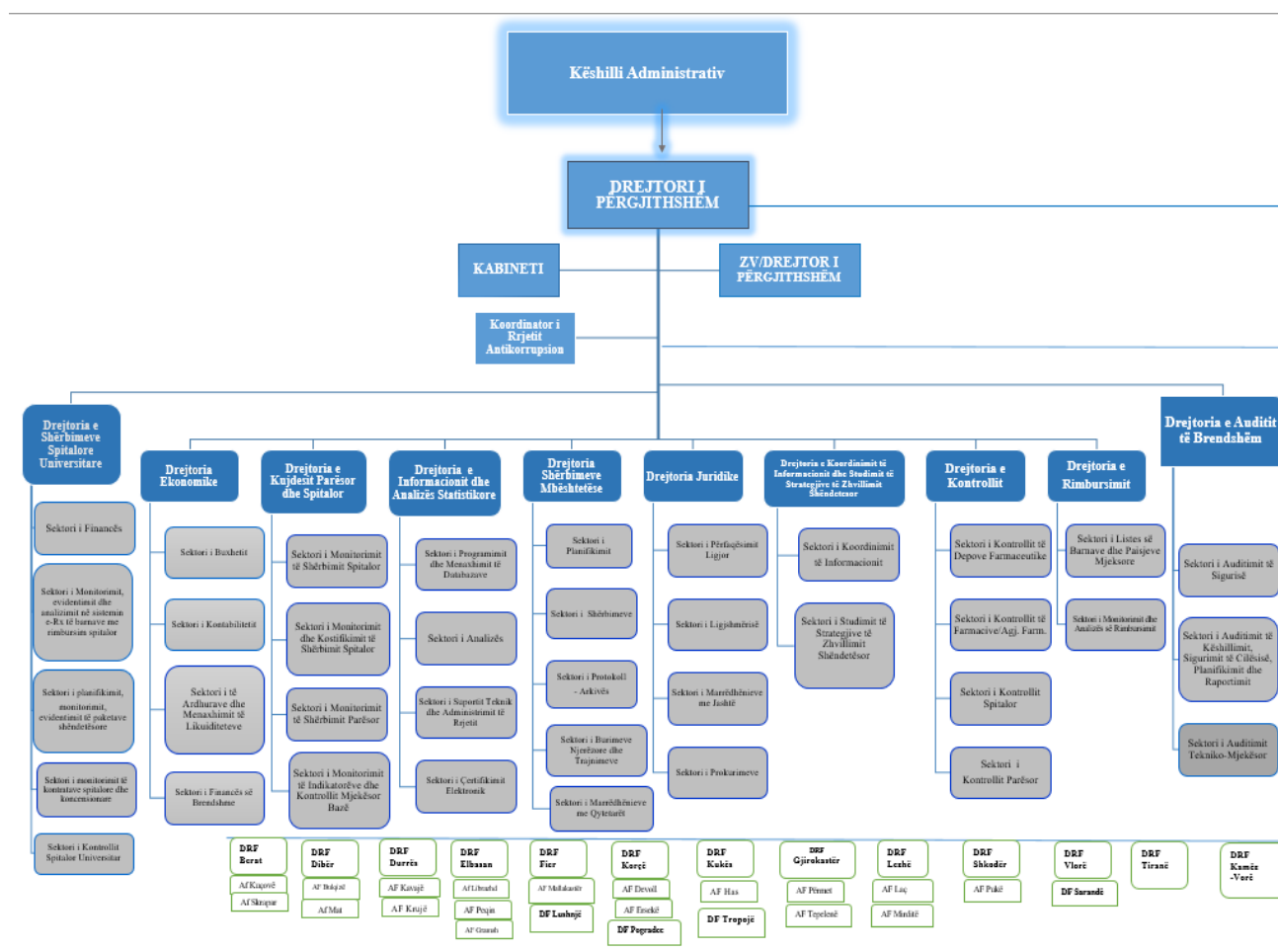
- Këshilli Administrativ është organi më i lartë vendimmarrës i FSDKSH-së dhe ka në përbërjen e tij 7 (shtatë) anëtarë, përkatësisht:
 - Ministri i Shëndetësisë ose përfaqësuesi i tij;
 - Ministri i Financave ose përfaqësuesi i tij;
 - Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë ose përfaqësuesi i tij;
 - Drejtori i Përgjithshëm i Fondit ose përfaqësuesi i tij;
 - Drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore ose përfaqësuesi i tij;
 - Një përfaqësues i sindikatës së të punësuarve të përcaktuar nga Këshilli i Ministrave;
 - Një përfaqësues i organizatës së profesionistëve të shëndetësisë, të përcaktuar nga Këshilli i Ministrave.
- Në kuadër të ndryshimeve të ministrive dhe emërtimeve të tyre, aktualisht përbërja e Këshillit Administrativ është si më poshtë:

- Ministri i Shëndetësisë ose përfaqësuesi i tij (2 përfaqësues);
- Ministri i Financave ose përfaqësuesi i tij;
- Drejtori i Përgjithshëm i Fondit ose përfaqësuesi i tij;
- Drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore ose përfaqësuesi i tij;
- Presidenti i Urdhrit të Mjekut të Shqipërisë ose përfaqësuesi i tij;
- Një përfaqësues i sindikatës së profesionistëve të shëndetësisë, të përcaktuar nga Këshilli i Ministrave.

Koha e shërbimit të anëtarëve në Këshillin Administrativ është 4 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje ose për aq kohë sa anëtari është përfaqësues i organit përkatës.

- Drejtori i Përgjithshëm zgjidhet nga Këshilli Administrativ mes jo më pak se tre kandidaturave të paraqitura nga anëtarët e Këshillit Administrativ. Koha e ushtrimit të detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm është 5 vjet.

2.2 Struktura organizative e Fondit gjatë vitit 2024



2.3 Vendimet e Këshillit Administrativ gjatë vitit 2024

- VKA nr.1, datë 31.01.2024, “Për miratimin e buxhetit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për vitin 2024”.
- VKA nr.2, datë 31.01.2024, “Për financimin shtesë të spitaleve publike për realizimin e paketave të shërbimeve të miratuara me Vendim të Këshillit të Ministrave, të ofruara nga shërbimet spitalore publike për vitin 2024”.
- VKA nr. 3, datë 28.02.2024, “Për krijimin e Komisionit teknik të Listës së Barnave të Rimbursuara për vitin 2024”.
- VKA nr.4, datë 28.02.2024, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 1 datë 11.01.2019 “Për funksionimin e Komisionit teknik të barnave të rimbursuara”.
- VKA nr.5, datë 18.03.2024, "Për një ndryshim në vendimin nr.489 datë 30.07.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Listës së Barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe masën e mbulimit të çmimit të tyre", të ndryshuar.
- VKA nr.6, datë 11.04.2024, “Për miratimin e raportit financiar dhe bilancit vjetor 2023 të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor”.
- VKA nr.7, datë 11.04.2024, “Për mënyrën e përdorimit të fondit rezervë për vitin 2024”.
- VKA nr.8, datë 11.04.2024, “Për rishpërndarje të buxhetit të shërbimit spitalor për vitin 2024”.
- VKA nr.9, datë 11.04.2024, “Për miratimin e Raportit Vjetor 2023 të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.
- VKA nr.10, datë 31.05.2024, “Për rishpërndarje nga rezerva e buxhetit të shërbimit spitalor për vitin 2024”.
- VKA nr. 11, datë 31.05.2024, “Për miratimin e një ndryshimi në Udhëzimin për mënyrën e pagesës dhe shpërblimit për punonjësit e Qendrave Shëndetësore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor”.
- VKA nr.12, datë 07.06.2024, “Për një ndryshim në Vendimin e Këshillit Administrativ nr.3 datë 28.02.2024 “Për krijimin e Komisionit teknik të Listës së Barnave të Rimbursueshme për vitin 2024”.
- VKA nr.13, datë 04.07.2024, “Për miratimin e propozimit të Projekt-Vendimit të Këshillit të Ministrave, për një ndryshim në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.61 datë 03.02.2017 “Për miratimin e paketave të pajisjeve mjekësore të rimbursueshme”, të ndryshuar.
- VKA nr.14, datë 04.07.2024, “Për miratimin e propozimit të Projekt-Vendimit të Këshillit të Ministrave, për disa ndryshime në vendimin nr. 308, datë 21.05.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në shërbimin spitalor”, të ndryshuar.
- VKA nr.15, datë 04.07.2024, “Për miratimin e kontratës me dhënësin e shërbimeve në kujdesin shëndetësor spitalor, Qendrës Spitalore Rajonale Berat, për vitin 2024”.
- VKA nr.16 datë 04.07.2024, “Për miratimin e propozimit të Projekt-Vendimit të Këshillit të Ministrave, për një ndryshim në Vendimin nr.737, datë 5.11.2014 të Këshillit të Ministrave, “Për financimin e shërbimeve shëndetësore publike të kujdesit shëndetësor parësor nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor“ të ndryshuar.
- VKA nr.17, datë 04.07.2024, “Për miratimin e propozimit të Projekt-Vendimit të Këshillit të

Ministrave, për disa ndryshime në Vendimin nr.124, datë 05.03.2014 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Statutit të Fondit të Sigurimit të detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

- VKA nr.18, datë 11.07.2024, “Për miratimin e Listës së Barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe masën e mbulimit të çmimit të tyre”.
- VKA nr.19, datë 31.07.2024, “Për miratimin e kontratave me subjektet farmaceutike”.
- VKA nr.20, datë 31.07.2024, “Për emërimin e Z. Spartak Zekja në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor”.
- VKA nr.21, datë 30.08.2024, “Për një ndryshim në Vendimin nr.1, datë 31.01.2024 të Këshillit Administrativ, “Për miratimin e buxhetit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për vitin 2024””.
- VKA nr.22, datë 30.08.2024, “Për propozimin për një ndryshim në Vendimin nr. 26, datë 17.01.2024, të Këshillit të Ministrave, “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor për vitin 2024”.
- VKA nr.23, datë 30.08.2024, “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2025 - 2027 të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor”.
- VKA nr.24, datë 09.09.2024, “Për kriteret që duhet të plotësojnë farmacitë dhe agjencitë farmaceutike për lidhjen e kontratës me Fondin dhe procedurat për lidhjen e kontratës”.
- VKA nr.25, datë 09.09.2024, “Për kriteret që duhet të plotësojnë importuesit/shpërndarësit farmaceutik për lidhjen e kontratës me Fondin dhe procedurat për lidhjen e kontratës”.
- VKA nr.26, datë 31.10.2024, “Për disa ndryshime në Rregulloren e burimeve njerëzore të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në kapitullin “Paga”.
- VKA nr.27, datë 31.10.2024, “Për rishpërndarje të buxhetit dhe shpërndarje nga rezerva e buxhetit të shërbimit spitalor për vitin 2024”.
- VKA nr.28, datë 31.10.2024, “Për propozimin e ndryshimit të transfertës së buxhetit midis programeve, brenda buxhetit të miratuar të Fondit për vitin 2024”.
- VKA nr.29, datë 31.10.2024, “Për ngritjen e Komisionit teknik të hartimit të Listës së Pajisjeve Mjekësore të Rimbursuara për vitin 2025”.
- VKA nr.30, datë 04.12.2024, “Për një ndryshim në Vendimin nr.1, datë 31.01.2024 të Këshillit Administrativ, “Për miratimin e buxhetit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për vitin 2024”, të ndryshuar”.
- VKA nr.31, datë 04.12.2024, “Për shpërndarje nga rezerva e buxhetit të shërbimit spitalor për vitin 2024”.
- VKA nr.32, datë 04.12.2024, “Për rregullat dhe mënyrën e organizimit të Regjistrimit Kombëtar të Paketave, monitorimin dhe financimin e paketave shëndetësore nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Institucionet Shëndetësore të kontraktuara dhe Qendrat e ofrimit të hemodializës nga kontrata e partneritetit publik/privat”.
- VKA nr.33, datë 04.12.2024, “Për miratimin e kontratave me dhënësit e shërbimeve në kujdesin shëndetësor parësor dhe spitalor për vitin 2025”.
- VKA nr.34, datë 30.12.2024, “Për rishpërndarje nga rezerva e buxhetit të shërbimit spitalor për vitin 2024”.
- VKA nr.35, datë 30.12.2024, “Për një ndryshim në Vendimin nr.1, datë 31.01.2024 të Këshillit Administrativ, “Për miratimin e buxhetit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për vitin 2024”, të ndryshuar”.
- VKA nr.36, datë 30.12.2024,” Për disa ndryshime në Rregulloren e burimeve njerëzore të

Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në kapitullin “Paga”.

3. Zbatimi i Skemës së Sigurimeve Shëndetësore

3.1 Panoramë e përgjithshme e skemës së sigurimeve shëndetësore

Skema e sigurimeve shëndetësore është ngritur dhe funksionon që nga viti 1995. Ajo rregullohet me ligjin nr. 10383, datë 24.02.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Që nga krijimi mbuloi një listë bazë barnash të rimbursueshme, si dhe pagesën e mjekut të familjes në sistemin publik. Skema evoluoi gradualisht, me zgjerimin e gamës së shërbimeve të mbuluara, duke kaluar nga financimi i padiferencuar, në pagesa për paketa shërbimesh shëndetësore. Modeli i skemës së sigurimeve shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, është një model mix (Bismark dhe Beveridge), i cili bazohet në kontributet e detyrueshme dhe ato vullnetare, si dhe në financimin nga buxheti i shtetit.

Popullsia ekonomikisht aktive paguan sigurime shëndetësore, ndërsa fondet e buxhetit të shtetit (që vijnë nga taksimi i përgjithshëm), mbulojnë popullatën joaktive dhe kategoritë në nevojë, duke i dhënë kështu skemës qasje solidare. Skema e sigurimeve shëndetësore bazohet në modelin e pagesit të vetëm, që është FSDKSH, i cili e menaxhon atë në përputhje me politikat kombëtare të kujdesit shëndetësor.

FSDKSH përdor metodat e pagesës së shërbimeve shëndetësore, për të influencuar në rritjen e aksesit, parandalimin dhe përmirësimin e treguesve shëndetësorë të popullatës. Mekanizmi i implementimit të skemës së sigurimeve shoqërore janë kontratat vjetore me dhënësit publikë dhe privatë të shërbimeve shëndetësore për ofrimin e paketave të shërbimeve shëndetësore.

Sigurimi i detyrueshëm financon paketat e shërbimeve të sigurimit të detyrueshëm, ku përfshihen:

- vizitat, ekzaminimet dhe trajtimet mjekësore në qendrat e kujdesit shëndetësor parësor publik dhe në spitalet publike;
- vizitat, ekzaminimet dhe trajtimet mjekësore në dhënës privat të kujdesit parësor dhe spitale private;
- barnat, produktet dhe trajtimet mjekësore nga dhënës të kontraktuar shërbimesh shëndetësore.

3.2 Parimet e skemës së sigurimeve shëndetësore në Shqipëri

Skema e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor synon mbulimin shëndetësor të popullatës, përmes këtyre parimeve:

- Sigurimit të detyrueshëm dhe vullnetar;
- Solidaritetit;
- Aksesit të barabartë për të gjithë shtetasit;
- Efikasitetit dhe cilësisë në financimin e shërbimeve shëndetësore;
- Zgjedhjes së lirë të mjekut;
- Partneritetit (blerës-dhënës-përfitues).

3.3 Kategoritë përfituese nga skema e sigurimeve

Çdo shtetas që paguan kontribut për sigurim shëndetësor, ose për të cilin paguan shteti, është i siguruar dhe përfiton nga skema e sigurimeve shëndetësore. Personat e siguruar në skemën e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor regjistrohen në regjistrin elektronik të të siguruarve, i krijuar dhe i menaxhuar nga FSDKSH. Identifikimi i personave të siguruar bëhet me anë të dokumentit të identifikimit, nëpërmjet shërbimit të regjistrit elektronik ose portalit e-Albania. Regjistri i të siguruarve përmban të dhëna lidhur me kategoritë e personit të siguruar ekonomisht aktiv, jo aktiv ose me sigurim vullnetar, si dhe kohëzgjatjen e sigurimit. Për shërbime të ndryshme shëndetësore që mbulohen nga skema e sigurimit shëndetësor, personat e siguruar, mund të bashkëpaguajnë një pjesë të çmimit.

3.4 Sigurimi vullnetar

Personat kanë të drejtë të bashkohen vullnetarisht me skemën e detyrueshme. Personat e siguruar vullnetarisht kanë të njëjtat të drejta dhe detyrime si personat, subjekte të sigurimit të detyruar, nëse përmbushin kushtin e periudhës pritëse 6 mujore nga data e regjistrimit dhe e derdhjes së kontributit deri në datën e lindjes së të drejtës për të përfituar. Pas përfundimit të periudhës së sigurimit të detyrueshëm ose sigurimit vullnetar, personat që nuk përfshihen në kategoritë, për të cilat kontribuon shteti, duhet të regjistrohen pranë FSDKSH për sigurim vullnetar brenda 3 muajve. Për regjistrime të vonuara, periudha pritëse do të jetë 1 vit nga data e regjistrimit dhe e derdhjes së kontributit vjetor. Sigurimi shëndetësor vullnetar paguhet nga vetë personi, i cili lidh me Fondin kontratë sigurimi shëndetësor vullnetar.

3.5 Baza për llogaritjen e kontributeve

Baza për llogaritjen e kontributit është paga bruto e personit të siguruar, ndërsa baza për llogaritjen e kontributit për punonjësit e vetëpunësuar është dyfishi i pagës minimale për efekt të llogaritjes së kontributeve. Paga minimale, për efekt të llogaritjes së kontributeve për të vetëpunësuarit në qytet dhe në fshat, përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Për sigurimet shëndetësore vullnetare baza e llogaritjes së kontributit është dyfishi i pagës minimale, për efekt të llogaritjes së kontributeve.

Kontributi i shtetit për personat ekonomikisht joaktivë bazohet në konsumin për frymë të shërbimit shëndetësor, indeksuar me koeficientin e inflacionit. Konsumi për frymë për shërbimin shëndetësor përcaktohet nga FSDKSH dhe miratohet nga Kuvendi, së bashku me miratimin e buxhetit vjetor.

Personat e punësuar me profesion në fushën e teknologjisë së informacionit (IT) dhe të regjistruar në subjektet me aktivitet kryesor në fushën e teknologjisë së informacionit, të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre sipas ligjit nr. 58/2022, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e parqeve teknologjike dhe shkencore”, të miratuara sipas legjislacionit në fuqi për këtë kategori, paguajnë kontributet e sigurimeve shëndetësore në nivelin e pagës minimale mujore në shkallë vendi, me miratimin paraprak të punëmarrësit, të evidentuar në kontratën e punës, pavarësisht pagës bruto të deklaruar.

3.6 Masa e kontributit

Masa e kontributit të sigurimit të detyruar shëndetësor është 3.4 për qind e bazës për llogaritjen e kontributeve sipas pikave 1, 3, 4 dhe 5 të nenit 7, të ligjit nr. 10383, datë 24.02.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Për të punësuarit, kontributet paguhet, në masën 50% (për qind) nga punëdhënësi dhe në masën 50% (për qind) nga i punësuari.

4. Burimet Financiare

4.1 Burimet financiare të skemës gjatë vitit 2024

Buxheti fillestar i Fondit:

Buxheti i miratuar me Ligjin nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, për Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, është 58,052 milionë lekë. Fondi për rimbursimin e medikamenteve nuk e tejkalon tavanin prej 12,000 milionë lekësh. Fondi për shërbimin spitalor detajohet dhe përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave.

Me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 26, datë 17.01.2024, “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor për vitin 2024”, është detajuar buxheti për shërbimin spitalor.

Ndryshimet e buxhetit fillestar:

Me shkresë të Ministrisë së Financave nr. 10079/1, datë 29.07.2024, janë akorduar transfertë nga Buxheti i Shtetit 1,244 milionë lekë, përkatësisht 544 milionë lekë në shërbimin spitalor dhe 700 milionë lekë në shërbimin parësor, për përballimin e efekteve të rritjes së pagave për vitin 2024.

Me shkresë të Ministrisë së Financave nr. 14419/1, datë 1.11.2024, është akorduar shtesa e dytë për përballimin e efektit të rritjes së pagave në shërbimin spitalor, prej 434,801 mijë lekë pas kërkesës sonë pranë Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Shëndetësisë e Mbrojtjes Sociale, mbi efektet e konstatuara financiare lidhur me këtë shërbim, për periudhën Korrik -Tetor 2024.

Me Aktin Normativ nr. 5, datë 19.12.2024, ”Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr.97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, të ndryshuar”, është realizuar kalimi i vlerës prej 335 milionë lekë të transfertës së buxhetit, nga programi i shërbimit parësor në programin e shërbimit spitalor.

Bazuar në këto akte, si dhe në vendimet e Këshillit Administrativ, buxheti i Fondit ka ndryshuar si më poshtë:

(Në mijë lekë)

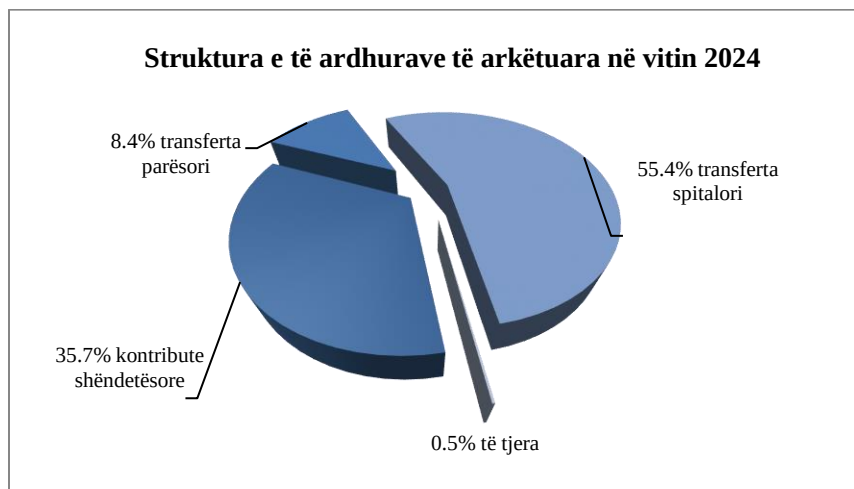
FONDI I SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR PERMBLEDHES E E NDYRSHIMEVE BUXHETORE 2024

Buxheti për vitin 2024 (000 lekë)	Ligji 97/2023	VKM 26 (17.1.2024)	Buxhet fillestar (VKA nr.1 (31.01.2024)	Buxhet fillestar behet (VKA nr.1 (31.01.2024)	NDRYSHIM VKA 2 (31.01.2024) (paketat)	shkresa e MFE 10079/1, (29/07/2024)	AN 3 (28.08.2024)	Buxhet behet pas VKA 12	VKA 21 (30.08.2024)	Buxheti pas VKA 21	VKM 647 (16.10.2024)	shkresa e MFE 14419/1 (1.11.2024) shtese efekte pagash	VKA 27 (31.10.2024)	VKA 31 (4.12.2024)	AN 5 (19.12.2024)	VKA 35 (30.12.2024)	Buxheti perfundimtar
I. Te ardhurat gjithsej	58,051,790	0	0	58,051,790	0	1,244,000	0	59,295,790	0	59,295,790	0	434,801	0	0	0	0	59,730,591
1. Kontributi i sigurimeve shendetesore	20,481,000		-100,000	20,381,000			610,000			20,991,000							20,991,000
2. Kontribut i Buxhetit te Shtetit	37,570,790	0	0	37,570,790	0	1,244,000	-610,000	0	0	38,204,790	0	434,801	0	0		0	38,639,591
paresor	5,278,000			5,278,000		700,000	-610,000			5,368,000					-335,000		5,033,000
spitalor	32,292,790			32,292,790		544,000				32,836,790		434,801			335,000		33,606,591
3. Te ardhura te tjera			100,000	100,000						100,000							100,000
II. Shpenzimet gjithsej	58,051,790	0	0	58,051,790	0	1,244,000	0	59,295,790	0	59,295,790	0	434,801	0	0	0	0	59,730,591
1. Rimbursimi i barnave e pajisjeve	12,000,000	0	200,000	12,200,000	0	0	0	12,200,000	0	12,200,000	0	0	0	0		0	12,200,000
Likuidimi i rimbursimit te barnave	12,000,000			12,000,000						12,000,000							12,000,000
fisha diabeti (0-25) vjec			200,000	200,000						200,000							200,000
2. Shpenzime per kujdesin shendetesor paresor	0	0	11,964,000	11,964,000	0	700,000	0	12,664,000	0	12,664,000	0	0	0	0		0	12,664,000
Financimi i QSH (shpemdare + rezerve)			11,087,910	11,087,910		700,000				11,787,910							11,787,910
Kontrolli baze			876,090	876,090						876,090							876,090
3. Shpenzimet administrative			1,445,000	1,445,000					-215,000	1,230,000							1,230,000
4. Investime			150,000	150,000					-120,000	30,000							30,000
5. Financimi per shërbimin spitalor	32,292,790	0	0	32,292,790	0	544,000	0	32,836,790	0	32,836,790	0	434,801	0	0		335,000	33,606,591
spitalet		23,512,610		23,512,610	1,574,274					25,086,884	1,410,651		41,805	483,259		335,000	27,357,599
rezerve spitalet	32,292,790	-31,302,849		989,941		544,000				1,533,941	-1,403,476	434,801	-41,805	-483,259			40,202
paketat		3,204,135		3,204,135	-1,574,274					1,629,861	-7,175						1,622,686
rimbursime VKM		30,000		30,000						30,000							30,000
transferta per individe (mjeke specialiste)		30,000		30,000						30,000							30,000
pagesa e sherbimeve PPP	0	4,526,104	0	4,526,104	0	0	0	0	0	4,526,104	0		0	0		0	4,526,104
pagesa e sherb. PPP (dialize)		920,000		920,000						920,000							920,000
pagesa e sherb. PPP (Sterilizim)		1,756,104		1,756,104						1,756,104							1,756,104
pagese spitalet PPP laboratore		1,850,000		1,850,000						1,850,000							1,850,000
6. Rezerve e padetajuar	13,759,000		-13,759,000	0					335,000	335,000						-335,000	0

TË ARDHURAT

Të ardhurat e arkëtuara (cash) u realizuan në vlerën 60,266 milionë lekë, ose 100.9% e planifikimit, realizuar me tejkalim nga plani për vlerën 535 milionë lekë.

Në strukturën e të ardhurave, peshën specifike më të madhe e zënë transfertat e buxhetit të shtetit me 63.8% (nga të cilat 55.4% për shërbimin spitalor dhe 8.4% për shërbimin parësor), ndjekur nga të ardhurat e kontributeve të sigurimeve shëndetësore me 35.7 %. Të ardhurat nga burime të tjera zënë një peshë specifike të vogël prej 0.5%.



Realizimi i të ardhurave

(Në milionë lekë)

	ZËRAT E TË ARDHURAVE	Viti 2023	Viti 2024			Realizimi i cash /planit viti 2024		Realizimi i konst /planit viti 2024		Ndryshimi konstatuar (viti 2024-viti 2023)		Peshë spec. cashi v.2024
		Fakti - konstatuara	Plani	Fakti - cash	Fakti - konstatuara	vlerë	%	vlerë	%	vlerë	%	
	TË ARDHURAT GJITHSEJ	56,088	59,731	60,266	59,999	535	100.9%	268	100.4%	3,911	107.0%	100. %
a	Kontributet e sigurimit shëndetësor	18,946	20,991	21,506	21,239	515	102.5%	248	101.2%	2,293	112.1%	35.7%
	nga DPT në BSH	18,886	20,931	21,440	21,173	509	102.4%	242	101.2%	2,287	112.1%	35.6%
	nga ISSH (fermerët)	60	60	66	66	6	110.0%	6	110.0%	6	110.0%	0.1%
b	Transferta e buxhetit të shtetit, nga këto	37,043	38,640	38,418	38,418	-222	99.4%	-222	99.4%	1,375	103.7%	63.8%
	Transfertë për shërbimin parësor	6,414	5,033	5,033	5,033	0	100.0%	0	100.0%	-1,381	78.5%	8.4%
	Transfertë për shërbimin spitalor	30,629	33,607	33,385	33,385	-222	99.3%	-222	99.3%	2,756	109.0%	55.4%
	Spitalet	23,914	26,401	26,179	26,179	-222	99.2%	-222	99.2%	2,265	109.5%	43.4%
	Tërheqje nga FSDKSH për paketat, bonus, VKM, PPP	6,715	7,206	7,206	7,206	0	100.0%	0	100.0%	491	107.3%	12.0%
c	Të ardhura të tjera	99	100	342	342	242	342.0%	242	342.0%	243	345.5%	0.5%

4.2 Të ardhurat nga kontributi i sigurimeve shëndetësore (DPT, ISSH)

Kontributet e sigurimit shëndetësor në total ishin programuar 20,991 milionë lekë. Në fakt u transferuan në llogaritë e Fondit 21,506 milionë lekë, ose në masën 102.5%, me tejkalim prej 515 milionë lekë, përkatësisht sipas organeve përgjegjëse të mbledhjes së kontributeve:

- Nga organet tatimore (DPT) nga 20,931 milionë lekë kontribute të programuara, u transferuan 21,440 milionë lekë, ose në masën 102.4%, me tejkalim 509 milionë lekë.
- Nga organet e sigurimeve shoqërore (ISSH) nga 60 milionë lekë kontribute të fermerëve të programuara, u transferuan 66 milionë lekë, ose 110%, me tejkalim 6 milionë lekë.

4.3 Transferta nga buxheti i shtetit

Transfertat nga buxheti i shtetit në total nga 38,640 milionë lekë të programuara u realizuan 38,418 milionë lekë, ose në masën 99.4%, me mosrealizim 222 milionë lekë, përkatësisht:

- *Transfertat për shërbimin parësor* u realizuan në vlerën 5,033 milionë lekë, ose në masën 100% të planifikimit. Me transfertën e shërbimit parësor mbulohen financimi i Qendrave Shëndetësore, si dhe pagesat e kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 35-70 vjeç.
- *Transfertat për shërbimin spitalor* (përfshirë edhe spitalet publike) nga 33,607 milionë lekë të programuara u realizuan në vlerën 33,385 milionë lekë, ose në masën 99.3% e programimit, me mosrealizim 222 milionë lekë.

Nga transfertat totale, vlera prej 26,179 milionë lekë është transferuar për spitalet publike dhe vlera prej 7,206 milionë lekë është tërhequr nga Fondi për pagesa të shpenzimeve që përballohen nga programi i shërbimit spitalor.

Tërheqja e Fondit nga llogaria e thesarit përcaktuar për shërbimin spitalor bëhet, sipas përcaktimeve në VKM për:

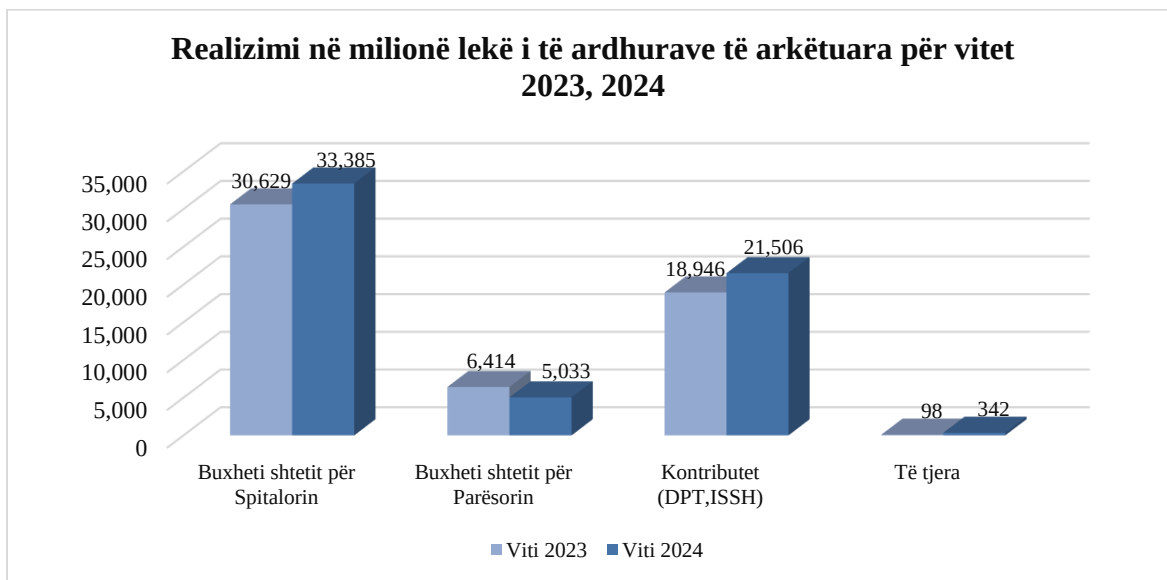
- financimin e shërbimit spitalor në spitalin rajonal Durrës dhe “Memorial” Fier;
- financimin e paketave shëndetësore në institucionet jopublike;
- financimin e kontratave konçesionare të lidhura nga autoriteti qendror (Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale);
- pagesat për kujdes shëndetësor në institucione jopublike, brenda e jashtë vendit, sipas miratimit, rast pas rasti, me vendim të Këshillit të Ministrave;
- pagesa të bonusit për mjekë specialistë që kontraktohen për ofrimin e shërbimeve të munguara në spitalet rajonale e bashkiake.

4.4 Të ardhura të tjera

Nga burime të tjera (interesat e depozitave, të investimeve në bono thesari, dëmet ekonomike, etj), u arkëtuan të ardhura në vlerën 342 milionë lekë, në masën 342% e planifikimit, me tejkalim 242 milionë lekë. Nga shuma e të ardhurave të tjera, rreth 92 milionë lekë u arkëtuan interesa

nga investimi i fondit rezervë në bono thesari, si dhe rreth 224 milionë lekë u depozituan për pjesëmarrjen në strukturën globale të qasjes në vaksinat COVID-19.

Grafiku krahasues për të ardhurat e arkëtuara për vitet 2023, 2024, paraqitet si vijon:

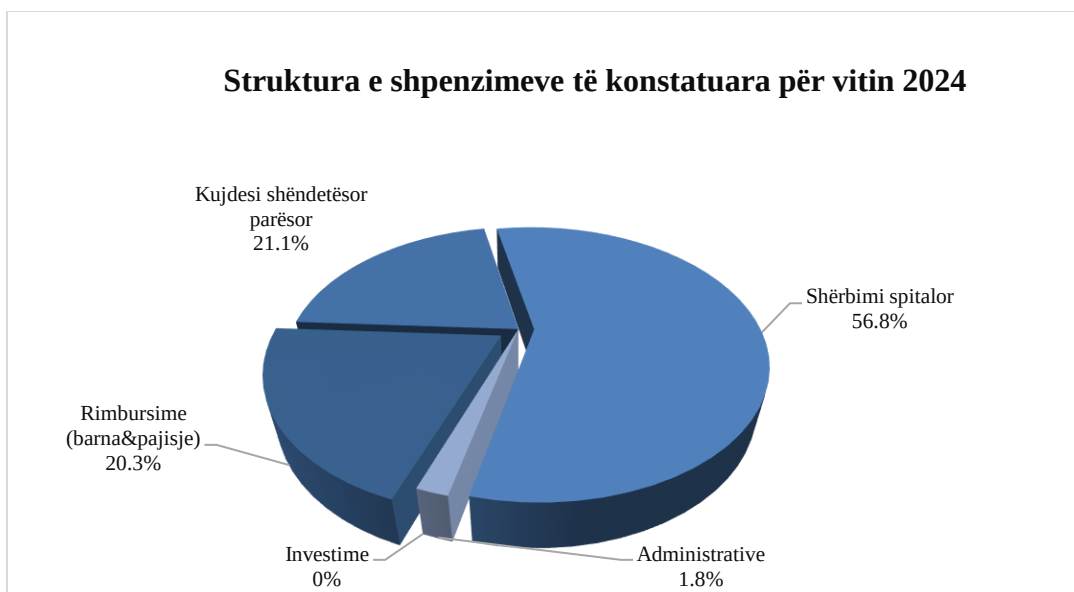


5. Financimi i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor

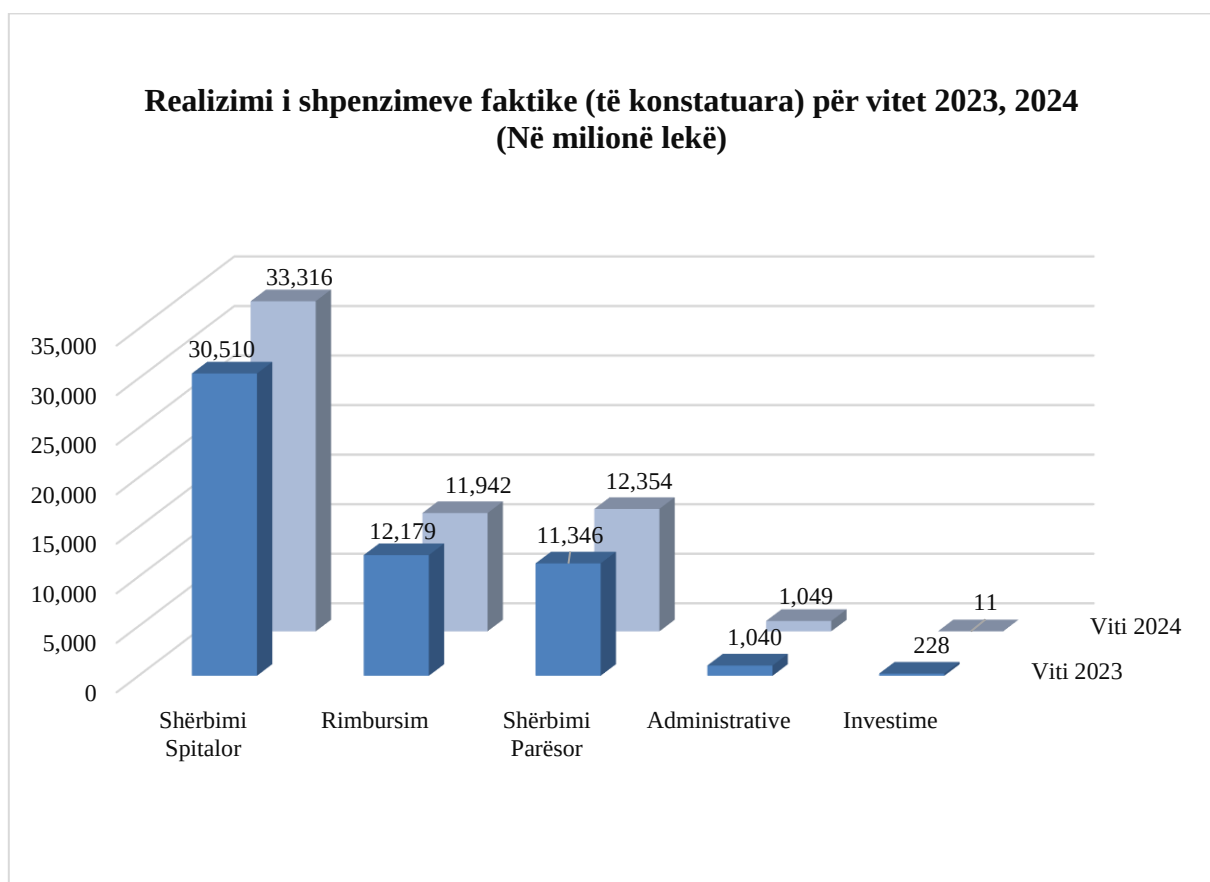
Gjatë vitit 2024, shpenzimet totale të paguara (përfshirë shpenzimet e spitaleve publike) arritën në vlerën 58,781 milionë lekë nga 59,731 milionë lekë të programuara, ose 98.4% e planifikimit. Shpenzimet e paguara u realizuan më pak 950 milionë lekë. Theksojmë se në fillim të vitit buxhetor u paguan të gjitha detyrimet nga viti 2023.

Gjatë vitit 2024, shpenzimet faktike të konstatuara arritën në vlerën 58,672 milionë lekë.

Në strukturën e shpenzimeve faktike, peshën specifike më të madhe e zënë shpenzimet e shërbimit spitalor me 56.8%, ndjekur nga shpenzimet e kujdesit parësor (*financimi i QSH e kontrolli mjekësor bazë*) me 21.1%, shpenzimet për rimbursimin e barnave e pajisjeve me 20.3%, shpenzimet administrative (*pagat e shpërblimet, sigurimet shoqërore-shëndetësore, mallra e shërbime*) me 1.8 % dhe së fundi investimet me një peshë jo të konsiderueshme.



Grafiku krahasues për shpenzimet e paguara, për vitet 2023 dhe 2024, paraqitet si vijon:



Realizimi i shpenzimeve

(Në milionë lekë)

ZËRAT E SHPENZIMEVE	Viti 2023	Viti 2024			Realizimi i cash /planit viti 2024		Realizimi i konst /planit viti 2024		Ndryshimi konstatuar (viti 2024-viti 2023)		Peshë spec. konsta vit.2024
	Fakti-konstatuar	Plani	Fakti-cash	Fakti-konstatuar	në vlerë	në %	vlerë	%	në vlerë	në %	
SHPENZIMET GJITHSEJ	55,303	59,731	58,781	58,672	-950	98.4%	-1,059	98.2%	3,369	106.1%	100.0%
1. Rimbursimi i barnave e pajisjeve	12,179	12,200	12,136	11,942	-64	99.5%	-258	97.9%	-237	98.1%	20.3%
2. Shpenzime për kujdesin shëndetësor parësor	11,346	12,664	12,352	12,354	-312	97.5%	-310	97.6%	1,008	108.9%	21.1%
Financimi i QSH	10,470	11,788	11,476	11,478	-312	97.4%	-310	97.4%	1,008	109.6%	19.6%
Kontrolli bazë	876	876	876	876	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	1.5%
3. Shpenzimet administrative	1,040	1,230	1,058	1,049	-172	86.0%	-181	85.3%	9	100.8%	1.8%
4. Investime	228	30	11	11	-19	35.7%	-19	36.7%	-217	4.8%	0.02%
5.Financime për shërbimin spitalor	30,510	33,607	33,224	33,316	-383	98.9%	-291	99.1%	2,806	109.2%	56.8%
Financime për spitalet publike	26,313	29,248	29,026	29,026	-222	99.2%	-222	99.2%	2,713	110.3%	49.5%
Shpenzime për paketat spitalore në privat	1,539	1,623	1,534	1,547	-89	94.5%	-76	95.3%	8	100.5%	2.6%
Shpenzime për trajtimin e pacientit me VKM	11	30	10	10	-20	33.3%	-20	33.3%	-1	94.9%	0.0%
Shpenzimet –Bonusi për mjekët specialistë	13	30	4	4	-26	13.3%	-26	13.3%	-9	30.1%	0.0%
Shpenzimet- PPP (dializa,sterilizimi)	2,634	2,676	2,650	2,729	-26	99.0%	53	102.0%	95	103.6%	4.7%

Gjatë vitit 2024, u konstatuan shpenzime rreth 58,672 milionë lekë, ose 98.2% e programimit, më pak për vlerën 1,059 milionë lekë.

5.1 Financimi i listës së barnave të rimbursueshme dhe pajisjeve

- Plani vjetor: 12,200 milionë lekë,
- Pagesat vjetore: 12,136 milionë lekë (ose 99.5% e planit vjetor).
- Shpenzuar më pak nga plani rreth 64 milionë lekë.

Në shumën totale të pagesave përfshihen edhe likuidimet e detyrimeve nga viti i mëparshëm. Pavarësisht shtimit të barnave në listë, faktorë të tjerë si ndryshimi i kurseve të këmbimit dhe ulja e çmimeve kanë ndikuar pozitivisht në efektet financiare lidhur me rimbursimin e barnave të listës.

Në fund të vitit, nga listëtreguesit e pranuar për rimbursimin e barnave & pajisjeve mbetën papaguar rreth 604 milionë lekë. Krahësuar me vitin e mëparshëm, detyrimet e fundit të vitit u pakësuan me 24.1%, ose rreth 192 milionë lekë.

5.2 Financimi i shërbimit të kujdesit shëndetësor parësor

Shpenzimet e shërbimit të kujdesit shëndetësor parësor (financimi i QSH dhe kontrolli mjekësor bazë) arritën në vlerën 12,354 milionë lekë, ose në masën 97.6%, më pak nga plani 310 milionë lekë.

- Shpenzimet për financimin e QSH arritën në shumën 11,478 milionë lekë (përfshirë edhe financimi në natyrë me shtypshkrime). Janë financuar qendrat shëndetësore për aktivitetin e tyre vjetor, përfshirë financimin shtesë për qendrat që ofrojnë shërbim të pandërprerë gjatë sezonit veror, si dhe paketën e barnave e materialeve të mjekimit për qendrat shëndetësore që bllokohen gjatë dimrit. U financuan qendrat shëndetësore për përballimin e efektit të rritjes së pagave për mjekët, teknikët e shkencave mjekësore, në zbatim të politikave qeveritare për rritjen e pagave në sistemin shëndetësor publik. Këtë vit buxhetor ka rritje të pagës me mesatarisht 20 mijë lekë të reja për mjekët e përgjithshëm e të famijes, si dhe me rreth 15 mijë lekë teknikët e shkencave mjekësore. Gjithashtu, ndryshim rrënjësor pësoi struktura e pagës së mjekëve të përgjithshëm e të famijes, duke u unifikuar me strukturën e pagës së mjekëve të tjerë në sistemin shëndetësor publik.

- Shpenzimet për shërbimin e kontrollit bazë shëndetësor të popullsisë nga 35-70 vjeç arritën në vlerën 876 milionë lekë, në masën 100% të planit.

Gjatë periudhës gjithë vjetore u realizuan gjithsej 461,376 raste nga projeksioni prej 475,000 raste.

5.3 Financimi i shërbimit spitalor

Buxheti për shërbimin spitalor parashikohet në ligjin e buxhetit dhe miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Për vitin 2024, spitalet u financuan në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 26, datë 17.01.2024, “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor për vitin 2024”, i ndryshuar.

Shpenzimet gjithë vjetore për shërbimet spitalore arritën në vlerën 33,316 milionë lekë, ose në masën 99.1%, ose më pak nga plani 291 milionë lekë.

Gjatë vitit buxhetor për shpenzimet spitalore u kryen pagesa në vlerën 33,224 milionë lekë, nga 33,607 milionë lekë të planifikuara, ose 98.9%, shpenzuar më pak 383 milionë lekë. Në shumën totale të pagesës përshihen edhe likujdimet e detyrimeve nga viti i mëparshëm.

Financimi i Spitaleve Publike

Financimi vjetor i spitaleve publike ka arritur në shumën 29,026 milionë lekë nga 29,248 milionë lekë të planifikuara, ose 99.2% e planit. Shpenzuar më pak nga plani 222 milionë lekë. Nëpërmjet financimit janë përballuar nevojat e spitaleve në paga, sigurime shoqërore-shëndetësore, mallra e shërbime. Gjithashtu, në vlerën e mësipërme përfshihet financimi i paketave spitalore të miratuara me VKM në spitalet publike, si dhe financimi i kontratës koncesionare të laboratorëve.

U financuan spitalet për përballimin e efektit të rritjes së pagave në zbatim të politikave qeveritare për rritjen e pagave në sistemin shëndetësor spitalor.

Financimi i paketave spitalore në institucionet jopublike

Për paketat spitalore në dhënës privat të shërbimit (spitalet jopublike) shpenzimet arritën në shumën 1,547 milionë lekë, ose 95.3% e planit vjetor, më pak nga plani 76 milionë lekë. Nga këto shpenzime, në fund të vitit mbeti palikujduar shuma 149 milionë lekë.

Gjatë vitit buxhetor për paketat spitalore u kryen pagesa në shumën 1,534 milionë lekë, (përfshirë pagesat e detyrimeve nga viti i mëparshëm), nga 1,623 milionë lekë të planifikuara, ose u realizuan 94.5%, më pak 89 milionë lekë.

Financimi i paketave në spitalet jopublike është realizuar nga Drejtoria e Shërbimeve Spitalore Universitare dhe nga Drejtoritë Rajonale Berat, Durrës, Gjirokastrë, Fier, për paketën e dializës.

Financimi sipas vendimeve rast pas rasti të Këshillit të Ministrave

Për trajtimet spitalore miratuar rast pas rasti me VKM shpenzimet e paguara arritën 10 milionë lekë, nga 30 milionë lekë të planifikuara, ose 33.3%, më pak nga plani 20 milionë lekë. Pagesa bëhet nga drejtoria qendrore vetëm për rastet që kanë paraqitur dokumentacionin përkatës të trajtimit spitalor nga VKM-të e miratuara.

Financimi i bonusit të mjekëve specialistë

Për financimin e bonusit për mjekë specialistë të kontraktuar në shërbime të munguara në spitalet rajonale e bashkiake shpenzimet e pranuar për pagesë arritën në shumën 4 milionë lekë nga 30 milionë lekë të planifikuara, ose 13.3% e planit vjetor, më pak nga plani 26 milionë lekë. Nga këto shpenzime, në fund të vitit kanë mbetur palikujduar rreth 0.4 milionë lekë.

Gjatë vitit buxhetor për financimin e mjekëve specialistë të kontraktuar pagesat arritën rreth 4 milionë lekë, (përfshirë pagesat e detyrimeve nga viti i mëparshëm).

Pagesa bëhet nga drejtoritë rajonale për mjekët e kontraktuar që paraqesin dokumentacionin për shërbimin e kryer.

Financimi i shërbimeve PPP në shërbimin spitalor (hemodializë, sterilizim dhe laboratorë)

Për financimin e kontratave PPP në shërbimin spitalor, të nënshkruara nga Autoriteti u shpenzuan:

Për shërbimin e hemodializës dhe sterilizimit, të cilat paguhen nga njësitë e Fondit, kryer përmes partneritetit publik-privat (PPP) shpenzimet e pranuar gjithë vjetore arritën 2,729 milionë lekë, ose 102% e planit vjetor, më tepër 53 milionë lekë. Nga këto shpenzime, në fund të vitit kanë mbetur palikujduar rreth 340 milionë lekë.

Gjatë vitit buxhetor për shërbimin e hemodializës dhe sterilizimit u kryen pagesa në vlerën 2,650 milionë lekë, (përfshirë pagesat e detyrimeve nga viti i mëparshëm) nga 2,676 milionë lekë të planifikuara, ose 99%. U shpenzuan më pak nga plani 26 milionë lekë.

Financimi i hemodializës realizohet nga 5 drejtori rajonale ndërsa financimi i shërbimit të sterilizimit realizohet nga 12 drejtori (11 drejtori rajonale dhe Drejtoria e Shërbimeve Spitalore Universitare).

Për kontratën PPP të laboratorëve, e cila paguhet nga vetë spitalet, rezultojnë të paguara nga këta të fundit vlera prej 1,843 milionë lekë, nga 1,850 milionë lekë të planifikuara.

6. Shpenzime të tjera të Fondit

6.1 Shpenzimet administrative

Shpenzimet administrative (paga e shpërblime, sigurime shoqërore-shëndetësore, mallra e shërbime) arritën 1,049 milionë lekë, ose në masën 85.3% e planifikimit, më pak nga plani 181 milionë lekë.

6.2 Shpenzimet për investime

Shpenzimet për investime u realizuan rreth 11 milionë lekë nga 30 milionë lekë të planifikuara. Realizuar në masën 36.7% e planifikimit, më pak nga plani 19 milionë lekë. Investimet janë realizuar për zërin e ndërtimeve dhe pajisje zyre dhe informatike.

7. Përfitimet e Popullatës

Ligji Nr. 10 383, datë 24.02.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, zgjeroi mundësitë e përfitimit të shërbimeve nga popullata, përmes procesit të kontraktimit nga ana e Fondit, si të shërbimeve publike ashtu edhe të atyre private.

Paketat e shërbimeve të sigurimit të detyrueshëm hartohen duke përcaktuar:

- vizitat, ekzaminimet dhe trajtimet mjekësore në qendrat shëndetësore të kujdesit parësor dhe spitalet publike, të cilat paguhen për këtë shërbim nga sigurimi i detyrueshëm;
- listën e barnave të rimbursueshme, si dhe masën e mbulimit të barnave të saj. Struktura e listës së barnave përcaktohet në bazë të listës së barnave themelore, sipas emërimit INN (principit aktiv të barit), të përcaktuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, si dhe në mbulimin e alternativës më të lirë. Lista e Barnave të Rimbursuara është ndërtuar sipas klasifikimit ATC (Anatomik Terapeutik Kimik) të barnave. Sistemi i klasifikimit ATC të barnave është i hartuar nën rekomandimin dhe kujdesin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Këshillit Nordik të Barnave. Sipas këtij sistem klasifikimi barnat

- ndahen në grupe të ndryshme në përputhje me sistemin sipas organit në të cilin veprojnë, efektin e tyre farmakologjik dhe terapeutik;
- listën e pajisjeve mjekësore, si dhe masën e mbulimit të tyre.

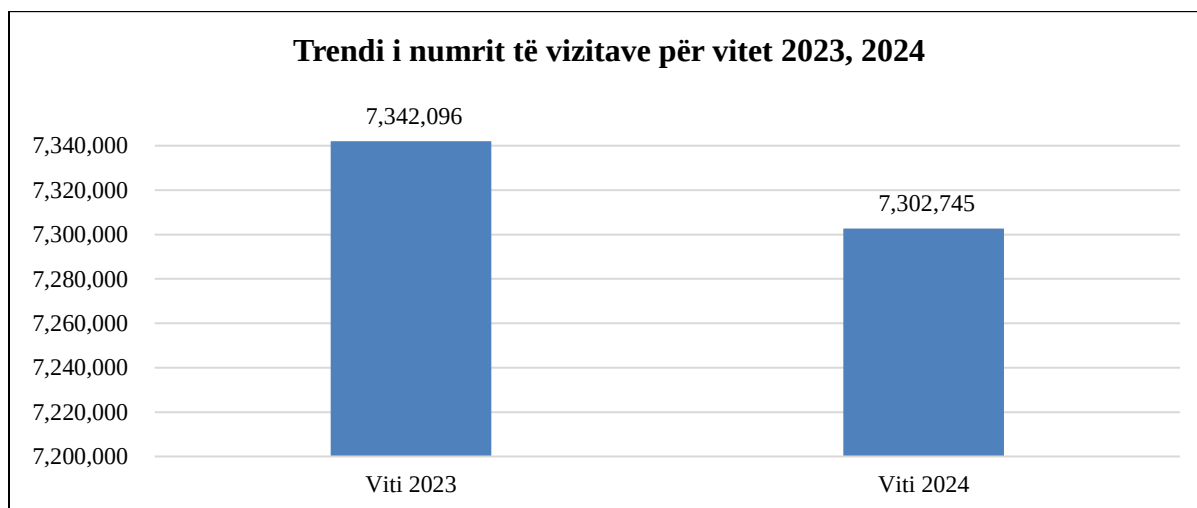
7.1 Paketa e shërbimeve në kujdesin shëndetësor parësor

Paketa e shërbimeve, të cilën Fondi e kontraktonte me Qendrat Shëndetësore, përfshin 7 shërbime:

- Kujdesi në rastet e urgjencës;
- Kujdesi shëndetësor për fëmijët;
- Kujdesi shëndetësor për të rriturit;
- Kujdesi shëndetësor për gratë dhe shëndeti riprodhues;
- Kujdesi shëndetësor për të moshuarit;
- Kujdesi shëndetësor mendor;
- Promocioni dhe edukimi shëndetësor.

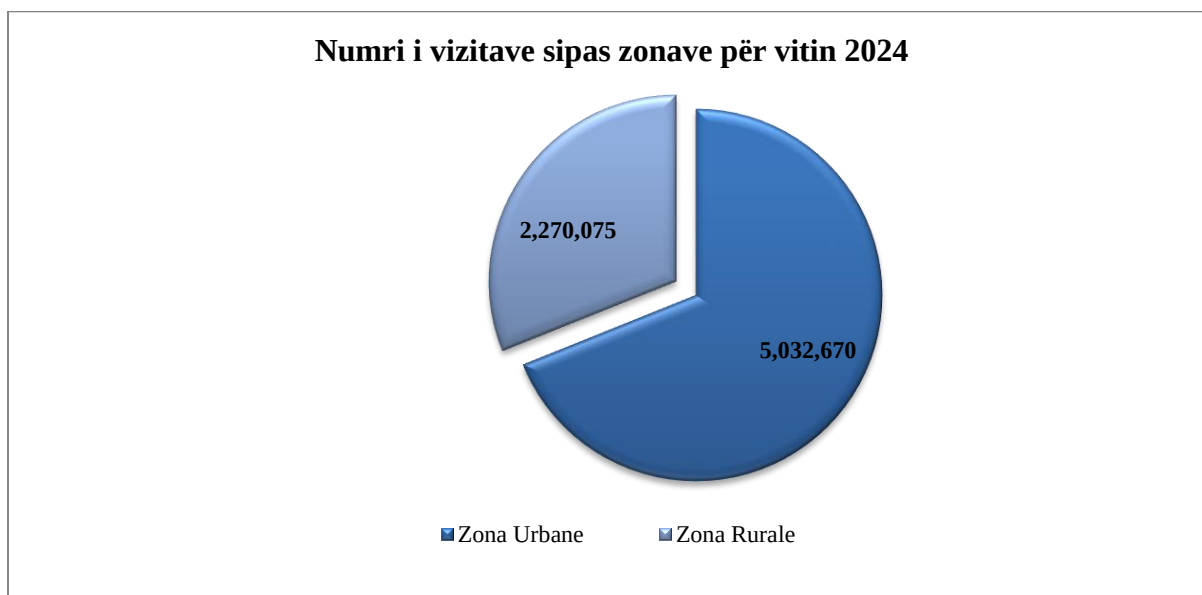
Popullsia e deklaruar nga mjekët e familjes në total është 3,907,055 banorë, ku 2,132,778 banorë janë në zonat urbane dhe 1,774,277 banorë në zonat rurale. Numri i Mjekëve të Përgjithshëm dhe të Familjes që kanë mbuluar me shërbim shëndetësor gjithë territorin e vendit për muajin Dhjetor 2024 është 1,483. Numri i mjekëve specialistë është 316. Numri i infermierëve dhe laborantëve është 6,636, nga të cilët 1,787 janë infermierë të Mjekut të Përgjithshëm dhe të Familjes. Gjatë vitit 2024 nga ana e Qendrave Shëndetësore të Kujdesit Parësor janë kryer 7,302,745 vizita, nga këto 6,432,941 vizita janë kryer nga MP/F dhe 869,804 vizita janë kryer nga Mjekët Specialistë të Qendrave Shëndetësore të Specialiteteve në Tiranë. Përqindja e realizimit në total të numrit të vizitave në rang vendi është 148 % dhe mesatarja ditore e vizitave është rreth 14 vizita/ditë.

➤ Vizitat e realizuara për periudhën 2023, 2024 nga Qendrat Shëndetësore të Kujdesit Parësor.

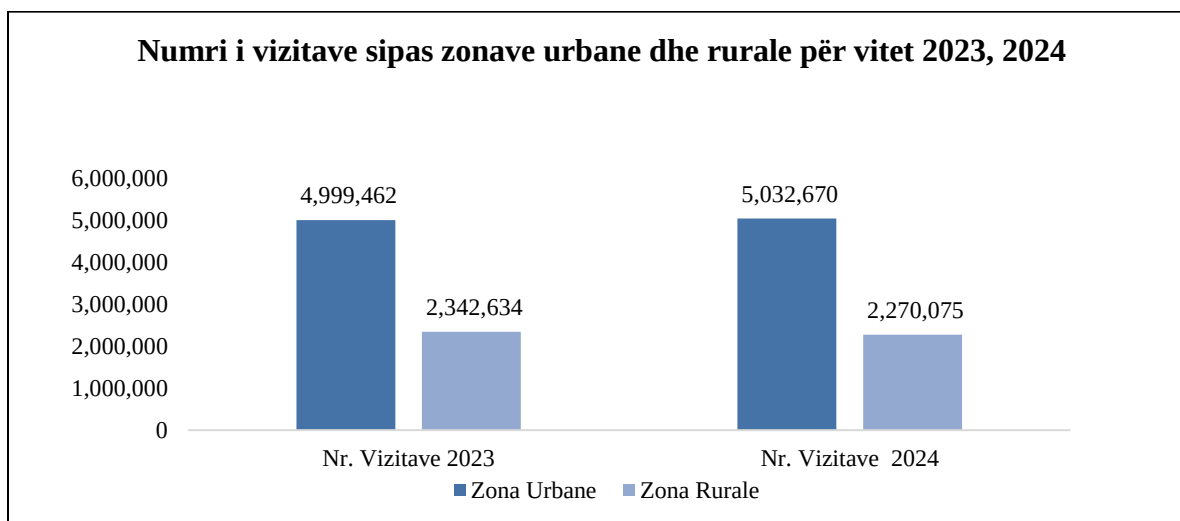


Paraqitja grafike e mësipërme tregon trendin e vizitave të kryera nga qendrat shëndetësore të kujdesit parësor gjatë viteve 2023, 2024. Nga krahasimi i numrit të vizitave me vitin 2023 vihet re një ulje prej 39,351 vizita ose rreth 1% më pak në vitin 2024.

➤ **Vizitat e kryera sipas zonave urbane dhe rurale për vitin 2024**



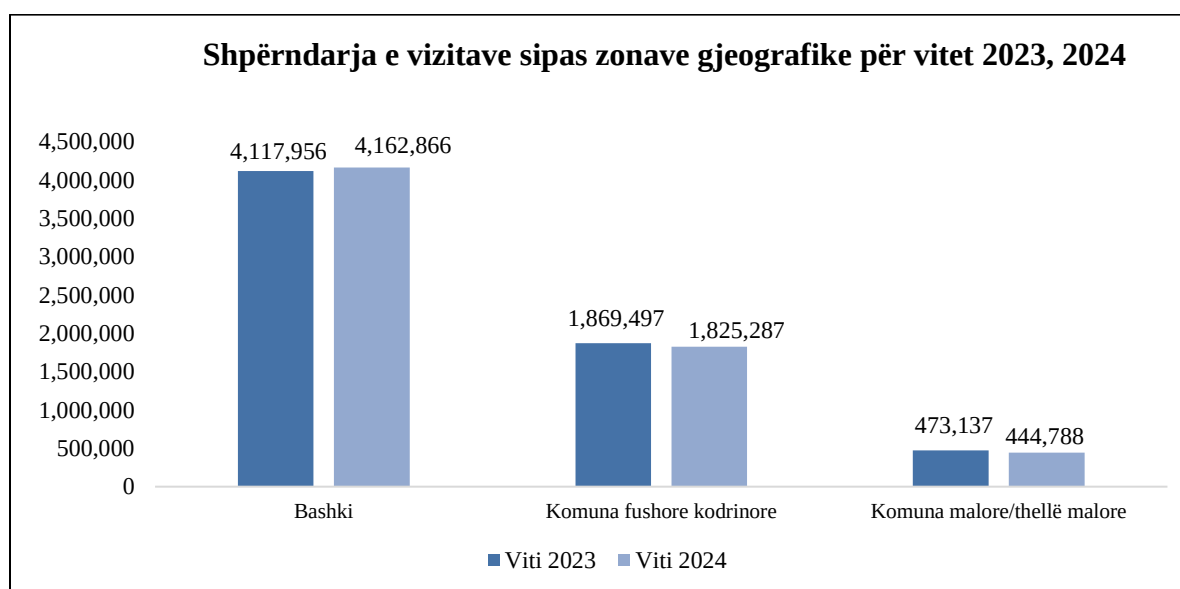
➤ **Vizitat e kryera sipas zonave urbane dhe rurale për vitet 2023, 2024**



Në grafikun e mësipërm jepen të dhënat sipas zonave urbane/rurale gjatë viteve 2023 dhe 2024.

Gjatë vitit 2024 kemi ndryshim të dukshëm të vizitave në zonat urbane dhe rurale. Në vitin 2024, këto vizita u rritën me rreth 1% për zonat urbane dhe janë ulur me rreth 3% për zonat rurale.

➤ **Vizitat e realizuara sipas zonave gjeografike, Bashki, Komunë Fushore/ Kodrinore, Komunë Malore/Thellë malore për vitet 2023, 2024**



Shpërndarja e vizitave sipas zonave gjeografike të përcaktuara në kontratë, për vitet 2023, 2024 paraqitet si më poshtë

- vizitat nga MP/F e Qendrave Shëndetësore në Bashki gjatë vitit 2024 u rrit me rreth 45 mijë vizita (ose rreth 1%) më shumë.
- vizitat nga MP/F e Qendrave Shëndetësore në zonat Komunë Fushore/Kodrinore gjatë vitit 2024 janë ulur me rreth 44 mijë vizita (ose rreth 2%) më pak.
- vizitat nga MP/F në Qendrat Shëndetësore të zonave Komunë Malore/Thellë Malore gjatë vitit 2024 vizitat janë ulur me rreth 28 mijë vizita (ose 6%) më pak.
- Në total rezultojnë rreth 28 mijë vizita (ose rreth 1%) më pak.

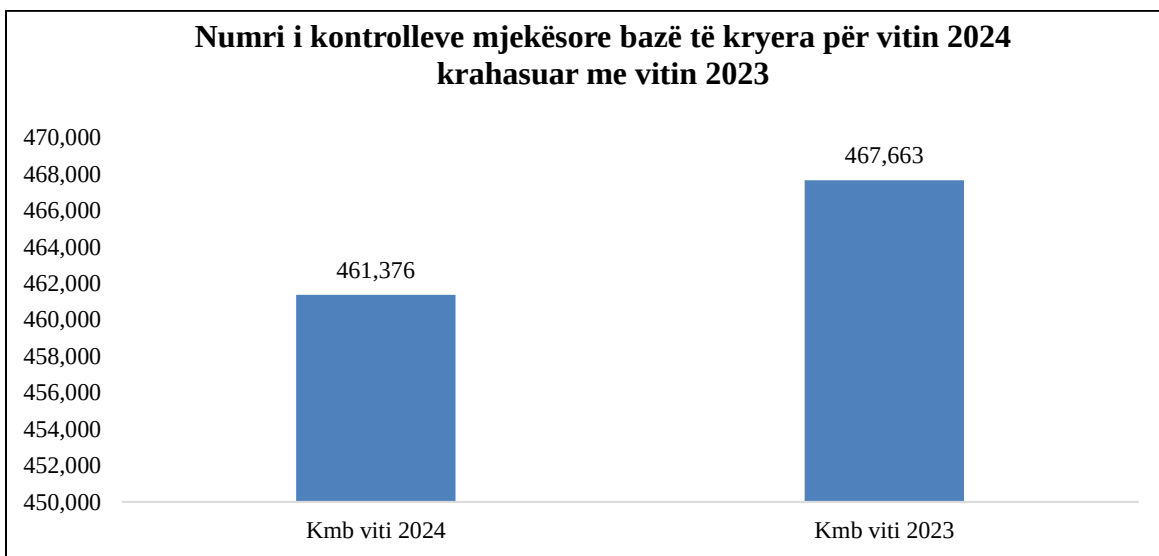
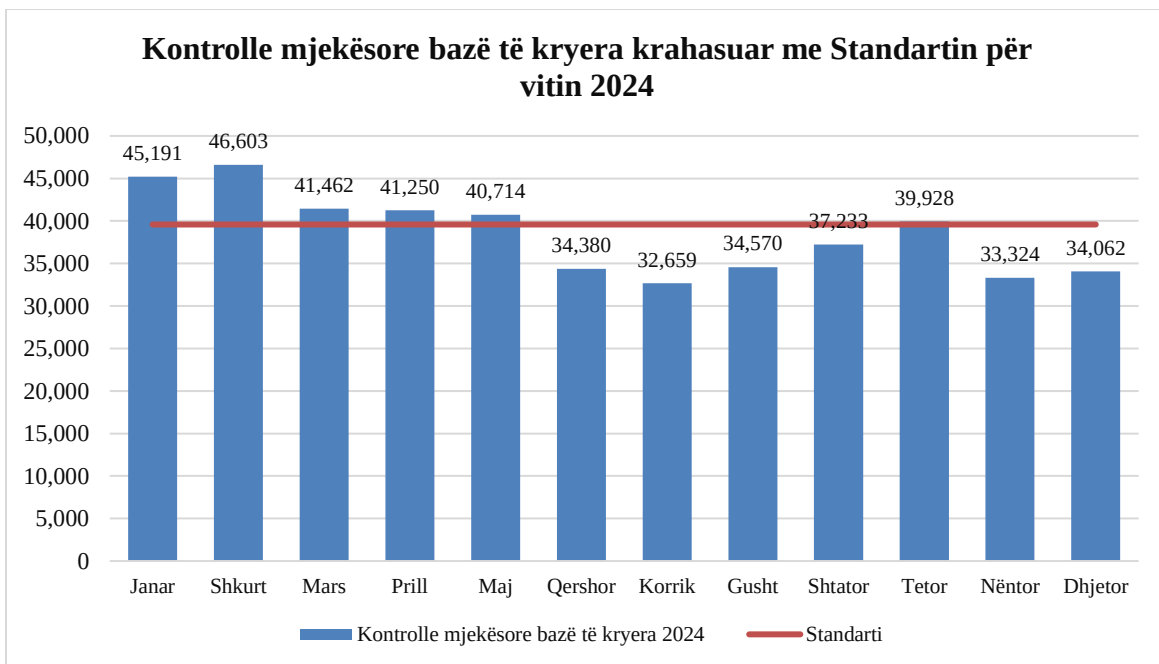
7.2 Kontrolli mjekësor bazë

Ofrimi i paketës së Kontrollit Mjekësor Bazë (KMB), realizohet bazuar në Vendimin Nr. 185, datë 02.04.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së realizimit të kontrollit mjekësor bazë për shtetasit e grupmoshës 35-70 vjeç”, të ndryshuar me VKM, Nr. 721, datë 12.10.2016.

Bazuar në Kontratën e Financimit si dhe Udhëzimin nr.12, datë 18.05.2015 “Për procedurat e pagesës së Shoqërisë 3P Life Logisitik sh.p.k”, lidhur me shërbimet për ofrimin e Paketës së Kontrollit Mjekësor Bazë, sektori përkatës çdo muaj mbledh, verifikon dhe përpunon të dhënat mbi numrin e kontrolleve mjekësore bazë të realizuara nga çdo Drejtori Rajonale e Fondit dhe përgatit dosjen për kryerjen e pagesës së Konçensionarit. Verifikimi dhe dorëzimi i kërkesës për pagesë të Konçensionarit në çdo rast është bërë brenda afatit dhe mënyrës të përcaktuar në udhëzim.

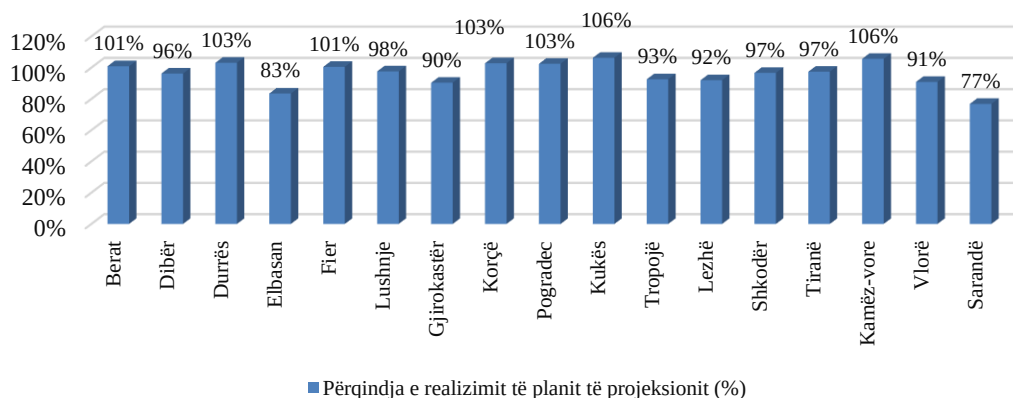
Për periudhën Janar – Dhjetor 2024, u realizuan 461,376 kontrolle mjekësore bazë, me një përqindje realizimi të planit të projeksionit 97%. Ndërkohë që për vitin 2023 janë kryer 467,663 kontrolle mjekësore bazë, ose e shprehur në përqindje 98%. Pra për vitin 2024 kemi një ulje të numrit të kontrolleve mjekësore bazë të kryera me 6,287 kontrolle më pak, ose e shprehur në përqindje me një ulje prej rreth 1% më pak kontrolle të kryera krahasuar me një vit më parë.

Për më shumë grafikët e mëposhtëm:

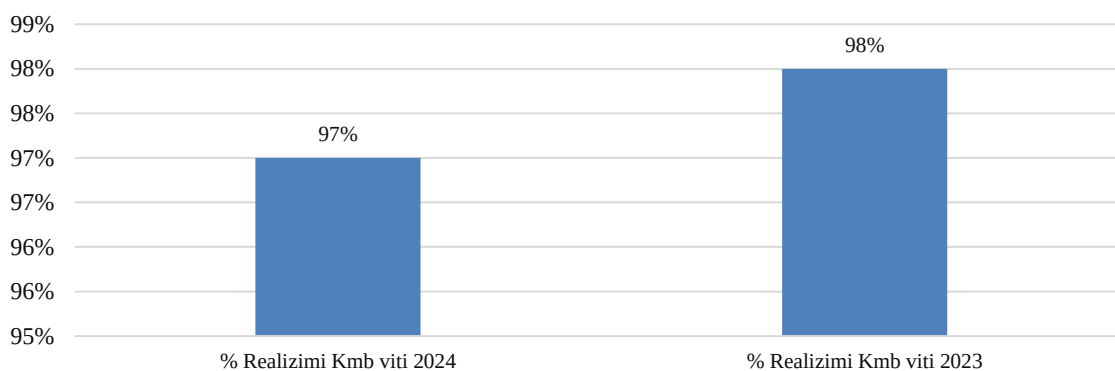


Realizimi i planit të projeksionit të kontrollit mjekësor bazë në përqindje për periudhën Janar-Dhjetor 2024:

Realizimi në përqindje i planit të projeksionit të KMB për vitin 2024

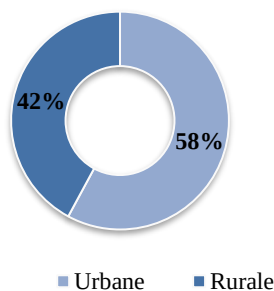


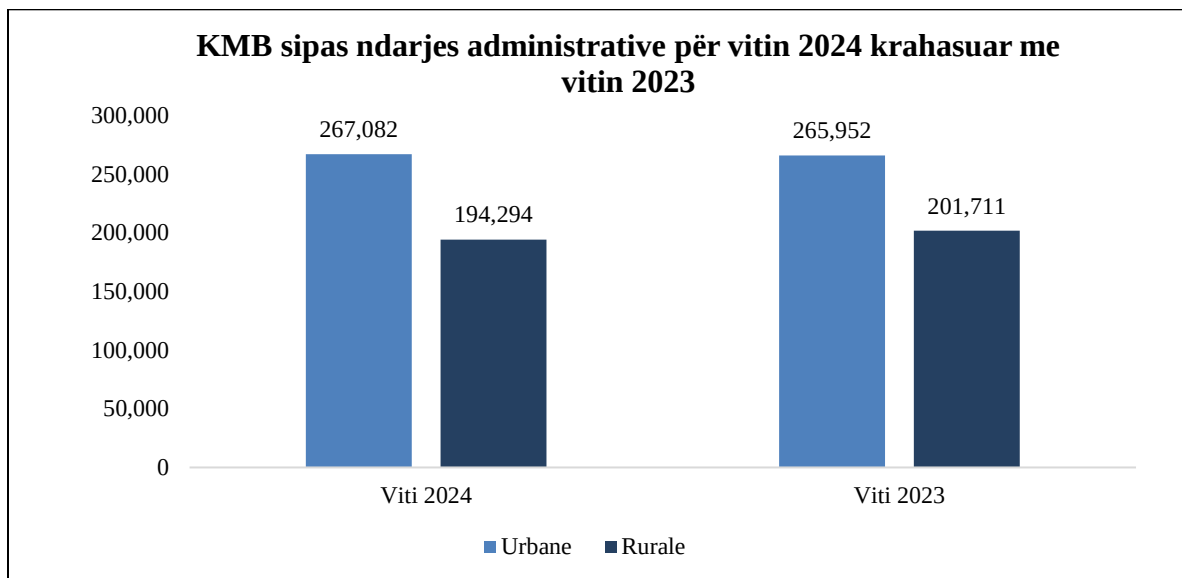
Trendi i përqindjes së realizimit të projeksionit të KMB për vitin 2024 krahasuar me vitin 2023



Sipas ndarjes administrative në zona urbane dhe rurale, kontrolli mjekësor bazë për periudhën Janar-Dhjetor 2024, paraqitet në grafikun si më poshtë:

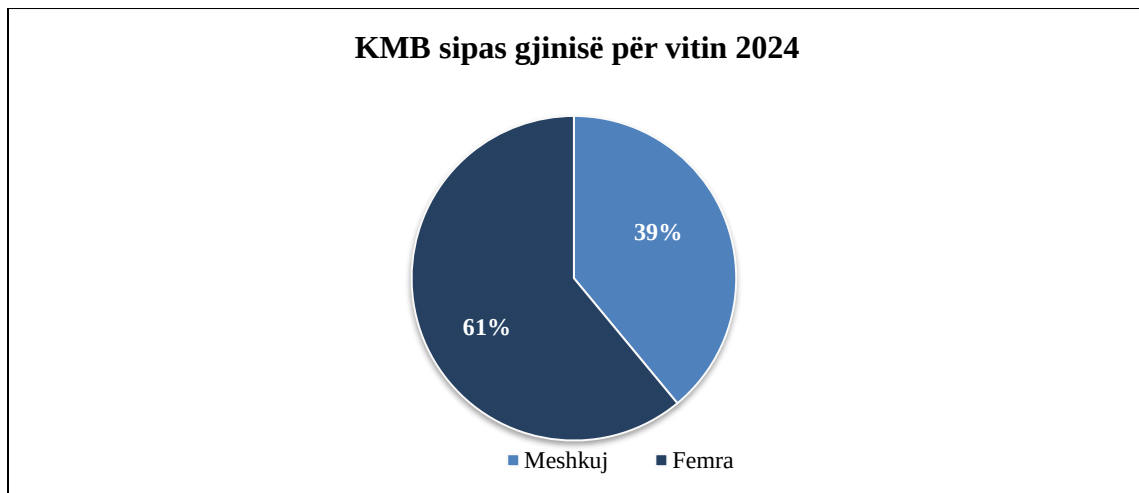
KMB sipas ndarjes administrative për vitin 2024





Për vitin 2024 kontrole mjekësore bazë rezultojnë të kryera 42% në zonat rurale dhe 58% në zonat urbane. Ndërsa për vitin 2023 kontrole mjekësore bazë sipas ndarjes administrative rezultojnë 43% në zonat rurale dhe 57% në zonat urbane.

Struktura e realizimit të kontrollit mjekësor bazë sipas gjinisë paraqitet në grafikun e mëposhtëm:



Siç shihet nga grafiku, femrat kanë % më të lartë në kryerjen e vizitave të kontrollit mjekësor bazë krahasuar me meshkujt.

7.3 Paketa e shërbimeve në shërbimin spitalor

Në kontratën me spitalet publike janë monitoruar indikatorët e performancës dhe cilësisë. Në totalin e indikatorëve të monitoruar dhe vlerësuar janë: numri i shtrimeve në spitale, niveli i shfrytëzimit të shtratit, ditëqëndrimi mesatar, xhiro e shtratit në spitale, përqindja e numrit të pacientëve të shëruar të dalë nga spitali, si dhe përqindja e shtrimeve urgjente në spital.

Më poshtë janë të pasqyruara aktivitetet e Spitaleve Universitare, Rajonale dhe Bashkiake si edhe realizimet e indikatorëve sipas kontratës.

Shtrimet

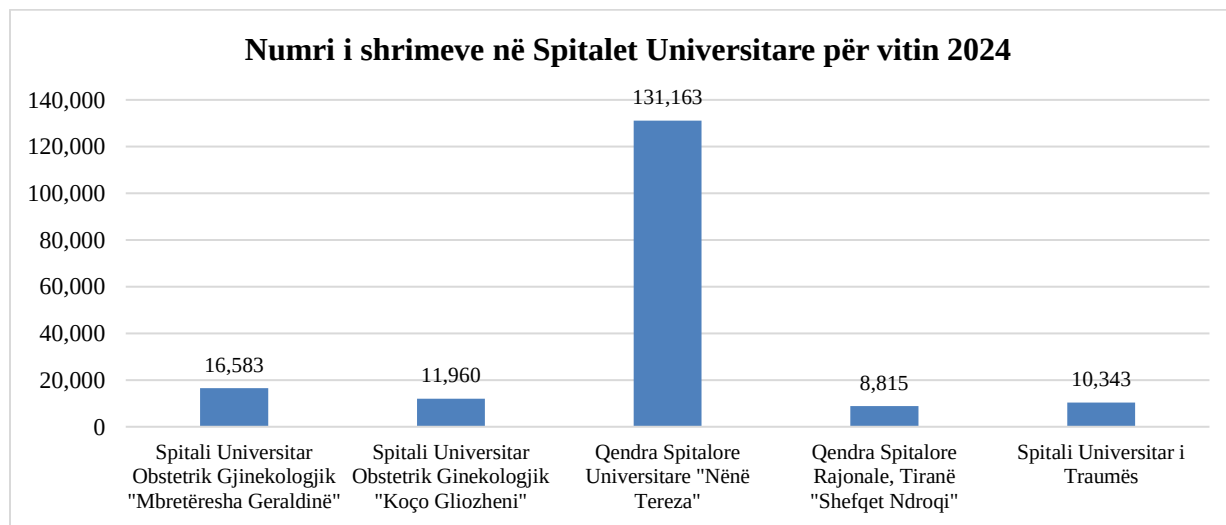
Në total për vitin 2024 numri i shtrimeve për të gjithë spitalet e kontraktuara është 324,000 pacientë, 16,192 pacientë më shumë se një vit më parë.

Nga ky numër në Spitalet Universitare janë shtruar 178,864 pacientë, në Spitalet Rajonale janë shtruar 117,888 pacientë dhe në Spitalet Bashkiake janë shtruar 27,248 pacientë.

Spitalet Universitare

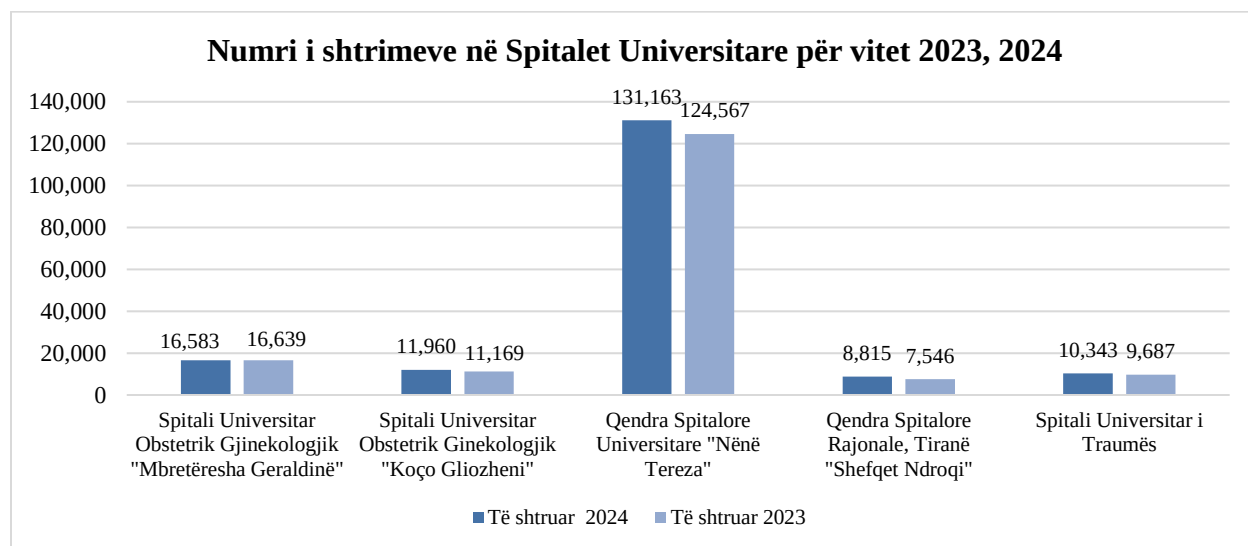
Në Spitalet Universitare numri i shtrimeve për vitin 2024 është 178,864 pacientë, 9,256 pacientë më shumë se një vit më parë.

Numri i shtrimeve në Spitalet Universitare për Vitin 2024:



Nga krahasimi i numrit të shtrimeve për vitin 2024 në spitalet universitare vihet re se Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë ka numrin më të lartë të shtrimeve me 131,163 shtrime për vitin 2024.

Krahasimi i shtrimeve në Spitalet Universitare për vitet 2023, 2024:



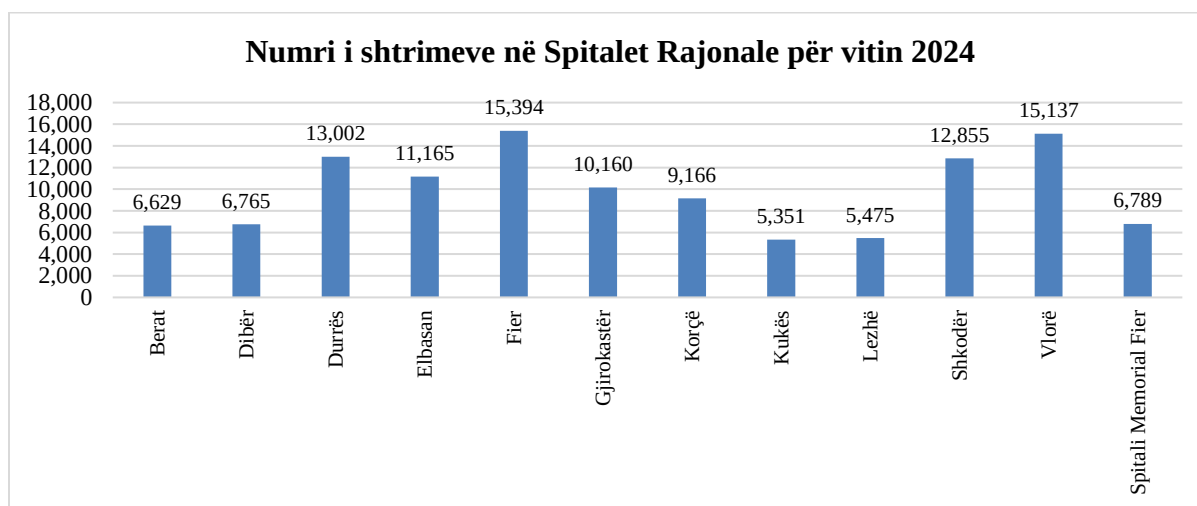
Nga krahasimi i numrit të shtrimeve në Spitalet Universitare për vitet 2024, 2023 vihet re një rritje e numrit të shtrimeve për vitin 2024.

Numri i shtrimeve gjatë vitit 2024 për Spitalet Universitare në total krahasuar me vitin 2023 ka rritje me 9,256 shtrime.

Spitalet Rajonale

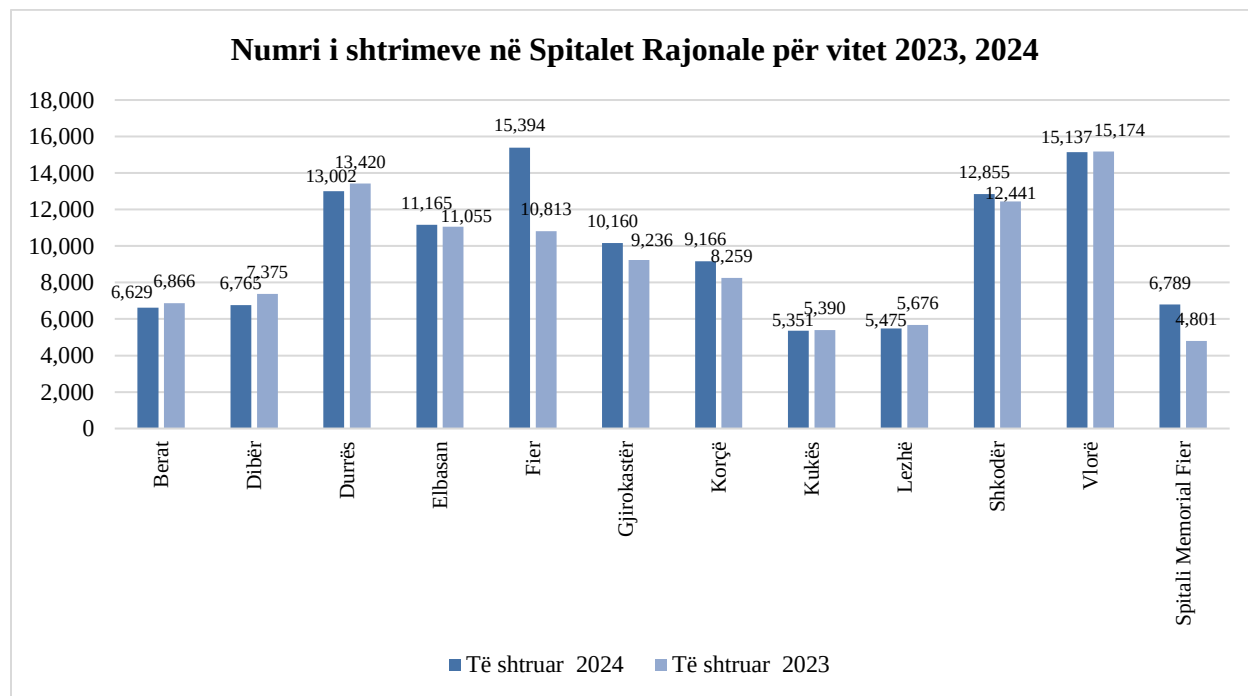
Numri i shtrimeve për Spitalet Rajonale për vitin 2024 është 117,888 pacientë, 7,382 pacientë me shumë se një vit më parë.

Numri i shtrimeve në Spitalet Rajonale për vitin 2024:



Me numrin më të lartë të shtrimeve në Spitalet Rajonale rezulton Spitali Rajonal Fier, i ndjekur nga Spitali Rajonal Vlorë dhe nga Spitali Rajonal Durrës.

Krahasimi i numrit të shtrimeve në Spitalet Rajonale për vitet 2023, 2024:



Nga krahasimi i numrit të shtrimeve për vitin 2024 me vitin 2023 vërehet se numri i shtrimeve për vitin 2024 ka rritje me 7,382 shtrime më shumë.

Spitalet Bashkiake

Numri i shtrimeve në Spitalet Bashkiake për vitin 2024 është 27,248 pacientë. 446 pacientë të shtruar më pak krahasuar me një vit më parë.

Raporti i shtrimeve urgjente me shtrimet në total

Për vitin 2024 në total 55.1 % e shtrimeve në spitale janë nëpërmjet shërbimit të urgjencës.

Për vitin 2024, në Spitalet Universitare janë shtruar nga urgjenca, që zënë 34.2 % të rasteve, ndërsa në Spitalet Rajonale janë shtruar nga urgjenca 79 % të totalit të shtrimeve.

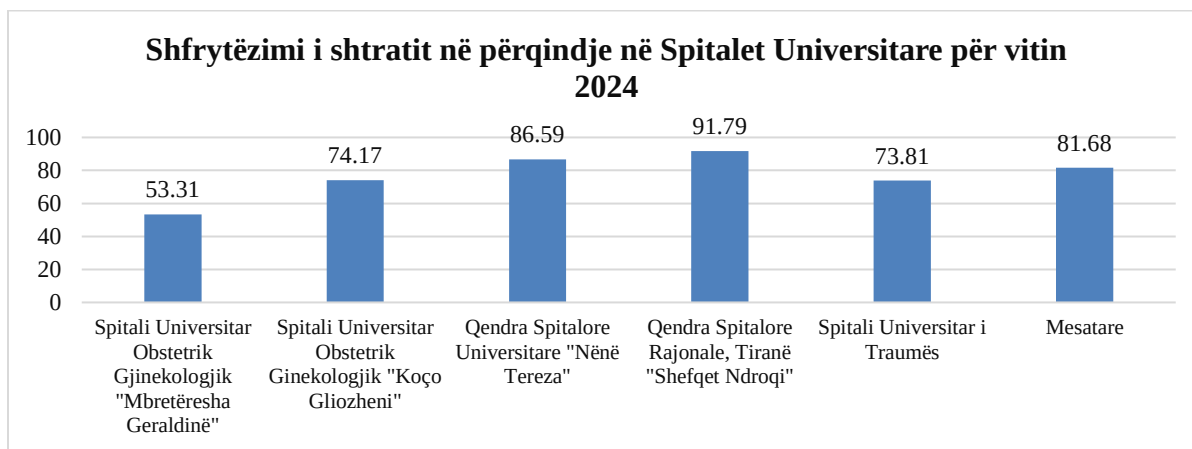
Për sa i përket këtij indikator vlerat më të larta janë në Spitalet Rajonale Vlorë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Gjirokastrë.

Shfrytëzimi i shtratit

Si një indikator tepër i rëndësishëm i efijencës spitalore paraqitet në këto nivele; në Spitalet Universitare mesatarja e shfrytëzimit të shtratit është 81.68 % dhe në Spitalet Rajonale mesatarja e shfrytëzimit të shtratit është 35.87 %.

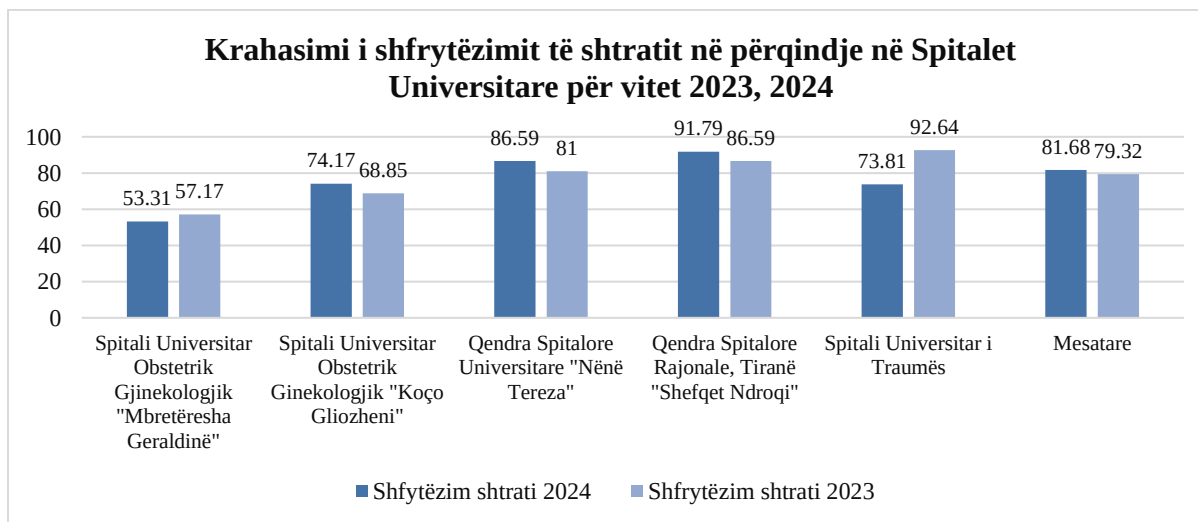
Më poshtë paraqesim grafikët krahasues për shfrytëzimin e shtratit në spitalet rajonale, universitare dhe bashkiake.

Shfrytëzimi i shtratit në Spitalet Universitare



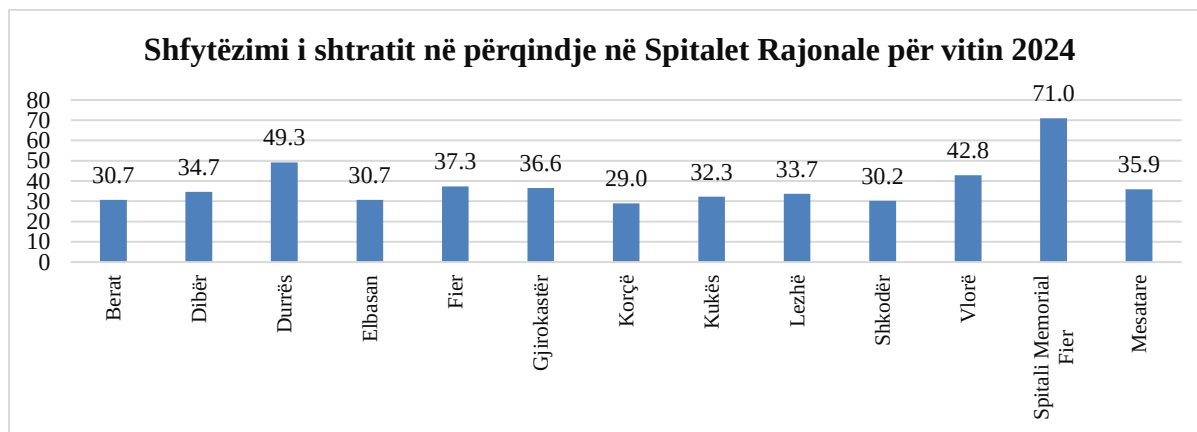
Në realizimin e këtij indikatori vlerat më të larta janë në Spitalet; Qendra Spitalore Rajonale, Tiranë "Shefqet Ndroqi" dhe Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë.

Krahasimi i shfrytëzimit të shtratit në Spitalet Universitare për vitet 2023, 2024:



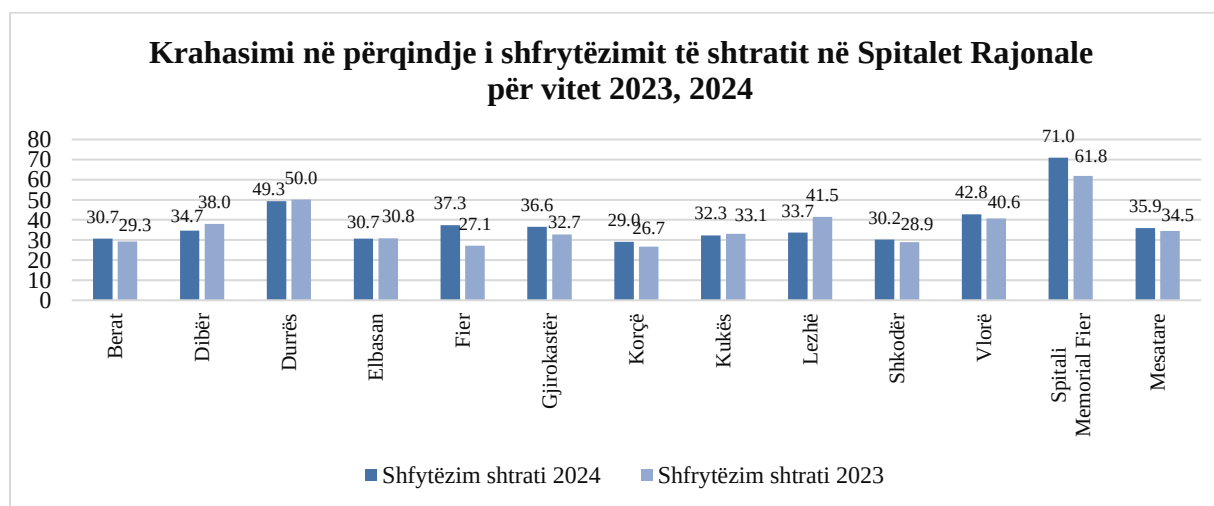
Për Spitalin Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”, Qendrën Spitalore Rajonale, Tiranë “Shefqet Ndroqi”, si dhe Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë kemi një rritje të indikatorit të shfrytëzimit të shtratit për vitin 2024, ndërsa për Spitalin Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë” dhe Spitalin Universitar të Traumës vihet re një ulje e lehtë e këtij indikatorit për vitin 2024.

Shfrytëzimi i shtratit në Spitalet Rajonale



Në nivele më të larta për shfrytëzimin e shtratit për vitin 2024 paraqitet Spitali Memorial Fier, Durrës, Vlorë, Fier dhe Gjirokastrë në vlera më të ulura paraqitet Spitali Berat, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Lezhë dhe Dibër.

Krahasimi i shfrytëzimit të shtratit për Spitalet Rajonale për vitet 2023, 2024:



Nga krahasimi i mësipërm vihet re një rritje e këtij indikatorit në Spitalet Rajonale për vitin 2024.

Ditë qëndrimi mesatar

Në total mesatarja e ditë qëndrimit mesatar për të gjitha spitalet për vitin 2024 është 3.9 ditë.

Indikatori i ditë qëndrimit mesatar paraqitet në këto shifra në spitale:

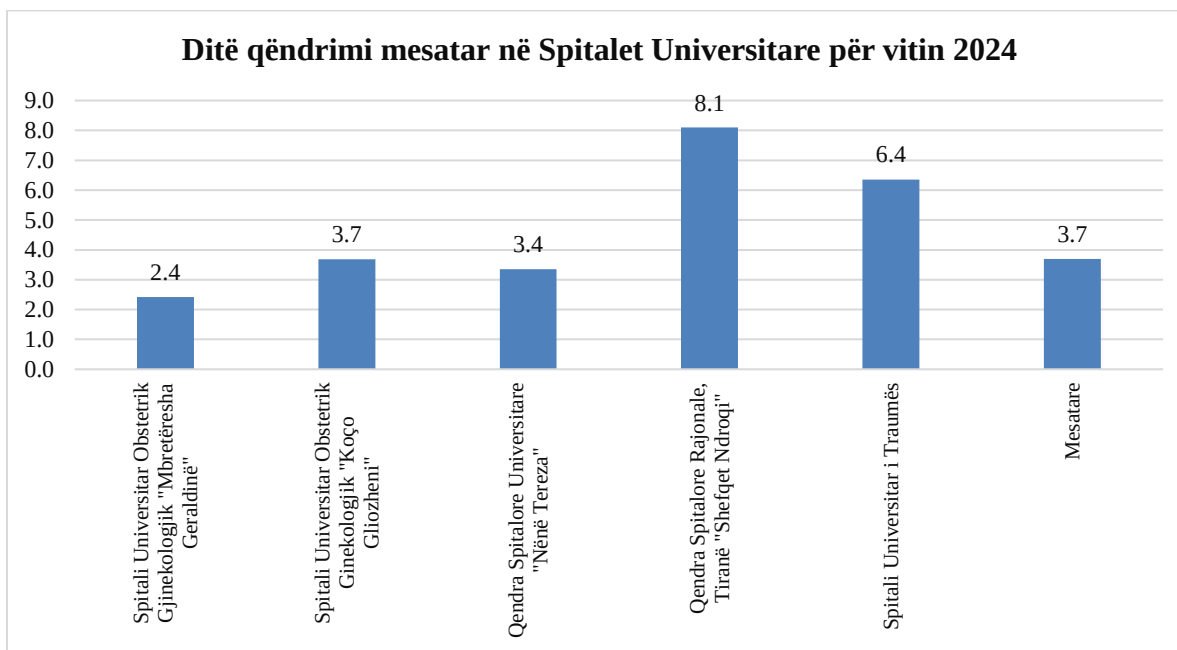
Në Spitalet Universitare mesatarja e ditë qëndrimit mesatar është 3.7 ditë.

Në Spitalet Rajonale mesatarja e ditë qëndrimit mesatar është 3.9 ditë.

Në spitalet Bashkiake mesatarja e ditë qëndrimit mesatar është 4.7 ditë.

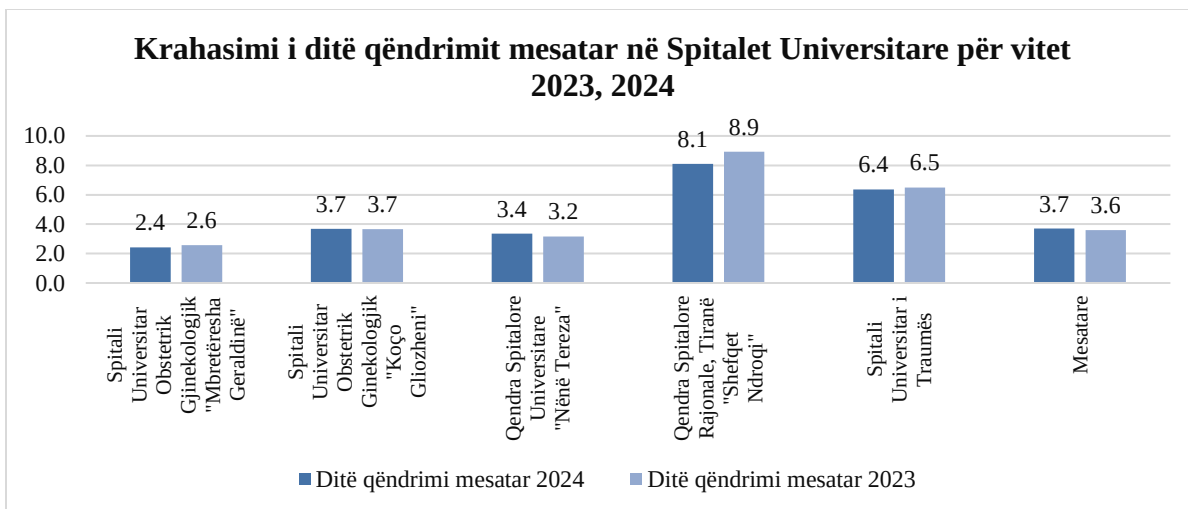
Më poshtë paraqesim grafikët krahasues për ditëqëndrimin mesatar në Spitalet Universitare dhe Spitalet Rajonale.

Ditë qëndrimi mesatar në Spitalet Universitare



Në Spitalet Universitare ditë qëndrimi mesatar në nivelet më të larta rezulton në Qendrën Spitalore Rajonale, Tiranë "Shefqet Ndroqi" përkatësisht 8.1.

Krahasimi i ditë qëndrimit mesatar në Spitalet Universitare për vitet 2023, 2024:

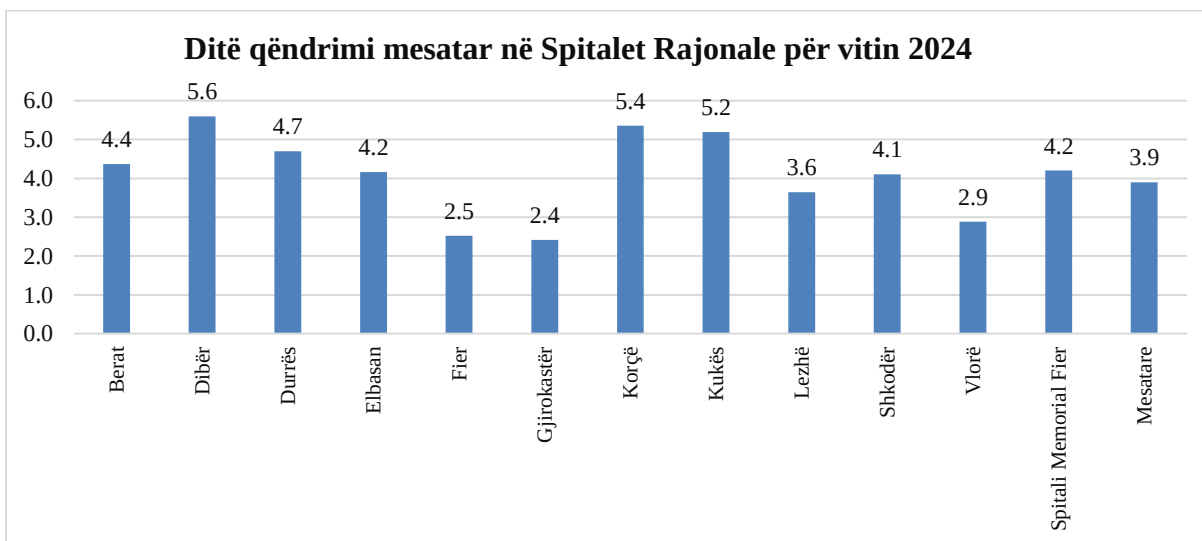


Nga krahasimi me vitin 2023 rezulton një rritje e lehtë e ditë qëndrimit mesatar për Qendrën Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë dhe një ulje e ditë qëndrimit mesatar për Spitalin Universitar të Traumës, Spitalin Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë" dhe Qendrën Spitalore Rajonale, Tiranë "Shefqet Ndroqi". Në Spitalin Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Koço Gliozheni" ditë qëndrimi rezulton në vlerë të njëjtë me vitin 2023.

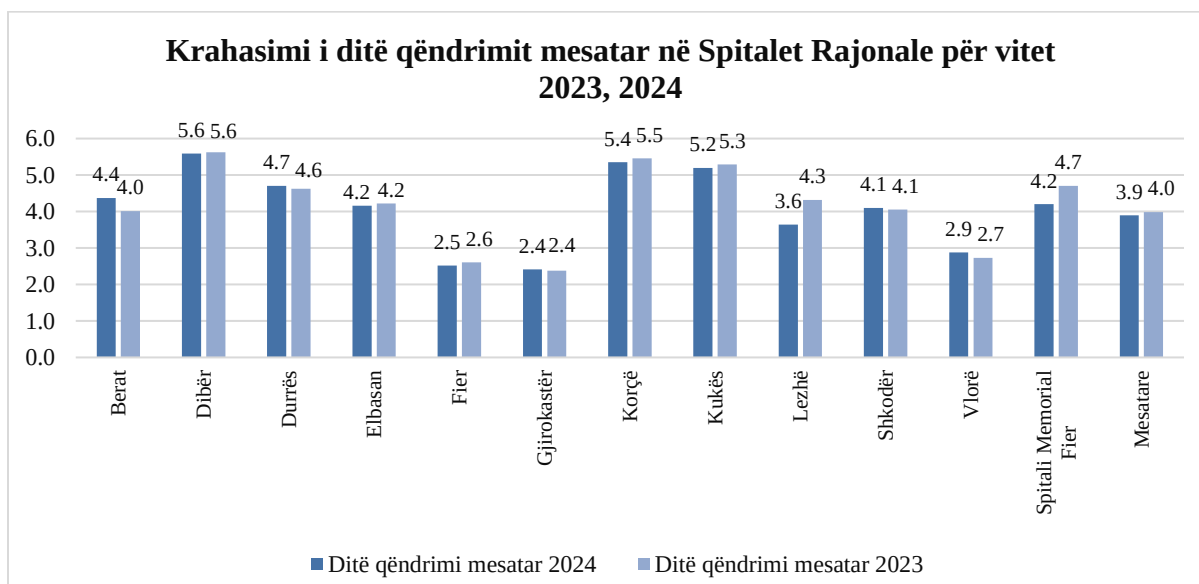
Për spitalet Universitare indikatori i ditë qëndrimit mesatar për vitin 2024 ka një mesatare 3.7 ditë.

Ditë qëndrimi mesatar në Spitalet Rajonale

Ditë qëndrimi mesatar paraqitet në shifra normale në të gjitha spitalet rajonale ku mesatarja është 3.9 ditë. Tregues më të lartë kanë spitalet Dibër, Korçë, Kukës dhe Durrës.



Krahasimi i ditëqëndrimit mesatar në Spitalet Rajonale për vitet 2023, 2024:



Në pjesën më të madhe të Spitaleve Rajonale vihet re një ulje e këtij indikator për vitin 2024. Për rajonet Lezhë, Spitali Memorial Fier, Fier, Kukës, Korçë vihet re një ulje e ditë qëndrimit mesatar.

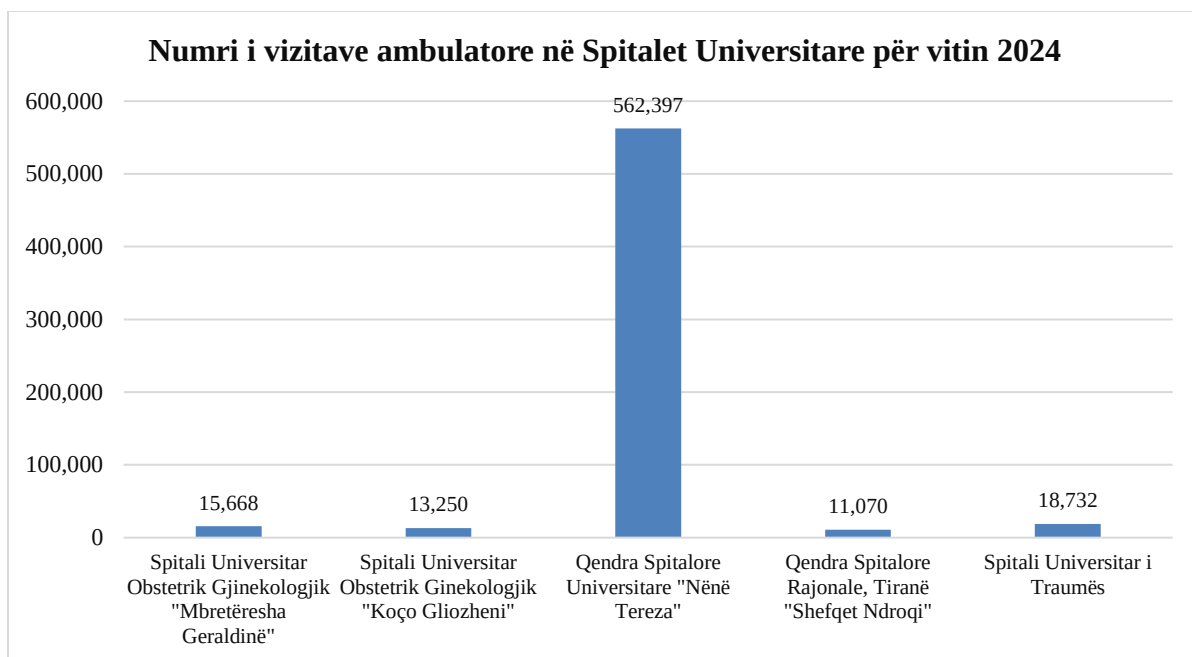
Për rajonet Berat, Durrës, Vlorë vërehet një rritje e këtij indikator. Për rajonet Dibër, Elbasan Gjirokastrë, Shkodër nuk ka ndryshime të vlerës së këtij indikator.

Vizitat ambulatorë

Vizitat ambulatorë në Spitalet Universitare

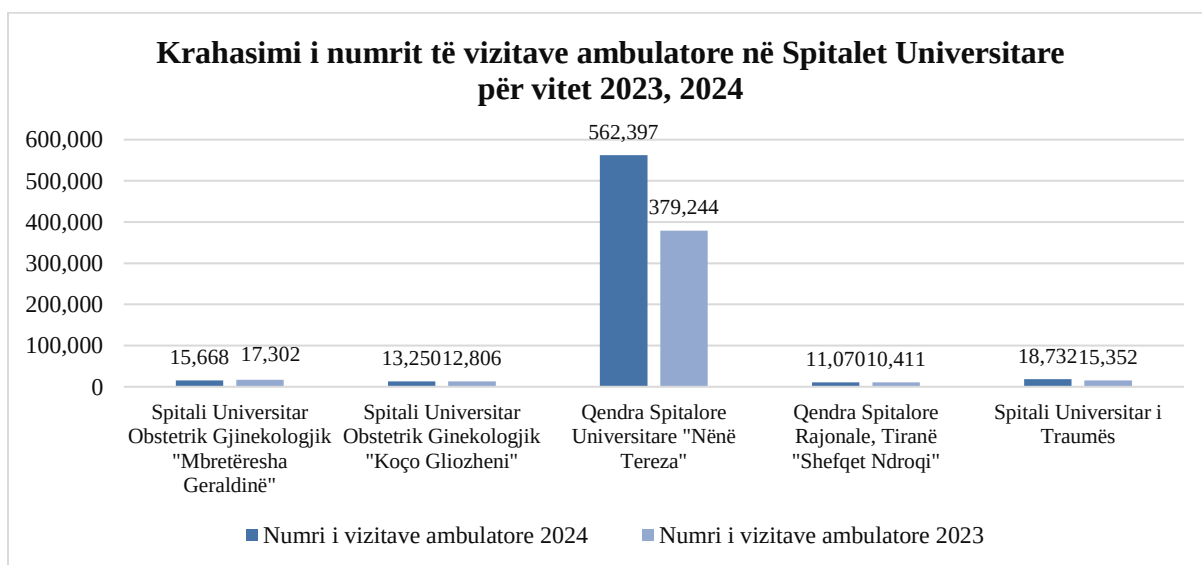
Pacientë të konsultuar për vitin 2024 në Spitalet Universitare janë 621,117. 186,002 pacientë më shumë se në vitin 2023.

Në grafikun e mëposhtëm paraqitet numri total i vizitave ambulatorë të specializuara në Spitalet Universitare për vitin 2024



Nga grafiku vihet re se numrin më të lartë të vizitave ambulatorë për vitin 2024 e ka realizuar Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë.

Në grafikun e mëposhtëm jepet krahasimi i numrit total të vizitave ambulatorë të specializuara në Spitalet Universitare për vitet 2023, 2024:

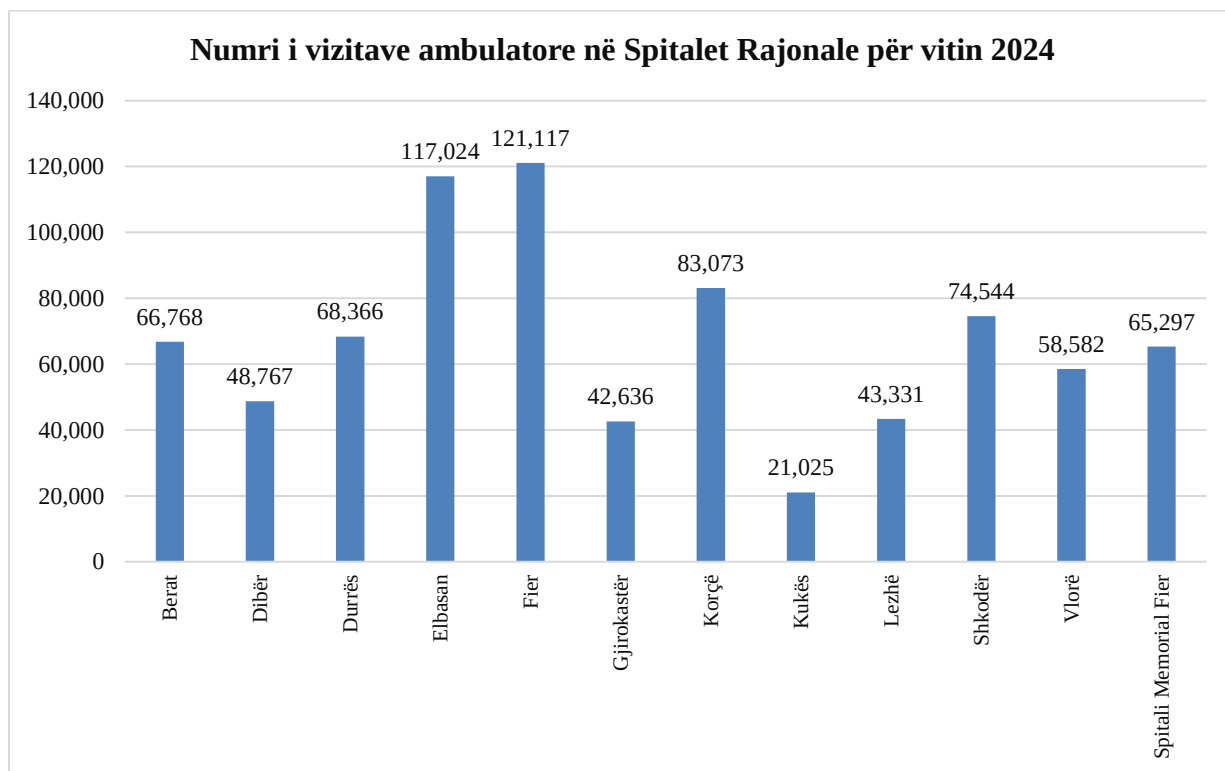


Për vitin 2024 rezulton se kemi një rritje të numrit të vizitave ambulatorë në realizuara në Spitalet Universitare.

Vizita ambulatorë në Spitalet Rajonale

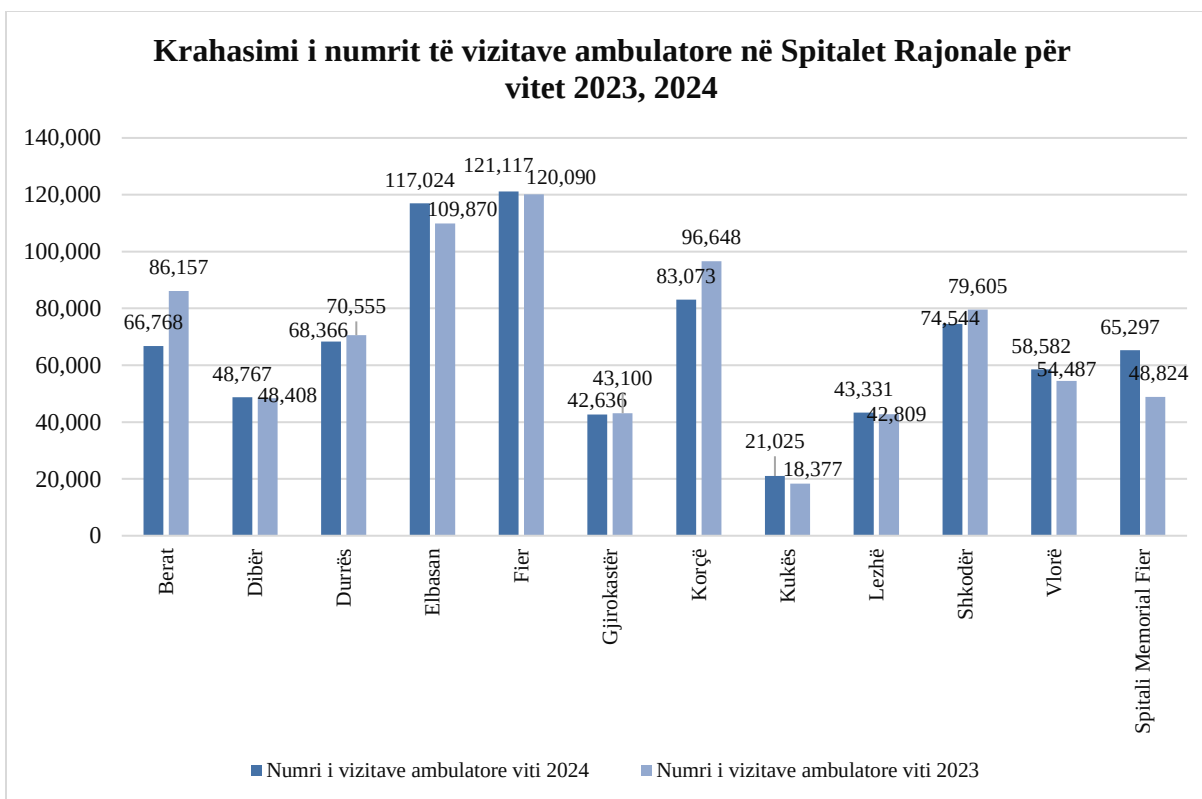
Pacientë të konsultuar për vitin 2024 në Spitalet Rajonale janë 810,530. Rezultojnë 8,400 vizita ambulatorë të kryera më pak se në vitin 2023.

Në grafikun e mëposhtëm jepet numri total i vizitave ambulatorë të specializuara në Spitalet Rajonale për vitin 2024



Nga grafiku vihet re se numrin më të lartë të vizitave ambulatorë për vitin 2024 e kanë Spitalet Rajonale Fier dhe Elbasan.

Në grafikun e mëposhtëm jepet krahasimi i numrit total të vizitave ambulatorë të specializuara në Spitalet Rajonale për vitet 2023, 2024:



Nga grafiku rezulton se për vitin 2024 në Spitalet Rajonale kemi një ulje të lehtë të numrit të vizitave ambulatorë.

Ekzaminimet Laboratorike

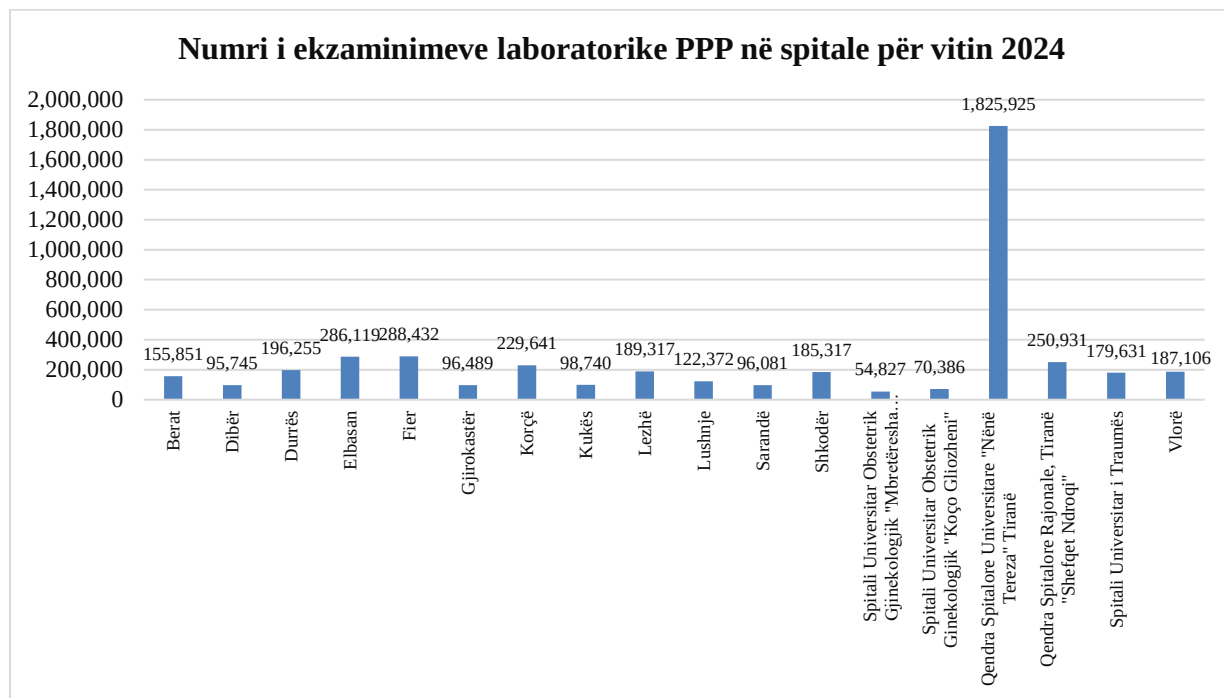
Ekzaminimet Biokimike-Klinike

Për vitin 2024 rezulton se në të gjithë spitalet e kontraktuara nga Fondi, janë realizuar 5,831,099 ekzaminime laboratorike. Në këtë numër ekzaminimesh përfshihen ekzaminimet e realizuara nga shërbimi i laboratorit në spitale dhe shërbimi i konçesionarit të laboratorëve me PPP në spitalet e caktuara.

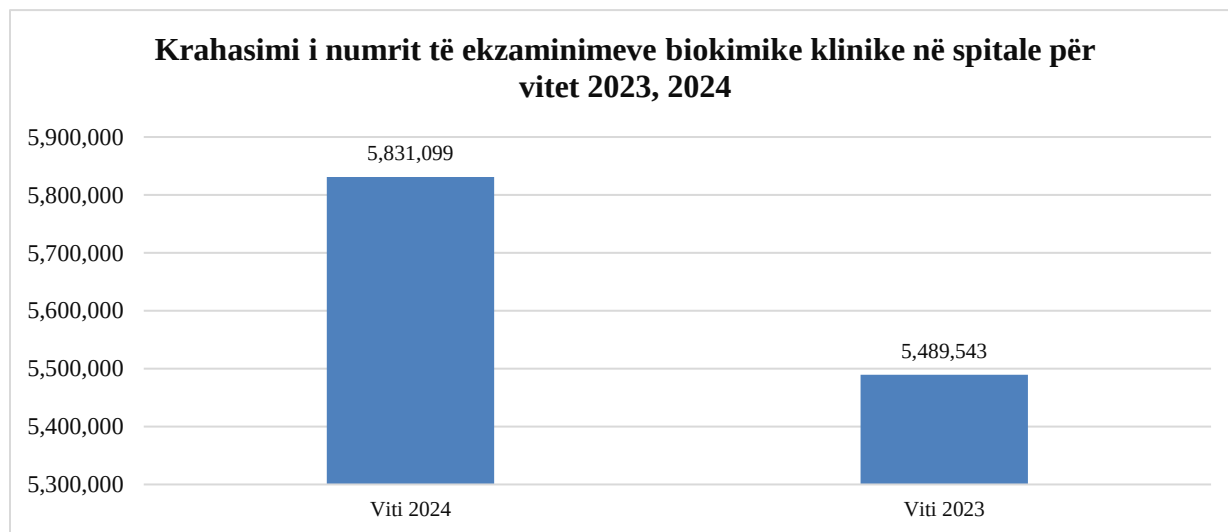
Në Spitalet Universitare janë realizuar 2,381,700 ekzaminime, në Spitalet Rajonale janë realizuar 2,263,690 ekzaminime, ndërsa Spitalet Bashkiake janë realizuar 1,185,709 ekzaminime laboratorike.

Nga numri total i ekzaminimeve nga shërbimi i konçensionarit të laboratorit në 18 spitale sipas kontratës “Për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale dhe atyre bashkiake të Sarandës dhe Lushnjës” për vitin 2024 janë realizuar 4,609,165 ekzaminime.

Ekzaminime Laboratorike përmes PPP për vitin 2024

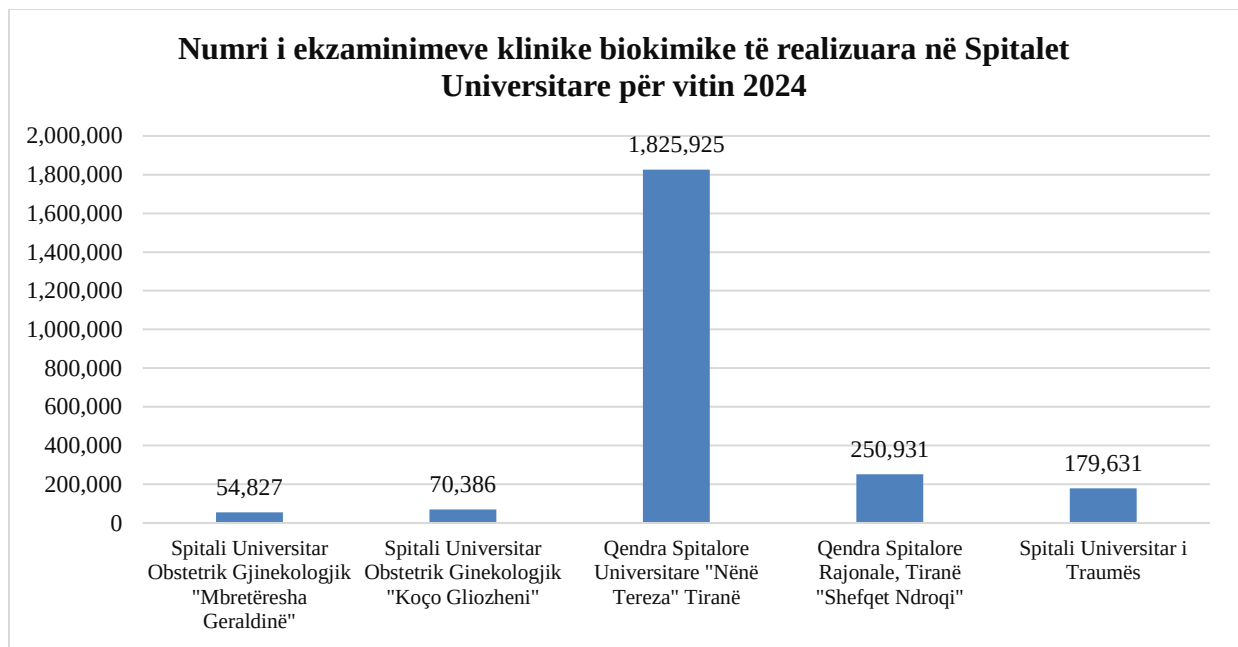


Numri i ekzaminimeve biokimike klinike në total në spitale për vitet 2023, 2024



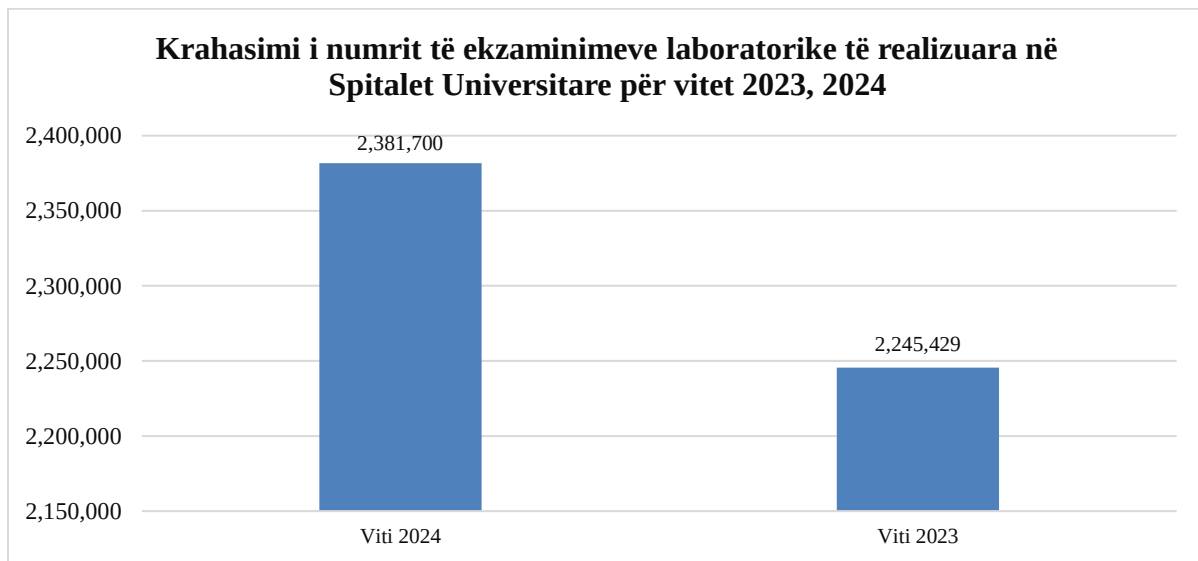
Ekzaminimet laboratorike në Spitalet Universitare

Grafiku me të dhënat mbi numrin e ekzaminimeve klinike biokimike të realizuara në Spitalet Universitare për vitin 2024



Nga grafiku vihet re se Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë ka numrin më të lartë të ekzaminimeve klinike biokimike të realizuara për vitin 2024.

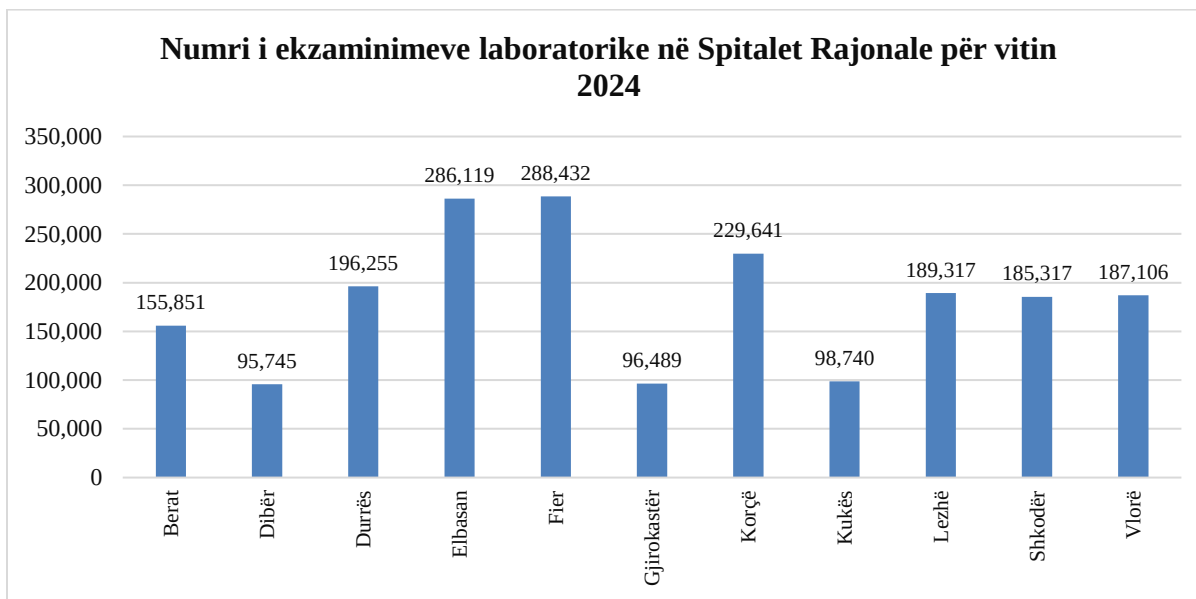
Grafiku me të dhënat mbi numrin e ekzaminimeve klinike biokimike të realizuara në total në Spitalet Universitare për vitet 2023, 2024:



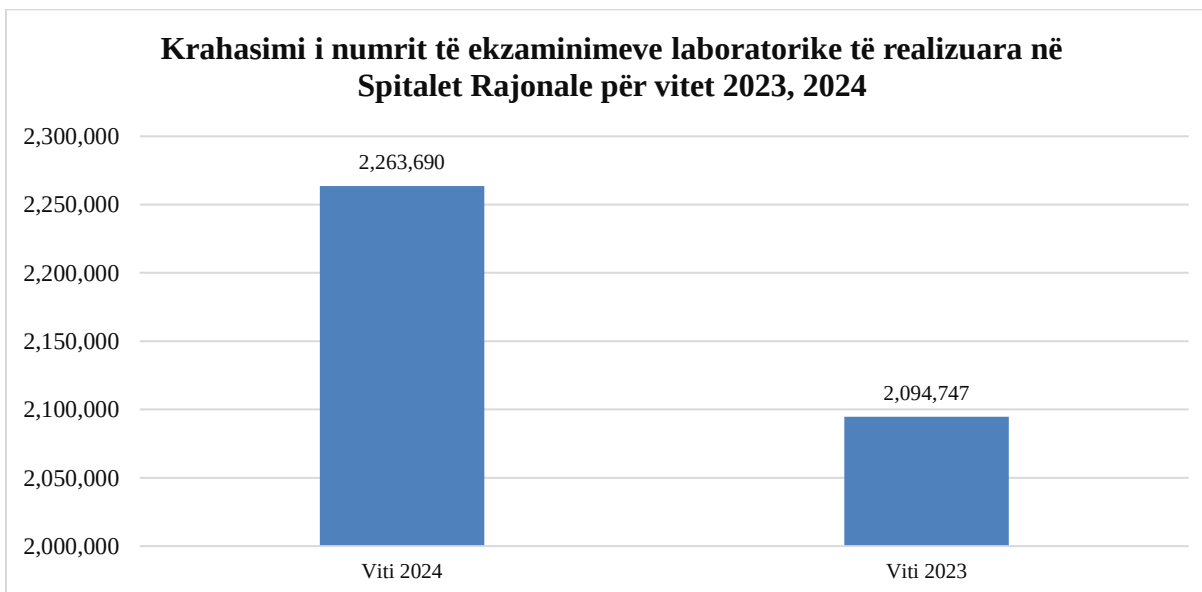
Nga grafiku krahasues për vitet 2023, 2024 vihet re se për vitin 2024 rezulton një rritje e numrit të ekzaminimeve klinike të realizuara në total në Spitalet Universitare me 136,271 ekzaminime më shumë.

Ekzaminimet laboratorike në Spitalet Rajonale

Grafiku me të dhënat mbi numrin e ekzaminimeve klinike biokimike të realizuara në total në Spitalet Rajonale për vitin 2024:



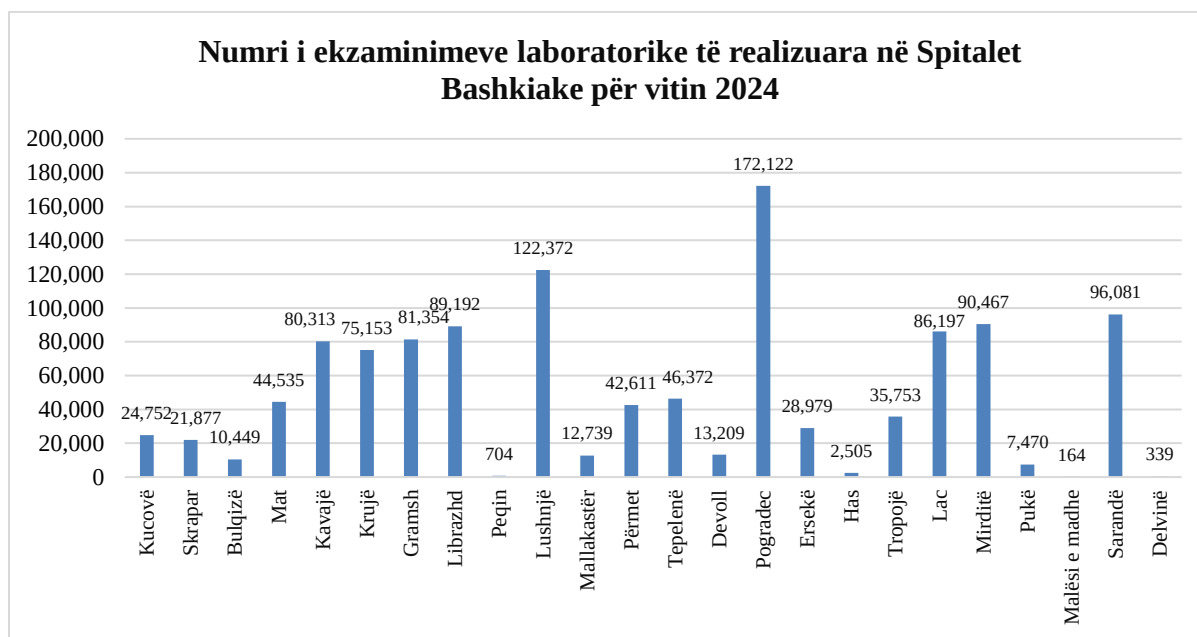
Nga grafiku vërehet se me numrin më të lartë të ekzaminimeve klinike të realizuara janë Spitalet Rajonale Fier, Elbasan dhe Korçë.



Nga grafiku vihet re se për vitin 2024 kemi një rritje të numrit të ekzaminimeve laboratorike të realizuara në total në Spitalet Rajonale krahasuar me vitin 2023.

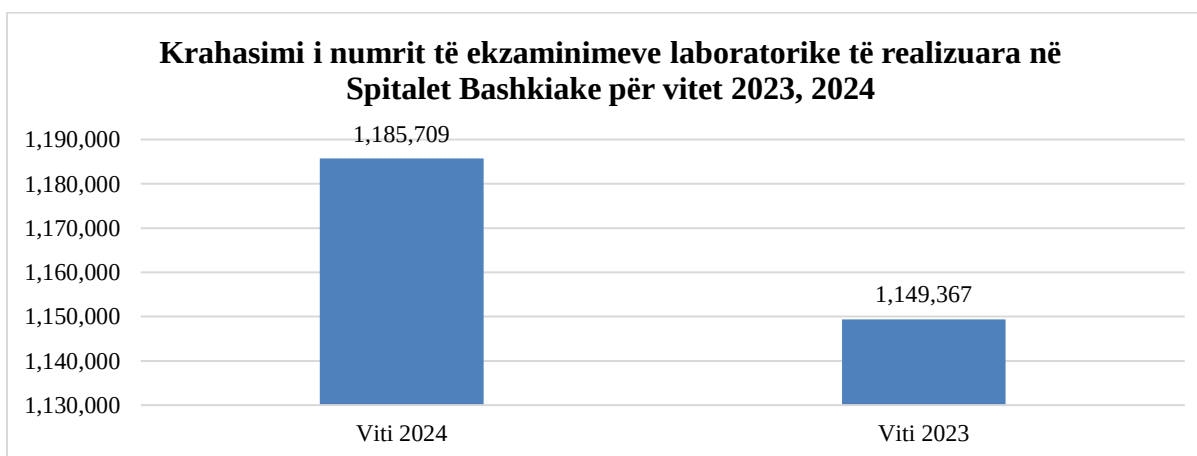
Ekzaminimet laboratorike në Spitalet Bashkiake

Grafiku me të dhënat mbi numrin e ekzaminimeve klinike biokimike të realizuara në Spitalet Bashkiake për vitin 2024.



Nga grafiku vihet re se numrin më të lartë të ekzaminimeve klinike biokimike të realizuara e kanë spitalet Pogradec, Lushnjë, Sarandë, Laç, Librazhd, Kavajë, Mirditë, etj.

Grafiku me të dhënat mbi numrin e ekzaminimeve klinike biokimike të realizuara në total në Spitalet Bashkiake për vitet 2023, 2024:

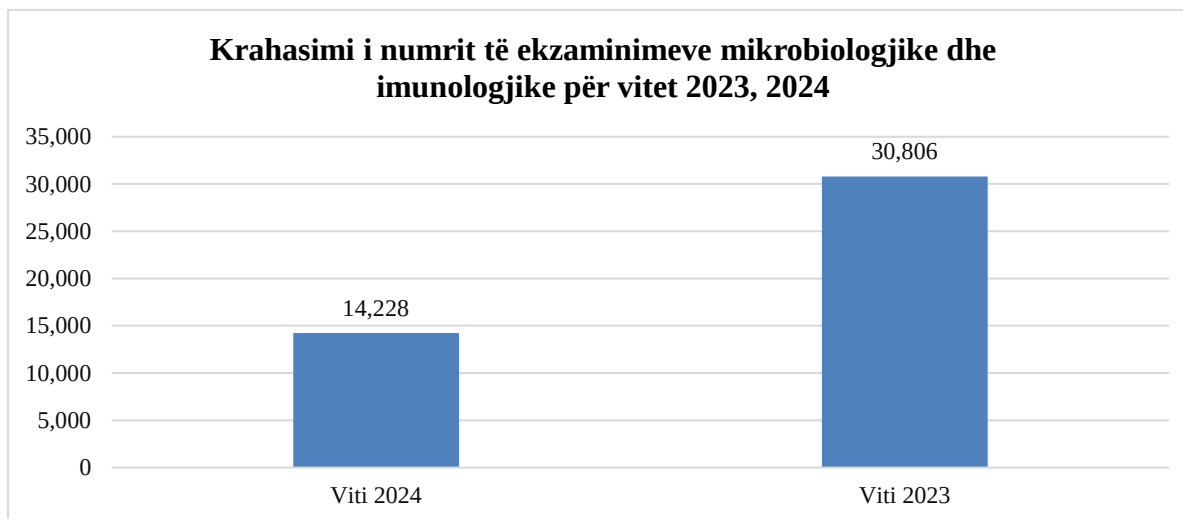


Nga grafiku krahasues për vitet 2023, 2024 vihet re se për vitin 2024 kemi rritje të numrit të ekzaminimeve laboratorike të realizuara në Spitalet Bashkiake.

Ekzaminimet mikrobiologjike dhe imunologjike 2024

Për vitin 2024 janë kryer në total 14,228 ekzaminime mikrobiologjike dhe imunologjike.

Grafiku me të dhënat mbi numrin e ekzaminimeve të kryera në spitale për vitet 2023, 2024:



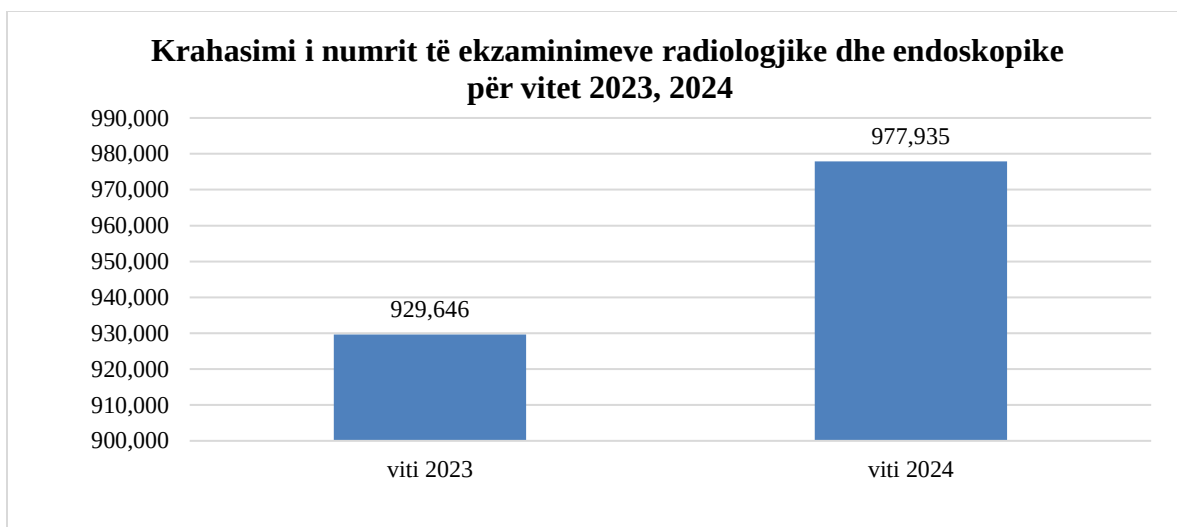
Nga grafiku vihet re se për vitin 2024 numri i ekzaminimeve mikrobiologjike dhe imunologjike të kryera në spitale është më i ulur krahasuar me vitin 2023.

Ekzaminimet radiologjike dhe endoskopike

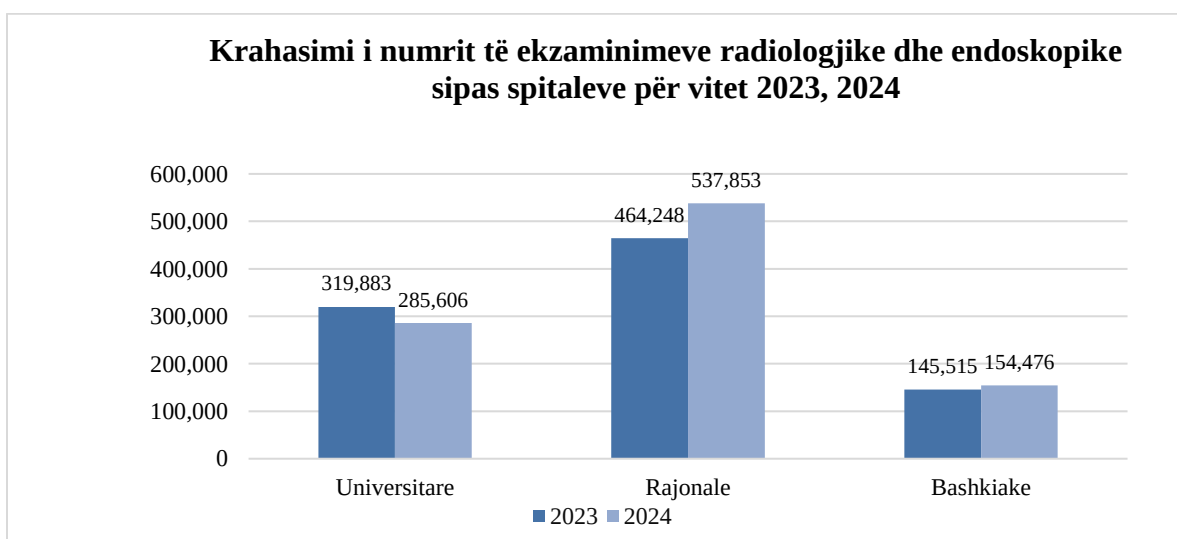
Për vitin 2024 janë realizuar në total 977,935 ekzaminime radiologjike dhe endoskopike për spitale Universitare, Rajonale dhe Bashkiake.

Nga krahasimi i numrit të ekzaminimeve për vitin 2024 me numrin e ekzaminimeve për vitin 2023 rezulton se janë realizuar 48,289 ekzaminime radiologjike dhe endoskopike më shumë gjatë vitit 2024.

Më poshtë gjeni paraqitjen grafike për periudhën Janar - Dhjetor 2023 dhe Janar - Dhjetor 2024, për numrin e ekzaminimeve radiologjike dhe endoskopike në total, të kryera nga Spitalet Universitare, Rajonale dhe Bashkiake.



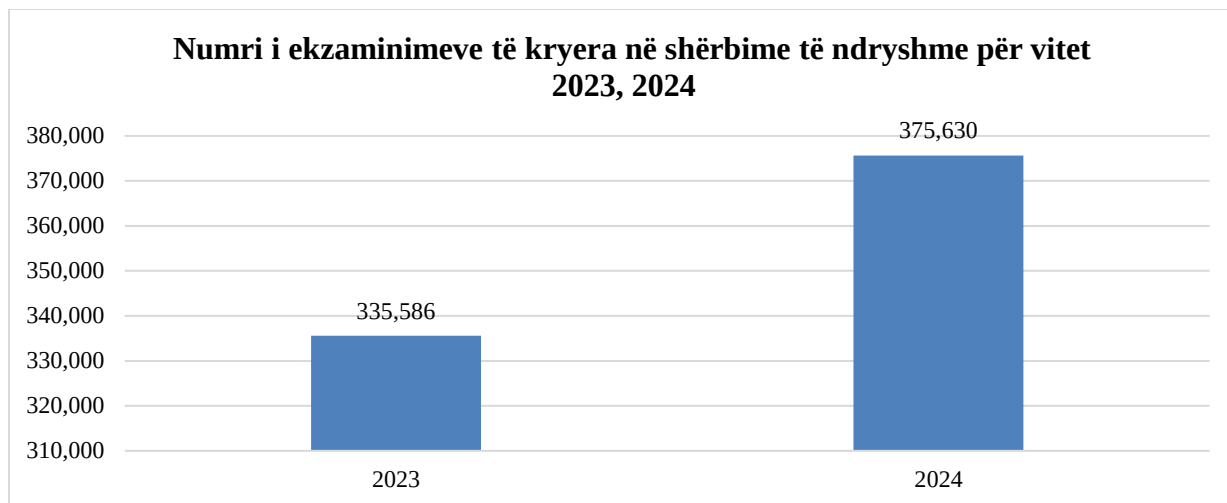
Më poshtë gjendet paraqitja grafike për vitet 2023, 2024 për numrin e ekzaminimeve radiologjike dhe endoskopike të kryera në Spitalet Universitare, Rajonale dhe Bashkiake.



Ekzaminime në shërbime të ndryshme

Në lidhje me numrin e ekzaminimeve në shërbime të ndryshme, për periudhën Janar-Dhjetor 2024 janë realizuar në total 375,630 ekzaminime në spitalet universitare, rajonale dhe bashkiake.

Më poshtë gjendet paraqitja grafike për vitet 2023, 2024:



7.4 Paketat shëndetësore

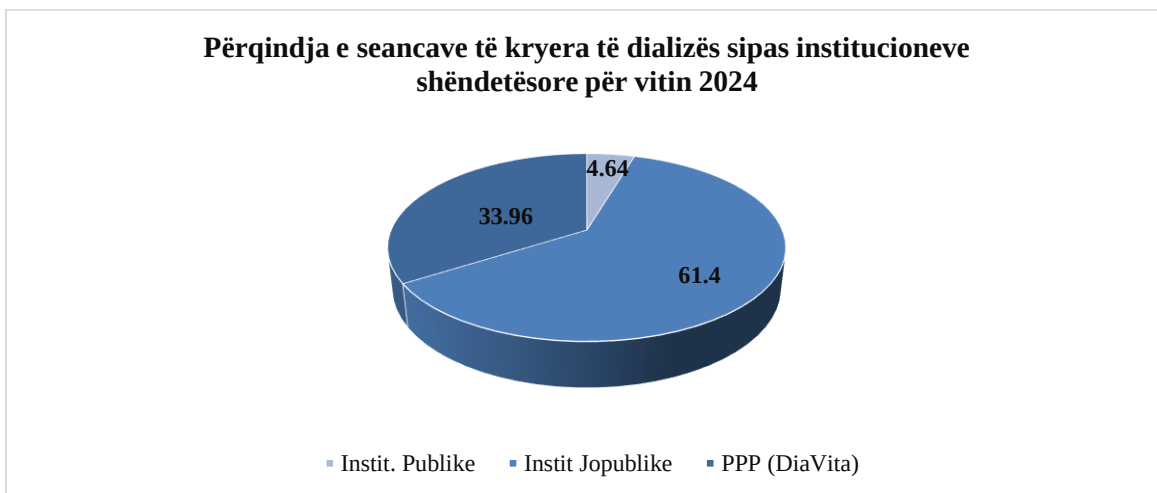
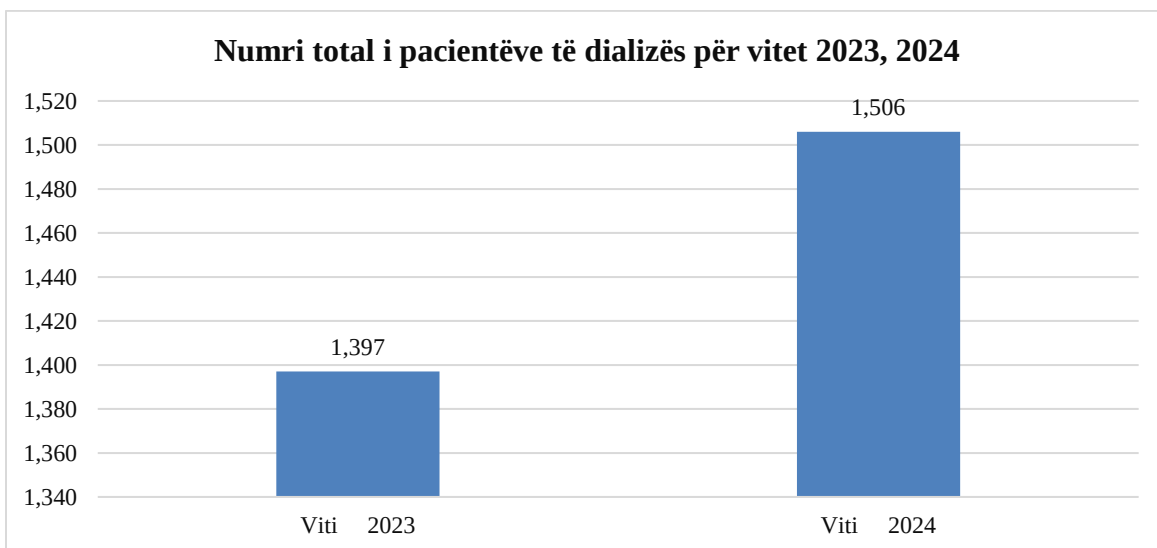
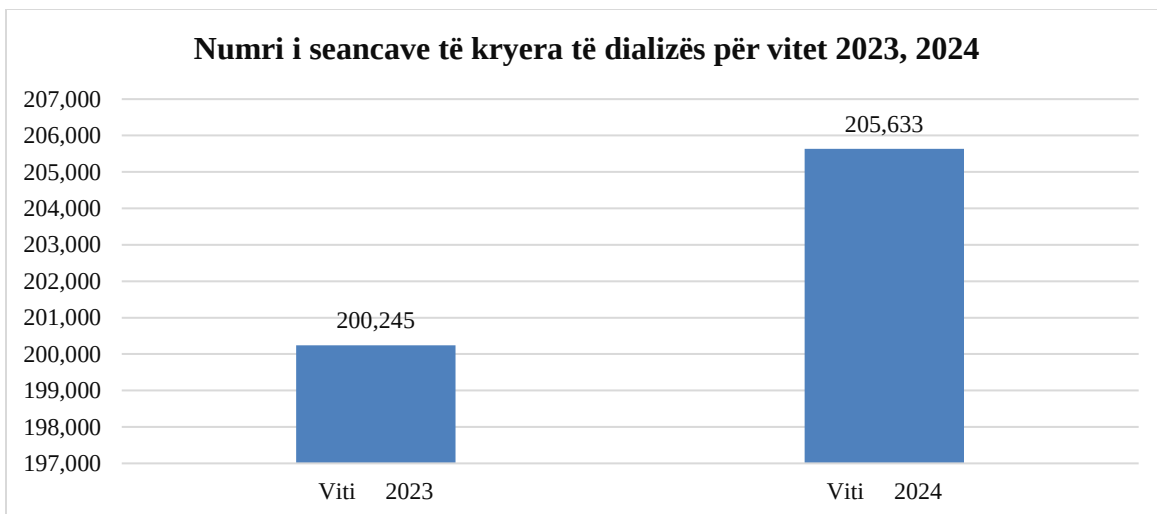
Monitorimi dhe analizimi i paketave shëndetësore nga institucionet shëndetësore publike dhe private të kontraktuara dhe të financuara nga Fondi bëhet në zbatim të Vendimit Nr. 308, datë 21.05.2014, “Për miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në shërbimin spitalor”, i ndryshuar. Gjatë vitit 2024 institucionet shëndetësore publike, private dhe shoqëria konçesionare, të kontraktuara nga Fondi, kanë ofruar shërbimet për ofrimin e paketave shëndetësore pacientëve.

Paketa e Dializës

Shërbimi i paketës së dializës është ofruar nga 1 spital publik, 8 institucione shëndetësore jopublike dhe 1 PPP (Shoqëria Tregtare DiaVita Sh.p.k.).

Numri total i pacientëve që janë trajtuar me dializë në institucionet shëndetësore publike dhe jopublike në muajin Dhjetor 2024 është 1,506 pacientë, nga të cilët 884 pacientë në spitalet jopublike, ose 58.7%, 114 pacientë në spitalet publike, ose 7.6% dhe 508 pacientë, ose 33.7% në 5 qendrat e dializës të Shoqërisë Tregtare “Dia Vita Sh.p.k.” (PPP).

Në vitin 2024 nga institucionet shëndetësore publike dhe private të kontraktuara nga Fondi për ofrimin e shërbimit të hemodializës u kryen 205,633 seanca hemodialize në total, nga të cilat 9,544 seanca nga institucionet shëndetësore publike, 126,261 seanca nga institucionet shëndetësore jopublike, si dhe 69,828 seanca dialize nga kontrata me PPP (konçesionari “DiaVita Sh.p.k.”).



Paketat e Kardiologjisë

Shërbimi për Paketat Shëndetësore të Kardiologjisë është mbuluar nga:

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, e cila ka kryer numrin më të madh të procedurave mjekësore, Qendra Spitalore Rajonale, Tiranë "Shefqet Ndroqi", Spitali Memorial Fier, si dhe Spitali Rajonal Shkodër .

Në paketat e kardiologjisë përfshihen këto procedura mjekësore:

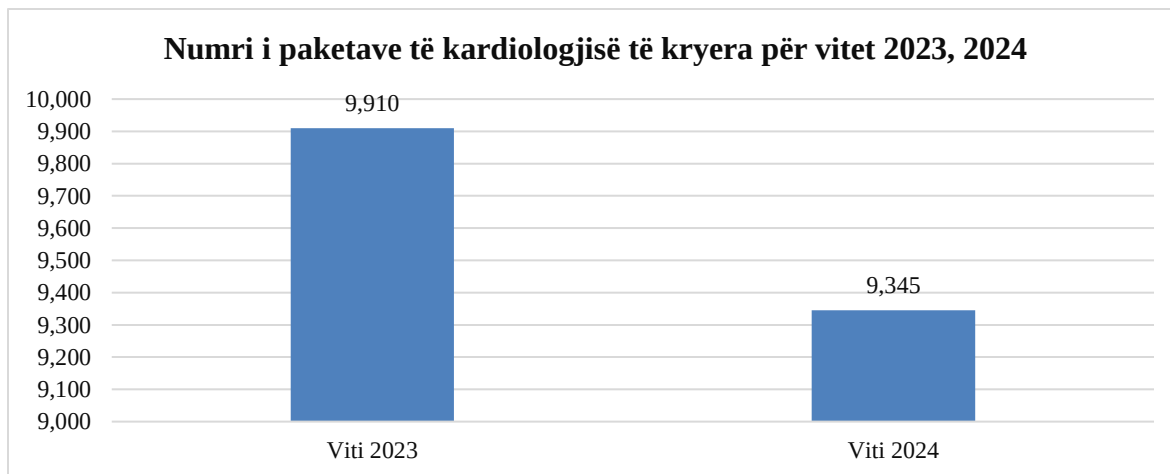
- Pacemaker definitiv
- Angiografi koronare
- Angioplastikë koronare (PCA)
- Angiografi + Angioplastikë

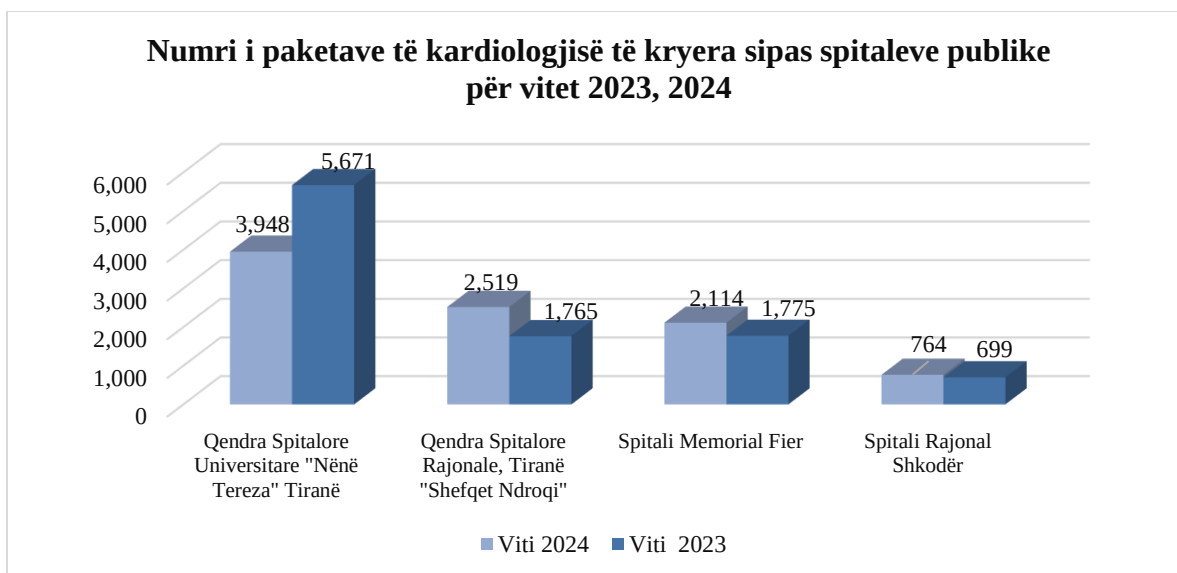
Theksojmë se edhe gjatë vitit 2024 shërbimi i kardiologjisë në QSUNT për procedurat e mësipërme, është ofruar në 24 orë, duke përmirësuar ndjeshëm ofrimin e shërbimit shëndetësor për pacientët.

Për vitin 2024 janë kryer në total 9,345 procedura të kardiologjisë, të cilat janë kryer të gjitha në spitalet publike. Të gjitha nevojat janë mbuluar 100 % nga spitalet publike.

Paketat shëndetësore të kardiologjisë të realizuara sipas paketave shëndetësore për periudhën Janar-Dhjetor 2024 paraqiten si më poshtë:

a-Pacemaker definitive	591 paketa
b-Angiografi koronare	5,082 paketa
c-Angioplastika koronare	174 paketa
d-Angiografi + Angioplastikë	3,498 paketa





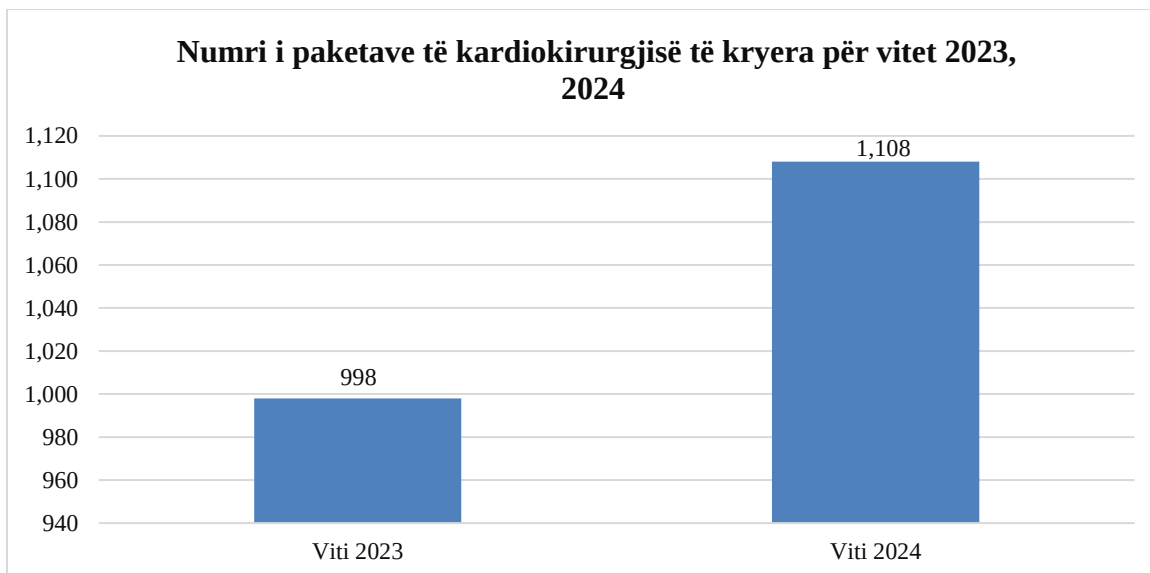
Paketa e Kardiokirurgjisë

Shërbimi për paketat shëndetësore të Kardiokirurgjisë për vitin 2024, është mbuluar nga Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë dhe Qendra Spitalore Rajonale, Tiranë "Shefqet Ndroqi".

Në paketat e kardiokirurgjisë përfshihen këto procedura mjekësore:

- 1 By Pass aorto koronar
 - 1.1. By Pass + Plastikë e Valvulës
 - 1.2. By Pass + Zëvendësim me Valvul Mekanike
 - 1.3. By Pass + Zëvendësim me Valvul Biologjike
2. Valvular
 - 2.1. Mono Valvular me Protezë Mekanike
 - 2.2. Mono Valvular me Protezë Biologjike
 - 2.3. BI Valvular me Protezë Mekanike
 - 2.4. BI Valvular me Protezë Biologjike
3. Interventi Kongenital

Për vitin 2024, janë kryer 1,108 procedura mjekësore, të cilat janë kryer të gjitha në institucionet shëndetësore publike, përkatësisht 751 procedura janë kryer në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, ose 67.77 % dhe 357 procedura janë kryer në Qendrën Spitalore Rajonale, Tiranë "Shefqet Ndroqi", ose 32.23 %.



Paketa e Transplantit Renal të Veshkës dhe Paketa e Terapisë së Flakjes Akute

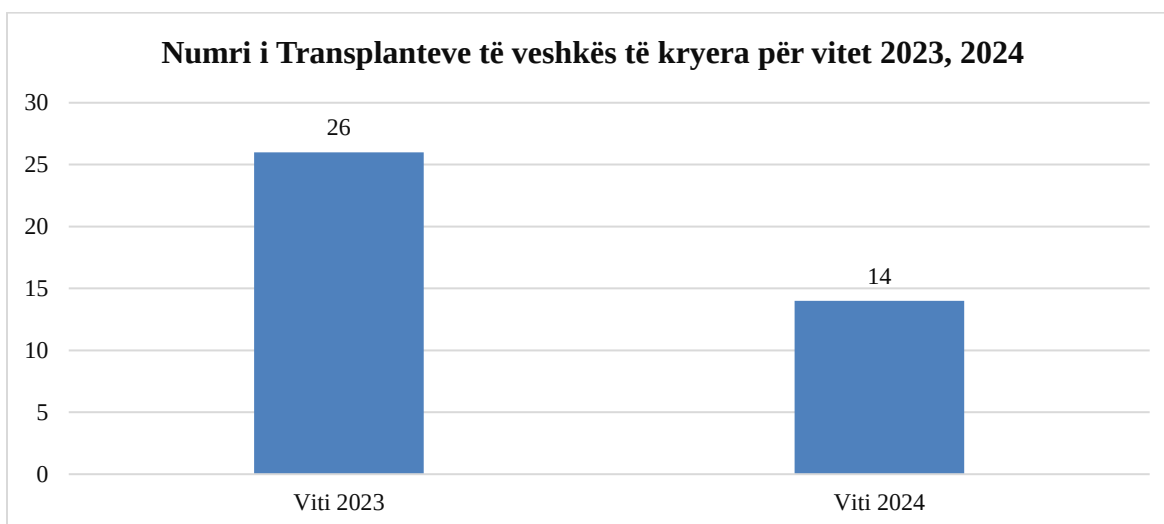
Paketa e Transplantit Renal të Veshkës dhe Paketa e Terapisë së Flakjes Akute është mbuluar nga institucionet shëndetësore jopublike të kontraktuara me Fondin.

Gjatë vitit 2024, janë kryer gjithsej 14 transplante dhe asnjë procedurë e terapisë së flakjes akute të veshkës nga të cilat:

7 transplante renale janë kryer në spitalin jopublik “Amerikan”;

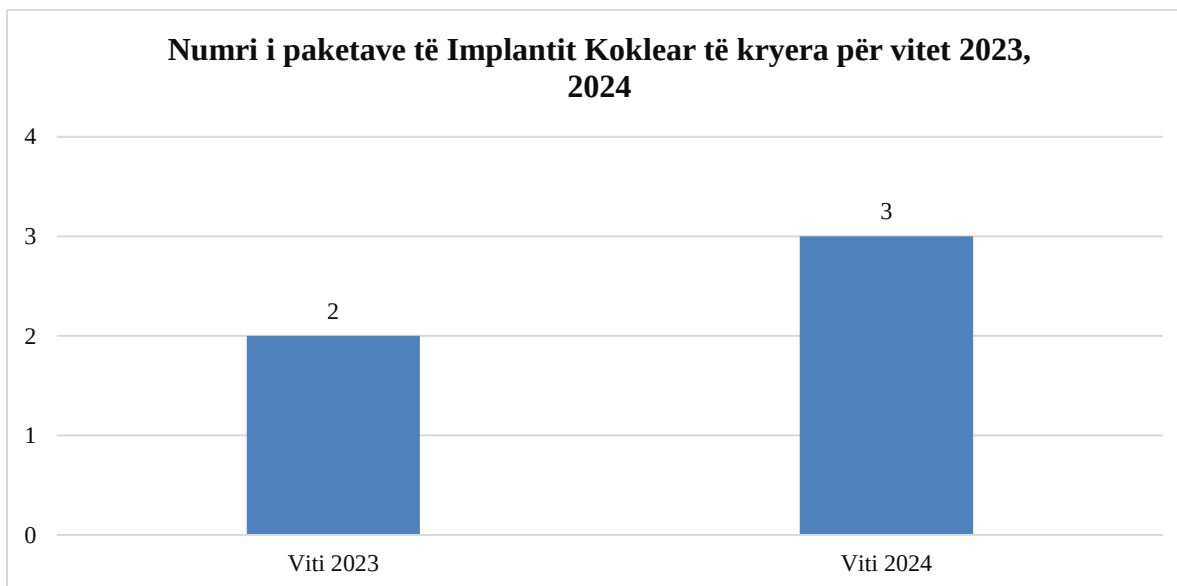
7 transplante renale janë kryer në spitalin jopublik “Hygeia”.

Në spitalet universitare publike nuk ofrohet ende paketa e transplantit të veshkës dhe paketa e terapisë së flakjes akute të veshkës.



Paketa e Implantit Koklear

Paketa e Implantit Koklear gjatë vitit 2024 është ofruar nga Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë. Gjatë vitit 2024, janë realizuar 3 paketa të implantit koklear në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë.

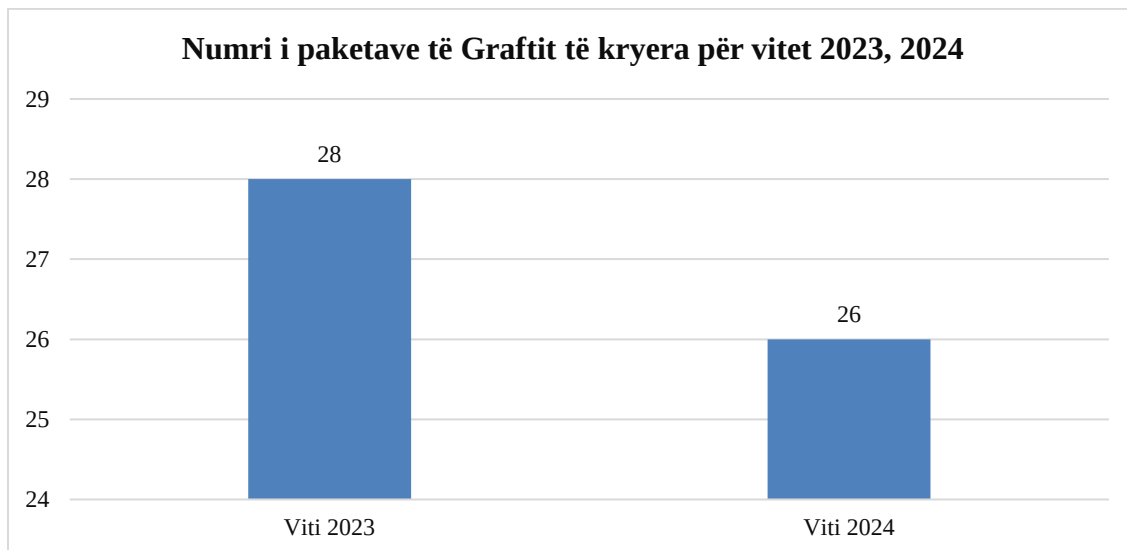
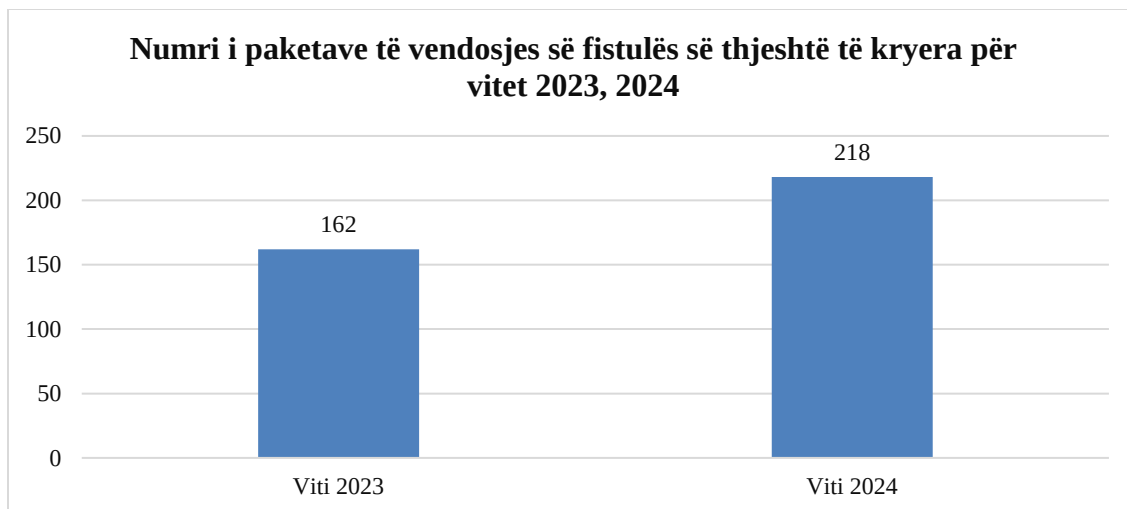


Paketa e vendosjes së Fistulës dhe Graftit

Paketa e vendosjes së Fistulës dhe Graftit të pacientëve të dializës për vitin 2024 është ofruar nga Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, si dhe spitali jopublik “Amerikan 1” e spitali jopublik “Hygeia”.

Gjatë vitit 2024 janë realizuar në total 218 vendosje fistule, nga të cilat në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, janë vendosur 103 fistula, në spitalin jopublik “Amerikan” janë vendosur 50 fistula dhe në spitalin jopublik “Hygeia” janë vendosur 65 fistula.

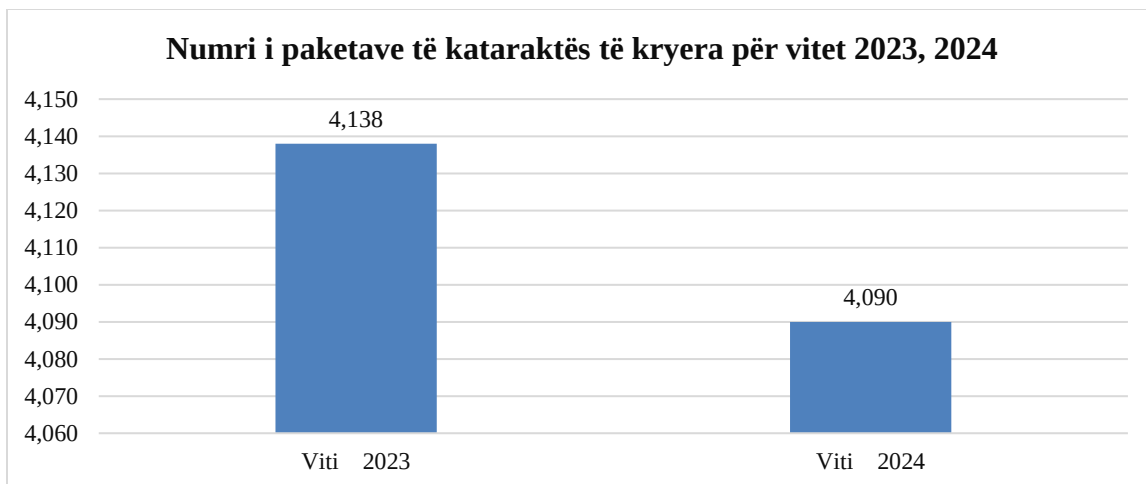
Gjithashtu në pacientët e dializës në vitin 2024 janë vendosur gjithsej 26 grafte, nga të cilat 11 grafte në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, 8 grafte në spitalin jopublik “Amerikan” dhe 7 grafte në spitalin jopublik “Hygeia”.



Paketa e Kataraktës

Paketa e Kataraktës është ofruar nga spitalet publike të kontraktuar nga Fondi si Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, Spitali Universitar i Traumës, si dhe Spitalet Rajonale Fier, Vlorë, Elbasan dhe Durrës.

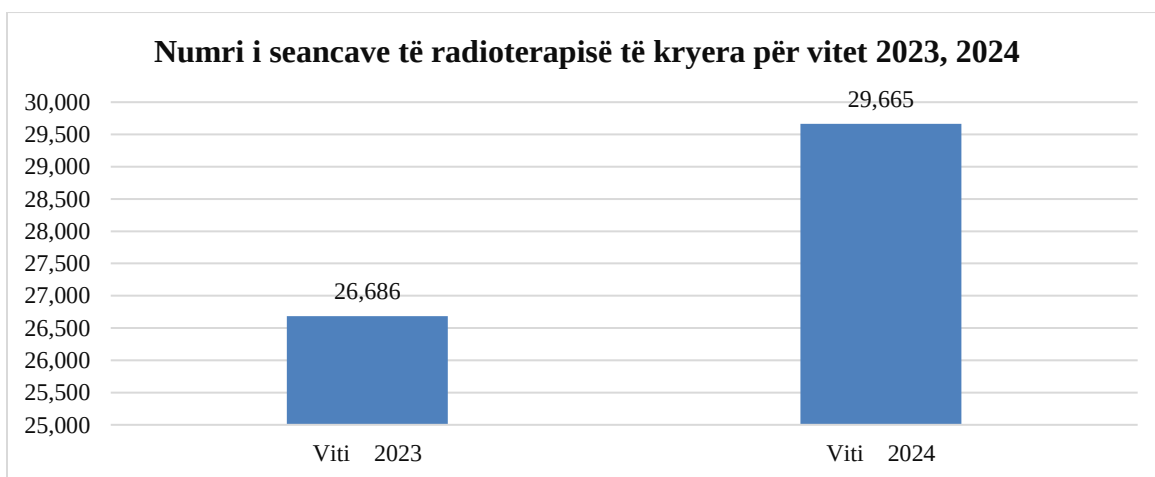
Gjatë vitit 2024 janë trajtuar në total 4,090 pacientë me paketën e kataraktës, nga të cilët në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë 3,245 pacientë, në Spitalin Rajonal Fier 87 pacientë, në Spitalin Rajonal Vlorë 343 pacientë, në Spitalin Rajonal Durrës 197 pacientë, në Spitalin Rajonal Elbasan 2 pacientë, si dhe në Spitalin Universitar të Traumës 216 pacientë.



Paketa e Radioterapisë, Trajtimi me akselerator linear

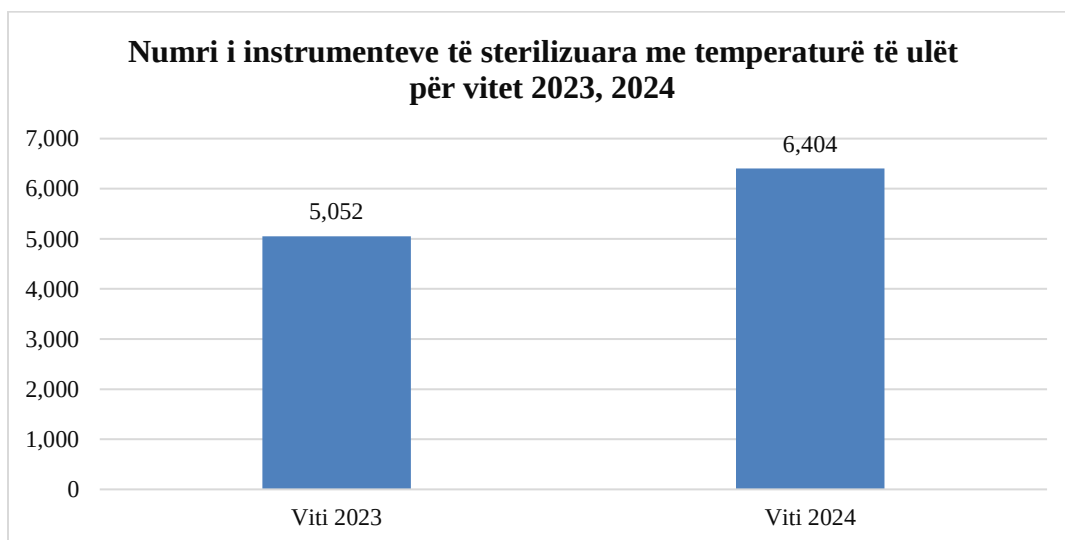
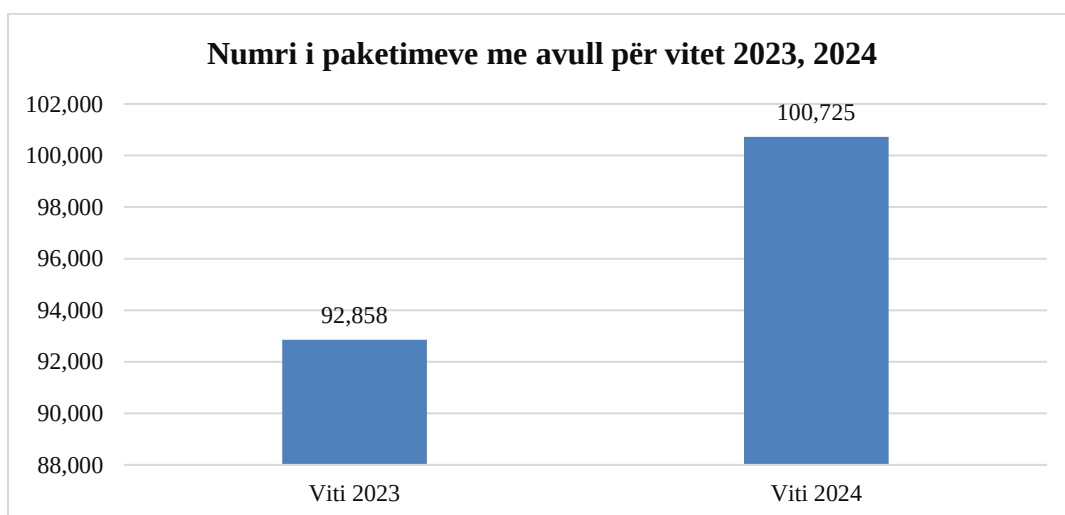
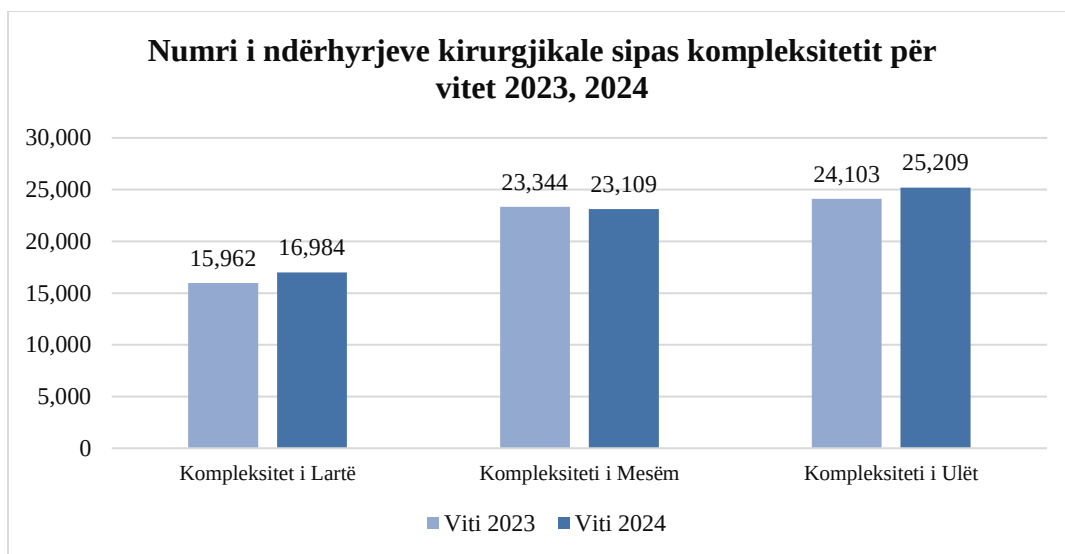
Paketat e Radioterapisë, trajtimi me akselerator linear është ofruar vetëm nga Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë. Në vitin 2024, janë realizuar gjithsej 29,665 seanca radioterapie sipas llojit të paketave të radioterapisë.

Këto paketa shëndetësore ofrohen nga Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë.



7.5 Shërbimi i sterilizimit të instrumenteve kirurgjikale

Shoqëria konçesionare “Sani Service” ka ofruar në spitalet publike shërbimet e integruara të furnizimit të setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale sterile, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve biologjike dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale.



7.6 Lista e barnave të rimbursueshme dhe e pajisjeve mjekësore të rimbursueshme

Lista e barnave të rimbursueshme dhe e pajisjeve mjekësore të rimbursueshme është një nga paketat e rëndësishme që financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

Mbi bazën e kontratave të Fondit me subjektet farmaceutike, realizohet rimbursimi i barnave, sipas Listës së Barnave të Rimbursuara dhe referuar masës së mbulimit sipas kategorive të caktuara me Vendim të Këshillit të Ministrave.

Lista e barnave të rimbursueshme e cila ka hyrë në fuqi në datën 01.08.2024 me Vendimin Nr. 491 datë 24.07.2024 të Këshillit të Ministrave është zgjeruar me 1,345 barna alternativa mjekimi në total.

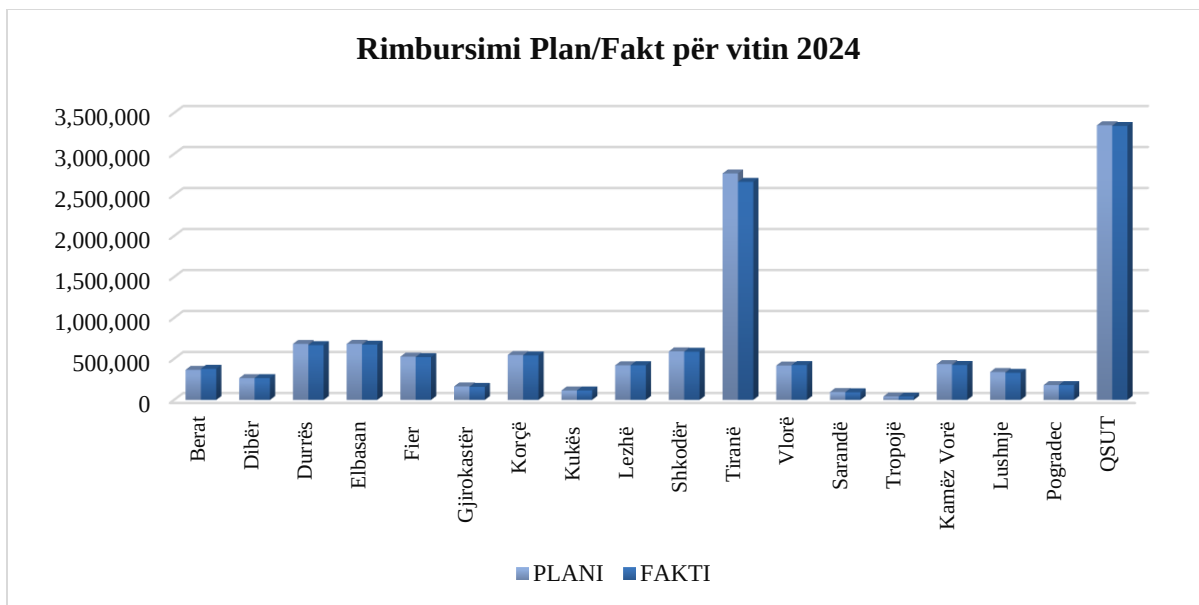
Listës i janë shtuar 50 barna të reja, nga të cilat 38 principe aktive të reja dhe 18 formë doza të reja.

Barnat e reja të shtuara në Listën e Barnave të Rimbursueshme i përkasin grupit të barnave spitalore dhe grupit të barnave ambulatorie, janë barna të cilat mbështesin akoma më shumë të gjitha diagnozat dhe patologjitë e sëmundjeve onkologjike, sëmundje kardiovaskulare, diabetin, sëmundje të veshkave, astmën bronkiale, sëmundje pulmonare, etj.

Realizimi i planit të shpenzimeve të rimbursimit:

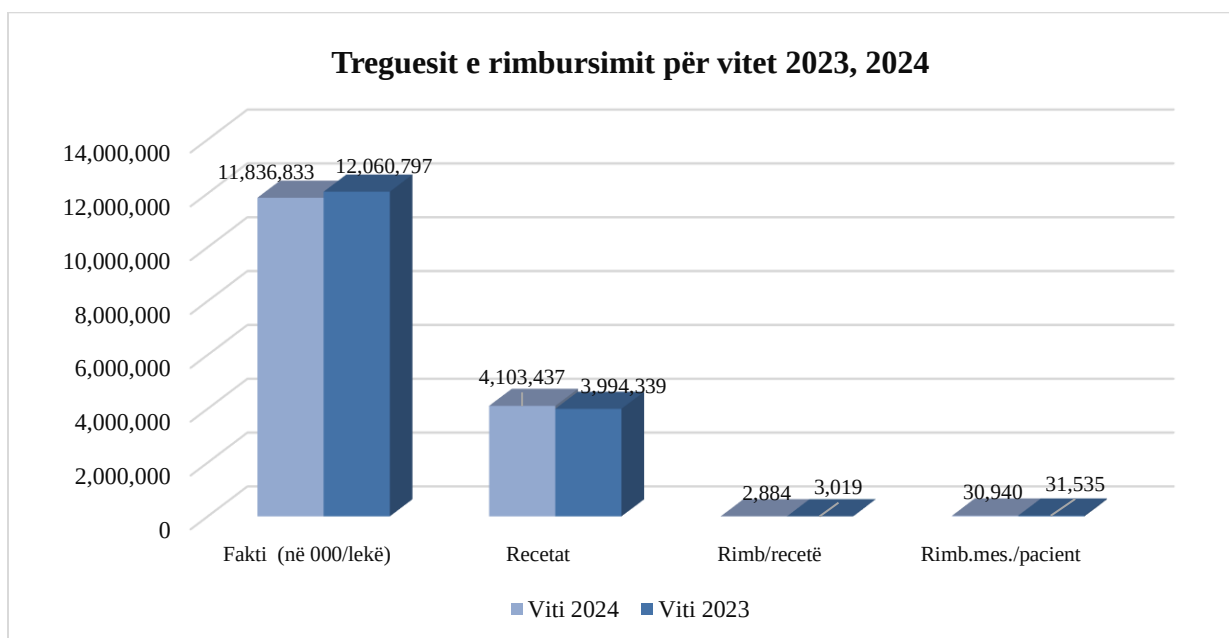
Periudha	Plani (000/lekë)	Fakti (000/lekë)	Tejkalimi (në 000/lekë)	Realizimi në %
Viti 2024	12,000,000	11,836,833	-163,167	98.6%

Shpenzimet e rimbursimit për vitin 2023 rezultojnë në vlerën 11,836,833 mijë lekë, rreth 163.2 milion lekë më pak se plani, rreth 1.4 % më pak se plani.



Situata e shpenzimeve të rimbursimit në nivel Fondi e krahasuar me rimbursimin e vitit 2024 dhe vitit 2023:

Periudha	Fakti (në 000/lekë)	Recetat	Rimb/recetë	Rimb.mes./pacient
Viti 2024	11,836,833	4,103,437	2,884	30,940
Viti 2023	12,060,797	3,994,339	3,019	31,535



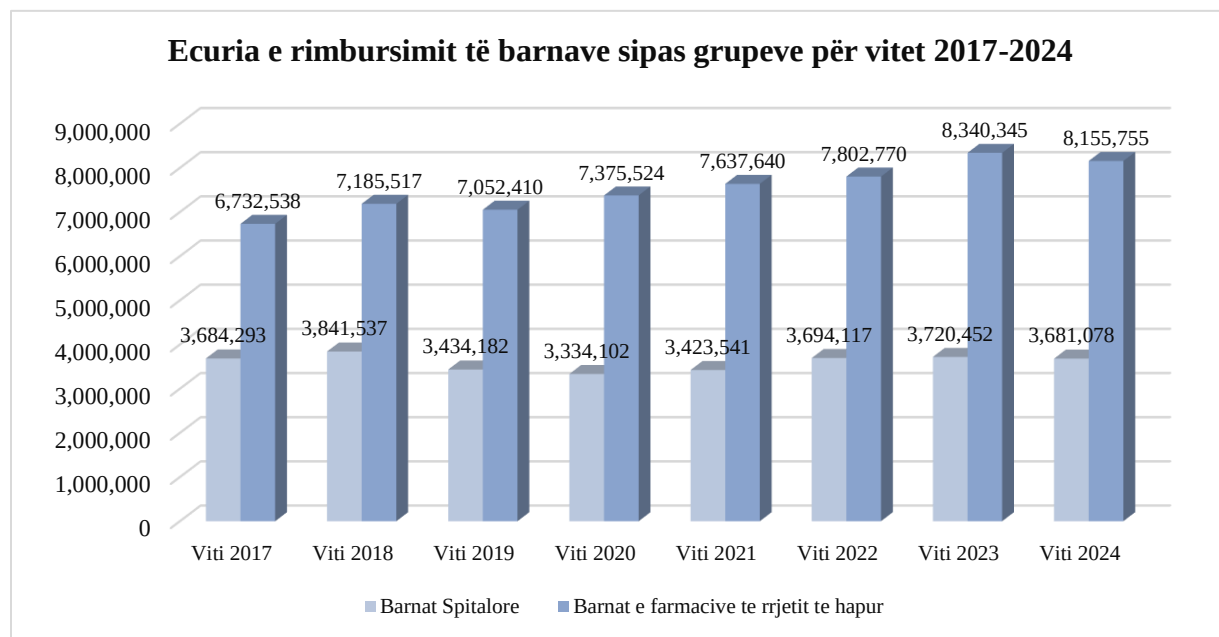
Nga të dhënat konstatohet se:

- ✓ Për vitin 2024 krahasuar me vitin 2023, shpenzimet e rimbursimit janë ulur me **223.9 milion lekë** më pak.
- ✓ Vlera mesatare e recetës është ulur me **135 lekë më pak**.
- ✓ Numri i recetave të rimbursuara është rritur me **109,098 receta më shumë**.
- ✓ Vlera e rimbursimit për pacient është ulur me **595 lekë** më pak se një vit më parë.

Ulja e shpenzimeve të rimbursimit, në krahasim me 1 vit më parë ka ardhur si pasojë e zbatimit të përcaktuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 491, datë 24.07.2024 “Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen dhe masën e mbulimit të tyre”, hyrë në fuqi më datë 01.08.2024.

Në tabelën e mëposhtme paraqitet ecuria e shpenzimeve të rimbursimit gjatë viteve të fundit, e ndarë sipas barnave spitalore dhe barnave që tregtohen në rrjetin e hapur farmaceutik, paraqitur në mijë lekë:

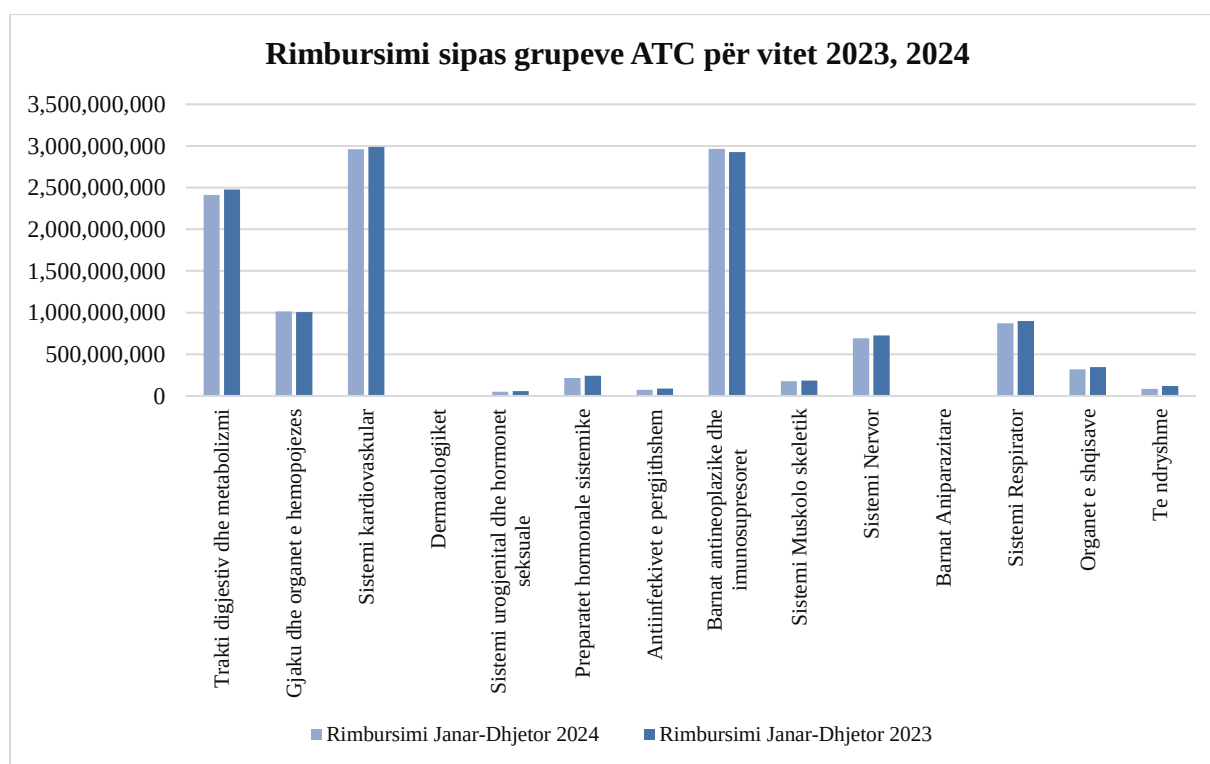
Grupet e barnave të LBR	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024
Barnat Spitalore	3,684,293	3,841,537	3,434,182	3,334,102	3,423,541	3,694,117	3,720,452	3,681,078
Barnat e farmaceutike të rrjetit të hapur	6,732,538	7,185,517	7,052,410	7,375,524	7,637,640	7,802,770	8,340,345	8,155,755
Barnat në total	10,416,831	11,027,054	10,486,592	10,709,626	11,061,181	11,496,887	12,060,797	11,836,833
% e barnave Spitalore ndaj totalit	35	34.8	32.7	31.1	30.95	32.1	30.8	31



Nga tabela dhe grafiku i mësipërm evidentohet se, gjatë Vitit 2024 ka një *ulje të shpenzimeve të rimbursimit për grupin e barnave spitalore* dhe si përqindje ndaj shpenzimeve totale të rimbursimit evidentohet një rritje gjatë këtij viti me 0.2%. Konkreisht për vitin 2024 shpenzimet e rimbursimit për barnat spitalore zënë rreth 31%, ndërsa një vit më parë zinin rreth 30.8 % të shpenzimeve totale të rimbursimit.

Shpenzimet e rimbursimit sipas grupeve ATC (anatomik, terapeutik, kimik) të barnave

Krahasimi grafik i ecures së rimbursimit sipas grupeve ATC për vitet 2023, 2024:

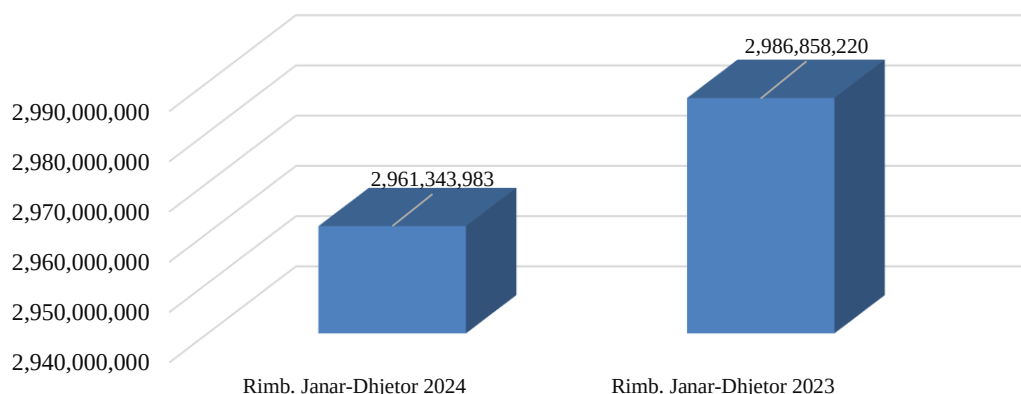


Krahasuar me vitin 2023, ulja e shpenzimeve të rimbursimit ka ardhur për shkak se grupet me impakt te lartë financiar kanë ulje të vlerës së rimbursimit.

Ulja më e madhe në shpenzimet e rimbursimit vërehet në grupet e mëposhtme:

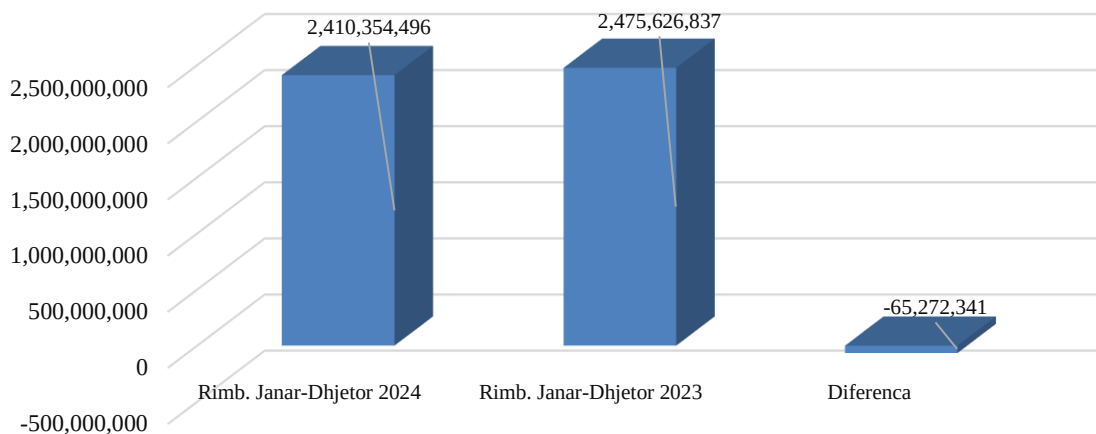
- Barnat e grupit C “Sistemi Cardiovascular” me rreth 25.5 milion lekë më pak se në vitin 2023. Për vitin 2024 grupi C, zë 24.2% të shpenzimeve të rimbursimit. Tek ky grup ulja më e madhe krahasuar me vitin 2023 konstatohet te barnat e nëngrupit të “*Barnat vepruese në Sistemin Renin-Angiotensin*”.

Shpenzimet e rimbursimit (mijë lekë) për grupin C "Sistemi kardiovaskular" për vitet 2023, 2024



- Grupi A “Trakti digjestiv dhe metabolizmi” me 65.2 milion lekë më pak, i cili zë rreth 20.3% të shpenzimeve totale të rimbursimit krahasuar me 18.5% që zinte vitin e kaluar se e njëjta periudhë. Nëngrupi me peshën specifike më të madhe është nëngrupi i “*Antidiabetikëve*” të cilët zënë 97 % të shpenzimeve të gjithë grupit A, (grupi i insulinave).

Shpenzimet e rimbursimit (mijë lekë) për grupin A "Trakti digjestiv dhe metabolizmi" për vitet 2023, 2024

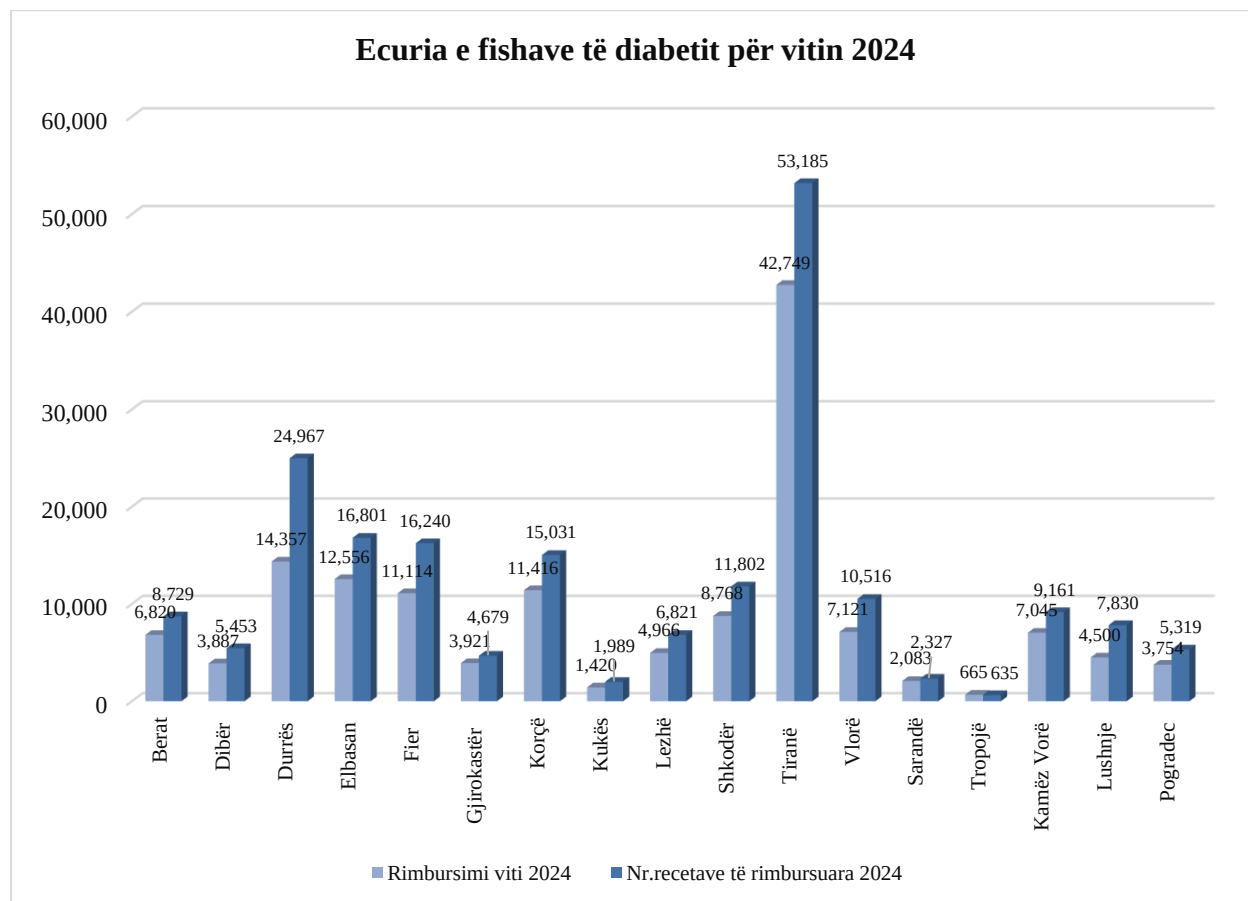


Ecuria e shpenzimeve të fishave të diabetit

Duke filluar nga data 27.02.2023, Fishat e Diabetit rimbursohen në të gjithë farmacitë e rrjetit të hapur farmaceutik, të cilat kanë kontratë me Drejtoritë Rajonale të Fondit.

Fishat e diabetit përshkruhen në recetat elektronike të rimbursuara nga mjekët e familjes për të gjithë pacientët, të cilët i përkasin dy kategorive të veçanta. Konkretisht, kategoria “Diabetike 0-25 vjeç” si dhe kategoria “Diabetike mbi 65 vjeç”.

Përveç grupmoshës nga 0 deri në 25 vjeç dhe pensionistëve mbi 65 vjeç, në zbatim të VKM Nr.492, datë 24.07.2024 “Për një ndryshim në vendimin Nr.61 datë 03.02.2017 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e paketave të pajisjeve mjekësore"” edhe invalidët e punës dhe personat me aftësi të kufizuar të grupmoshës nga 25 vjeç deri në 65 vjeç i përfitojnë 100% falas këto fisha. Duke filluar nga data 1 Gusht 2024, këto kategori të popullatës të diagnostikuar me Diabet Mellitus nga mjeku i familjes, përfitojnë falas fishat e diabetit për matjen e glicemisë.



Vlera e rimbursuar për fishat e diabetit për periudhën Janar-Dhjetor 2024 është rreth 147.1 milion lekë për pacientët me Diabet Mellitus që i përkasin katër kategorive të sipërcituara.

Rimbursimi sipas kategorive të popullsisë për vitin 2024 krahasuar me vitin 2023

Emërtimi i kategorisë	Rimbursimi 2024	Rimbursimi 2023	Diferenca	Nr. i recetave 2024	Nr. i recetave 2023	Diferenca	Nr. i Pacienteve	Nr. i Pacienteve	Diferenca	Treguesi Rimb. per recetë/lek 2024	Treguesi Rimb. per recetë/lek 2023	Diferenca
Femije 0-12 muajsh	267	189	78	204	212	-8	112	152	-40	1,308	892	416
Invalid i plote	1,898,725	1,946,365	-47,640	495,876	483,072	12,804	35,627	35,595	32	3,829	4,029	-200
Invalid i pjesshem	1,955	1,927	29	936	966	-30	207	190	17	2,089	1,995	95
Invalid lufte	142	213	-72	63	108	-45	8	9	-1	2,253	1,977	276
Veteran	16,591	21,849	-5,259	5,952	7,829	-1,877	395	519	-124	2,787	2,791	-3
Pensionist pa afat	5,691,848	5,561,150	130,698	2,467,594	2,373,281	94,313	209,701	208,633	1,068	2,307	2,343	-37
Paafte menderisht ose fizikisht	73,548	91,130	-17,581	24,050	26,742	-2,692	3,508	3,679	-171	3,058	3,408	-350
Leje lindje/ Raport Mjekesor	48	161	-113	34	70	-36	19	24	-5	1,410	2,299	-889
Sigurim vullnetar	287	150	137	209	114	95	89	23	66	1,375	1,319	56
I verber	4,187	5,420	-1,232	1,583	2,038	-455	184	251	-67	2,645	2,659	-14
IEVP	11,626	12,767	-1,141	11,356	11,178	178	2,532	2,672	-140	1,024	1,142	-118
Pension social	42,507	69,827	-27,320	24,531	30,709	-6,178	2,861	3,730	-869	1,733	2,274	-541
Student 18-25 vjec	404	532	-128	116	178	-62	57	76	-19	3,480	2,988	492
Ndihme ekonomike	13,382	11,091	2,290	12,108	9,584	2,524	3,588	2,826	762	1,105	1,157	-52
Grua shtatzene	126	333	-207	28	52	-24	16	31	-15	4,493	6,408	-1,915
Azilkerkues	7,530	9,621	-2,090	2,471	2,494	-23	380	311	69	3,047	3,858	-810
Viktme trafikimi	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2,009	0	2,009
I punesuar	28,995	27,371	1,624	21,949	19,004	2,945	6,333	4,730	1,603	1,321	1,440	-119
I vetepunesuar	2,186	3,114	-928	1,677	2,111	-434	499	734	-235	1,303	1,475	-172
Femije 1-18 vjec	171,019	203,208	-32,189	22,151	24,195	-2,044	5,498	6,636	-1,138	7,721	8,399	-678
I papune/punekerkes	326	2,962	-2,635	416	3,041	-2,625	234	1,064	-830	784	974	-190
Te permdjekur politike	571	634	-63	174	262	-88	29	67	-38	3,282	2,421	861
Pension me afat	2,305	3,358	-1,053	2,075	2,347	-272	533	529	4	1,111	1,431	-320
Perfitues te tjere nga ISSH	148	199	-51	82	121	-39	16	19	-3	1,804	1,644	161
Anetar i papaguar i familjes	561	57	504	668	56	612	284	25	259	840	1,016	-176
I vetpunesuar ne bujqesi	7	283	-276	8	195	-187	5	46	-41	846	1,450	-604
Invalid i pjesshem jashte kategorie	110	412	-302	115	312	-197	37	94	-57	957	1,320	-363
Semundje Kronike	3,861,402	4,077,059	-215,657	1,005,417	992,361	13,056	112,068	109,482	2,586	3,841	4,108	-268
Invalid/Tetraplegjik	5,920	8,965	-3,045	1,570	1,606	-36	232	210	22	3,771	5,582	-1,812
Persona te diagnostikuar me Sars-Cov2	107	447	-341	23	101	-78	22	99	-77	4,641	4,430	211
Total Barna	11,836,833	12,060,797	-223,964	4,103,437	3,994,339	109,098	385,075	382,456	2,619	2,885	3,019	-135
Diabetik 0-25 vjec	4,400	4,687	-287	3,546	2,833	713	595	599	-4	1,241	1,654	-413
Diabetik > 65 vjec	141,396	113,699	27,697	196,006	170,098	25,908	55,939	54,793	1,146	721	668	53
Diabetik Invalid i punes (25- 65) vjec	989	0	989	1,411	0	1,411	687	0	687	701	0	701
Diabetik I paafte menderisht ose fizikisht (25- 65) vjec	356	0	356	522	0	522	290	0	290	683	0	683
Total Fisha	147,141	118,385	28,756	201,485	172,931	28,554	57,511	55,392	2,119	730	685	46
TOTAL	11,983,974	12,179,181	-195,207	4,304,922	4,167,270	137,652	442,586	437,848	4,738	3,615	3,704	-89

Nga krahasimi i treguesve të rimbursimit të vitit 2024 me treguesit e një viti më parë konstatohet se ulje totale e shpenzimeve të rimbursimit prej rreth 223.9 milion lekë, ka ardhur për shkak të uljes tek disa kategori të veçanta dhe uljes se vlerës mesatare për receta me 89 lekë më pak, ku specifikojmë:

- Sëmundje kronike – me një ulje prej 215.6 milion lekë më pak se viti paraardhës ose rreth 96.4% e uljes totale të shpenzimeve. Për këtë kategori është rritur numri i recetave të rimbursuara me 13,056 receta më shumë dhe është ulur vlera mesatare për receta me 268 lekë.
- Pensionist pa afat - me një rritje prej 130.6 milion lekë më shumë se viti paraardhës, shoqëruar me 94,313 receta më shumë, është ulur vlera mesatare për recetës 37 lekë dhe janë trajtuar 1,068 pacientë më shumë, krahasuar me vitin 2023.
- Fishat e diabetit përshkruhen në recetat elektronike të rimbursuara nga mjekët e familjes për të gjithë pacientët, të cilët i përkasin dy kategorive të veçanta; *kategoria Diabetike 0-25 vjeç si dhe kategoria Diabetike mbi 65 vjeç (për vitin 2023 deri më 31.07.2024).*

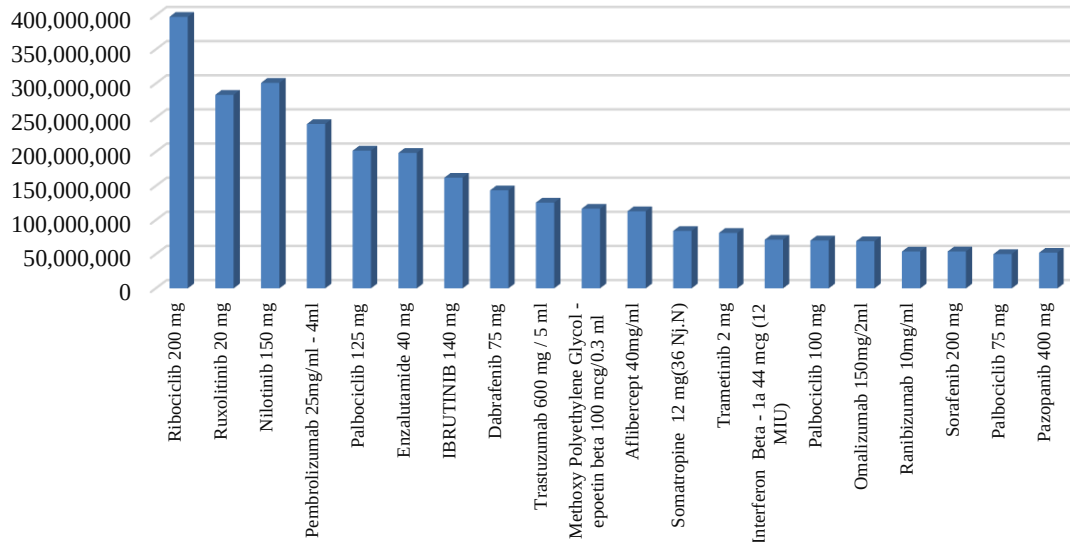
Në zbatim të VKM Nr.492, datë 24.07.2024 „Për një ndryshim në vendimin Nr.61 datë 03.02.2017 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e paketave të pajisjeve mjekësore", ndryshohet pika 9.1 e Vendimit Nr.61, në të cilën shtohen dy kategori të reja përfituese, konkretisht: „Diabetik Invalid i punës 25- 65 vjeç“, „Diabetik i paaftë mendërisht ose fizikisht 25- 65 vjeç“.

Vlera e rimbursuar për fishat e diabetit për periudhën Janar-Dhjetor 2024 është rreth 147.1 milion lekë, duke përfituar rreth 57,511 pacientë që i përkasin katër kategorive të sipërcituara.

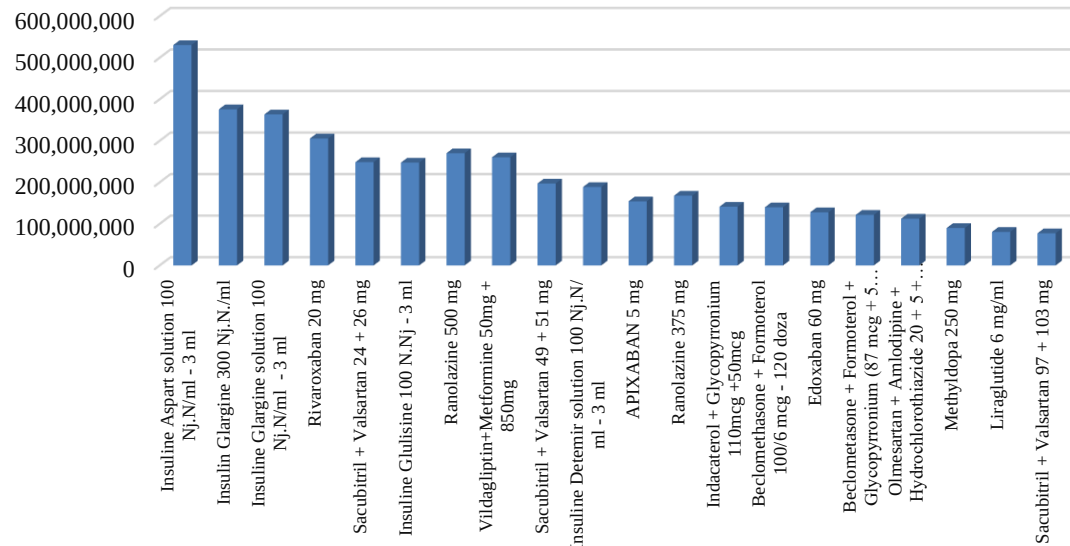
Identifikimi i barnave me impaktin më të lartë në shpenzimet e rimbursimit

- Për vitin 2024, 20 barnat spitalore me impaktin më të lartë financiar kanë shpenzime rimbursimi në vlerë rreth 2.8 miliardë lekë duke zënë rreth 23.3% të shpenzimeve totale të rimbursimit.
- Ndërsa 20 barnat ambulatorie me impaktin më të lartë financiar kanë shpenzime rimbursimi në vlerë rreth 4.2 miliard lekë duke zënë rreth 35 % të shpenzimeve totale të rimbursimit.
- Bari spitalor me rimbursimin më të lartë është Ribociclib 200 mg.
- Bari ambulator me rimbursimin më të lartë është Insuline Aspart solution 100 Nj.N/ml.

Rimbursimi i Top 20 barnave spitalore për vitin 2024



Rimbursimi i Top 20 barnave të rrjetit të hapur për vitin 2024



8. Zhvillimi i sistemit të informacionit

8.1 Sistemi elektronik për formularët e vizitave të mjekut të familjes

Ky projekt mundëson raportimin online të vizitave të pacientëve pranë mjekëve në Qendrat Shëndetësore e Poliklinikat.

Në vijim të zbatimit të kontratës me objekt “Regjistri elektronik për formularët e vizitave të mjekut të familjes”, me Nr. 1381 Prot., datë 18.03.2019, Fondi në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Shqërisë së Informacionit ka zhvilluar një sistem informatik për regjistrimin e vizitave të pacientëve në shërbimin parësor.

Projekti konsiston në:

- Zbatimin e sistemit e-vizita për regjistrimin, administrimin dhe përpunimin e vizitave të pacientëve online nga ofruesit e kujdesit shëndetësor parësor që raportojnë pranë FSDKSH dhe MSHMS.

Avantazhet e regjistrimit të vizitave në sistemin e ri:

- Evitohet regjistrimi manual i vizitave në formularët letër nga mjekët e Kujdesit Shëndetësor Parësor.
- Ndërvepron me sistemet e tjera elektronike dhe rrit saktësinë e të dhënave që regjistrohen.
- Tashmë në sistem ruhet historiku i vizitave dhe informacionit shëndetësor të pacientit (shenjat jetësore, alergjitë, etj).
- Raporte në kohë reale të qendëruara mbi të dhënat, të cilat shërbejnë për vendim-marrje klinike, menaxheriale dhe administrative.

Portali i mjekut të familjes dhe moduli “Single Sign On” bën të mundur akses te:

- Sistemi i Regjistrimit Elektronik i të Siguruarve (AHIS);
- Sistemi i Formularit të Vizitës (SISHP);
- Sistemi i Referimit Online (e-Referimi);
- Sistemi i Recetës Elektronike (e-Rx);
- Sistemi i Raportit Elektronik (e-RM).

Ky modul lehtëson punën e ofruesve të kujdesit shëndetësor parësor në aksesimin e disa sistemeve informatike njëherësh me një logim të vetëm.

Në zbatim të kontratës Nr. 3, datë 28.02.2022 dhe të kontratës Nr. 107, datë 08.10.2024 me objekt: “Mirëmbajta e sistemit formularët e vizitave të mjekut të familjes” gjatë viteve 2023, 2024 ka vijuar përdorimi i sistemit e-vizita në plotësimin e formularëve përkatës të vizitave nga stafi mjekësor. Më konkretisht stafi që plotëson aktualisht formularë vizite paraqitet si më poshtë:

			Staf që plotëson formular vizite	
DRF/DF	Numri i Agjencie	Numri i QSH	Mjekë	Infermierë
Berat	3	21	98	555
Dibër	3	28	77	535
Durrës	3	32	353	712
Elbasan	4	46	251	889
Fier	2	23	162	438
Gjirokastrë	3	18	79	411
Kamëz-Vorë	1	8	131	192
Korçë	3	25	113	582
Kukës	2	16	50	236
Lezhë	3	18	125	402
Lushnje	1	17	84	256
Pogradec	1	8	49	214
Sarandë	1	13	42	144
Shkodër	3	31	179	678
Tiranë	1	27	697	1,028
Tropojë	1	8	19	131
Vlorë	1	17	149	443

Gjatë vitit 2023, janë bërë përditësime të sistemit e-vizita dhe të webservice-ve të tij, në kuadër të vënies në punë të sistemit të përmirësuar AHIS për të mundësuar aksesimin e sistemit AHIS të ri, nëpërmjet portalit të mjekut me SSO. Gjithashtu, janë shtuar disa raporte të reja dhe janë përmirësuar raporte ekzistuese sipas kërkesave, si dhe është mundësuar në sistem regjistrimi i vizitave të banorëve tek mjeku i familjes kur banori referohet tek psikologu/punonjësi social.

Gjatë vitit 2024 është realizuar në sistemin e-vizita digjitalizimi i 6 mjeteve për vendim-marrje klinike. Janë kryer përditësime të ndërveprimit të sistemit me sistemin e ri AHIS, janë shtuar disa raporte të reja dhe janë përmirësuar raporte ekzistuese sipas kërkesave.

8.2 Përditësim i sistemit të menaxhimit të Depove Farmaceutike

Ky projekt i realizuar në vitin 2019 mundëson raportimin online të depove farmaceutike mbi qarkullimin e barnave të Listës së Barnave të Rimbursueshme midis distributorëve të ndryshëm, duke mundësuar shmangien e fiktivitetit.

Në zbatim të kontratave të shërbimit me Nr. 8358 Prot., datë 06.12.2021 dhe me Nr 98 Prot, datë 10/06/2024 me objekt “Mirëmbajtje e sistemit të depove farmaceutike (e-Depo) për FSDKSH”, gjatë viteve 2023 dhe 2024, ka vijuar përdorimi i këtij sistemi, si i vetmi sistem zyrtar i njohur nga Fondi, i cili përdoret nga rreth 65 depo farmaceutike.

Gjatë vitit 2023, me hyrjen në fuqi të VKM-së për rimbursimin e fishave të diabetit për kategorinë Diabetikë mbi 65 vjeç, është realizuar procesi i inventarizimit të këtyre pajisjeve mjekësore në sistemin e-depo, si dhe transaksionet hyrje-dalje midis depove farmaceutike dhe farmaceve të rrjetit të hapur, të kontraktuara me Fondin për rimbursimin e fishave të diabetit.

Sistemi e-Depo mundëson një pasqyrë të konsoliduar të informacionit mbi inventarin e depove farmaceutike për barnat e rimbursueshme dhe fishat e diabetit të rimbursueshme, duke trajtuar gjendjen e inventarit, fletë hyrjet nga importi si dhe fletë daljet drejt depove të tjera shpërndarëse apo subjekteve farmaceutike.

8.3 Sistemi i recetës elektronike

Gjatë vitit 2023, FSDKSH në bashkëpunim me AKSHI-n ka vijuar me mirëmbajtjen e sistemit të recetës elektronike. Në zbatim të kontratës me Nr. 3497 Prot., datë 21.05.2021, me qëllim përmirësimin e shërbimeve publike është realizuar në sistemin e recetës elektronike integrimi i teknologjisë së re të nënshkrimit elektronik nëpërmjet platformës së nënshkrimit elektronik të zhvilluar nga AKSHI. Ky sistem përdoret nga rreth 1,800 mjekë dhe rreth 1,600 farmacistë të cilët gjenerojnë, ekzekutojnë dhe nënshkruajnë elektronikisht receta me rimbursim.

Gjatë vitit 2024, me hyrjen në fuqi të VKM-së Nr. 492 datë 24.07.2024 “Për një ndryshim në Vendimin nr. 61 datë 03.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e paketave të pajisjeve mjekësore të rimbursueshme”, të ndryshuar, për rimbursimin e fishave të diabetit, që do të rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Fishat e Diabetit rimbursohen në të gjitha farmacitë e rrjetit të hapur farmaceutik, të cilat kanë kontratë me drejtoritë rajonale të Fondit. Fishat e diabetit përshkruhen në recetat elektronike të rimbursuara nga mjekët e familjes për të gjithë pacientët, të cilët i përkasin kategorive të veçanta, konkretisht kategorive “Diabetik 0-25 vjeç”, “Diabetik $\geq$ 65 vjeç”, “Diabetik Invalid i punës 25 - 65 vjeç” dhe “Diabetik i paafte mendërisht ose fizikisht 25 – 65 vjeç”.

8.4 Zbatimi i sistemit eKontroll: sistemi i kontrollit të subjekteve që kanë kontratë me Fondin

Gjatë vitit 2024 është vijuar me mirëmbajtjen dhe zbatimin e sistemit e-Kontroll, i cili:

- Mundëson digjitalizimin dhe automatizimin e procesit të lidhjes së kontratës me subjektet që kanë kontratë me FSDKSH, që nga aplikimi nëpërmjet platformës e-Albania nga ana e subjektit, deri në lidhjen përfundimtare të kontratës.
- Mundëson menaxhimin elektronik të proceseve të punës për kontrollin e përmbushjeve të detyrimeve kontraktuale të subjekteve që kanë kontratë me FSDKSH.
- Përmirëson dhe garanton transparencë, si dhe monitoron aktivitetin e Drejtorisë së Kontrollit dhe sektorëve të kontrollit në zbatim të objektivave të Fondit.

- Ndihmon në përshpejtimin e procedurave për trajtimin e aplikimeve, inspektimin e subjekteve që kanë kontratë me FSDKSH dhe informimin online të këtyre subjekteve mbi statusin e aplikimit të tyre.

Në vitin 2024 Fondi ka ofruar të gjithë shërbimet nëpërmjet platformës e-Albania. Shërbimet online të ofruara gjatë vitit 2024 paraqiten si më poshtë vijon:

1. Aplikim për lidhje kontrate me Importuesit/ Shpërndarësit Farmaceutik/ Importuesit e Fishave të Diabetit.
2. Aplikim për lidhje/rilidhje kontrate me Institucionet Shëndetësore Jo Publike.
3. Aplikim për lidhje kontrate për herë të parë me Agjencitë dhe Farmacitë e rrejtit të hapur.
4. Aplikim për rilidhje kontrate me Importuesit/ Shpërndarësit Farmaceutik.
5. Aplikim për rilidhje kontrate vjetore me Agjencitë dhe Farmacitë e rrejtit të hapur

8.5 Sistemi Regjistri i të Siguruarve

Gjatë vitit 2023, në zbatim të kontratës me Nr. 53 Prot., datë 11.04.2023, me objekt "Përmirësimi i sistemit të regjistrimit të të siguruarve", në bashkëpunim me AKSHI-n dhe Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë, është realizuar implementimi i këtij sistemi, i cili ka në fokus zgjidhjen e të gjitha problematikave të mbartura dhe hasura përgjatë gjithë viteve të përdorimit të këtij sistemi, si dhe një menaxhim më të mirë të regjistrimit dhe lëvizshmërisë së banorëve.

Gjithashtu, gjatë vitit 2024, në zbatim të kontratës, ka vijuar mirëmbajtja e sistemit Regjistri i të Siguruarve (AHIS).

8.6 Përmirësimi i rrjetit të FSDKSH

Në zbatim të kontratës me Nr. 54 Prot., datë 11.04.2023 me objekt "Përmirësimi i rrjetit të FSDKSH", është realizuar përmirësimi i infrastrukturës, duke zëvendësuar pajisjet e rrjetit end-of-life dhe jofunksionale (Zyra Qendrore dhe Degët në varësi). Pajisjet e rrjetit në degët dhe zyrën qendrore janë të aksesueshme dhe monitorojnë në mënyrë të qendërzuar aktivitetin dhe disponibilitetin e shërbimeve. Sistemet e brendshme dhe ato të rimbursimit që aksesohen nga sektorë të ndryshëm të drejtorive rajonale janë plotësisht të aksesueshme nëpërmjet pajisjeve të reja të rrjetit.

9. Monitorimi i Kontratave me Dhënësit e Shërbimeve Shëndetësore

Monitorimi i kontratave me dhënësit e shërbimeve shëndetësore, është element shumë i rëndësishëm i punës së FSDKSH, në mënyrë që financimi publik për shërbimet shëndetësore, të shkojë në të mirë të popullatës, duke shmangur abuzimet.

9.1 Monitorimi i zbatimit të kontratave

Drejtoria e Kontrollit gjatë vitit 2024, ka ushtruar kontrolle në 805 subjekte ose rreth 26% e totalit të subjekteve të cilat kanë lidhur kontratë me Fondin. Konkretisht, është ushtruar kontroll në këto subjekte:

- **161** Qendra Shëndetësore;
- **412** Mjekë të përgjithshëm e të familjes;
- **184** Farmaci (134 të plotë dhe 50 tematikë);
- **27** Depo farmaceutike (12 farmaci të spitaleve 15 depo inventarë);
- **21** Spitale (20 të plotë dhe 1 tematik).

Në përfundim të kontrolleve janë rekomanduar masat si më poshtë:

- Shpërblim Dëmi ekonomik në vlerën totale 3,898,805.16 lekë;
- Masë administrative Gjobë , në vlerën totale 314,000 lekë;
- Masë administrative Kushte penale, në vlerën totale 833,799.16 lekë;

9.2 Monitorimi i zbatimit të kontratave nga Qendrat Shëndetësore

Bazuar në planin vjetor të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm, për periudhën Janar-Dhjetor 2024 nga Sektori i Kontrollit Parësor janë planifikuar për kontroll dhe realizuar kontrollet në rajonet si më poshtë vijon:

Nr.	DRSKSH	Total Q.Sh	Total mjekë	Subjektet e kontrolluara		Lloji i kontrollit	Sanksione		
				Q.SH	MPF/MS		Dëmi ekonomik	Kushte penale	Gjoba
1	Kamëz-Vorë	8	68	7	35	I plotë	56,679		6,000
2	Durrës	32	190	16	45	I plotë	51,326		26,000
3	Berat	21	66	16	32	I plotë	44,742		17,000
4	Elbasan	46	159	17	46	I plotë	57,629		26,000
5	Tiranë	27	318	10	49	I plotë	125,626		35,000
6	Gjirokastrë	18	45	8	22	I plotë	14,432		5,000
7	Kukës	16	36	6	15	I plotë	24,838		14,000
8	Tropojë	8	10	4	6	I plotë			5,000
9	Korçë	25	62	14	29	I plotë	31,294		14,000
10	Vlorë	17	79	10	28	I plotë	18,489		12,000
11	Fier	23	93	14	29	I plotë	32,838		14,000
12	Dibra	28	50	14	19	I plotë	46,451		3,000
13	Komsi	1	1	1	1	Tematik	159,760		10,000
14	Shkodër	31	102	11	24	I plotë	30,016		5,000
15	Tiranë			13	32	I plotë			
	TOTAL	301	1,279	161	412		694,120		192,000

Nga kontrollet e ushtruara, janë konstatuar problematikat kryesore, si vijojnë:

-Kanë rezultuar shkelje të kufizimeve të listës së barnave të rimbursuara, protokolleve të përdorimit të barnave dhe akteve të Fondit për mirëadministrimin e shpenzimeve të rimbursimit për mjekimin e të sëmurëve dhe administrimin e kartelave të pacientëve.

Në përfundim të kontrolleve sipas evidencave të Drejtorisë janë marrë këto masa:

- Masa administrative “Detyrim shpërblim dëmi” në vlerën totale prej 694,120 lekë.
- Masa administrative “Gjjobë” në vlerën totale prej 192,000 lekë.

Krahasimi i kontrolleve si 12 mujor, si dhe masat e marra për vitin 2024 krahasuar me vitin 2023

Viti	DRF/Rajone	Kontroll QSH	Kontroll MPF	Lloji i kontrollit	Sanksione		
					Dëmi ekonomik	Kushte penale	Gjjoba
2024	15 Rajone	161	412	I plotë, Tematik	694,120	0	192,000
2023	16 Rajone	155	379	I plotë, Tematik	338,539	75,000	299,000

9.3 Monitorimi i zbatimit të kontratave nga Farmacitë dhe Depot Farmaceutike

a) Për subjektet Farmaci dhe Agjenci Farmaceutike

Sektori i Farmacive dhe agjencie farmaceutike kontrollojnë përmbushjen e detyrimeve kontraktuale, në zbatim të skemës së Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit shëndetësor në subjektet farmaceutike të kontraktuara nga Fondi, duke u bazuar në planin mujor të Drejtorisë së Kontrollit si dhe sa herë që paraqiten problematika të veçanta.

Sektori i Kontrollit të Farmacive dhe Agjencie Farmaceutike, për periudhën Janar-Dhjetor 2024, ka ushtruar kontrolle në 184 subjekte me kontratë me drejtorinë Rajonale, që përbëjnë 71.5% të shpenzimeve të rimbursimit në Fondin referuar të dhënave nga Drejtoria e Informacionit dhe Analizës Statistike për vitin 2024 (këtu nuk përfshihet DSHSU) dhe 100 % e Planit vjetor të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm.

Rezultatet paraqiten si më poshtë:

Nr.	Farmaci/Agjenci		Numri i subjekteve të kontrolluara			Lloji i kontrollit	Sanksione				Totali i rimbursimit të rajoneve në raport me rimbursimin e subjekteve të kontrolluara	Totali i subjekteve me kontratë në raport me numrin e subjekteve të kontrolluara
	DRF	Farmaci/Agjenci Totali	Totali	Plotë	Tematik		Dëmi ekonomik	Kushte penale	Gjoha	Zgjidhje kontrate		
1	Kamez-Vore	36	12	8	4	Tematik+inventar	78,488				46%	32%
2	Fier	50	13	10	3	Tematik+inventar	140,049				42%	26%
3	Durres	93	15	10	5	Tematik+inventar	227,539				28%	16%
4	Gjirokaster	15	6	3	3	Tematik+inventar	50,143	30,000			43%	40%
5	Sarande	14	4	2	2	Tematik+inventar	39,847				34%	31%
6	Tirane	268	31	26	5	Tematik+inventar	494,936	22,400			40%	12%
7	Elbasan	82	15	10	5	Tematik+inventar	178,565				32%	19%
8	Kukes	9	3	3		Tematik+inventar	27,704				43%	30%
9	Tropoje	3	1	1		Tematik+inventar	5,357				61%	33%
10	Berat	39	8	4	4	Tematik+inventar	50,344				24%	21%
11	Pogradec	17	6	4	2	Tematik+inventar	13,428				52%	35%
12	Vlore	54	6	6	-	Tematik+inventar	52,551				58%	10%
13	Diber	22	10	7	3	Tematik+inventar	100,574				65%	43%
14	Korce	39	15	12	3	Tematik+inventar	131,676		4,000		65%	38%
15	Shkoder	62	13	10	3	Tematik+inventar	115,530		10,000		45%	21%
16	Lushnje	40	13	10	3	Tematik+inventar	216,066		8,000		59%	33%
17	Diber		1	0	1	Tematik+inventar						
18	Lezhe	37	12	8	4	Tematik+inventar	71,130				45%	32%
	Totali	880	184	134	50		1,993,927	52,400	22,000			

Për periudhën Janar –Dhjetor 2024, janë kontrolluar 184 (134 kontrolle të plotë dhe 50 tematikë) subjekte dhe janë marrë masat si më poshtë:

- Detyrim shpërblim dëmi në vlerën 1,993,927 lekë për 133 subjekte farmaceutike;
- Kushte penale në vlerën 52,400 lekë në 3 subjekte farmaceutike;
- Gjohë në vlerën 22,000 lekë në 4 subjekte farmaceutike.

Krahasimi i kontrolleve si 12 mujor, si dhe masat e marra për vitin 2024 krahasuar me vitin 2023:

Viti	DRF/Rajone	Subjekte të kontrolluara	Lloji i kontrollit	Sanksione			
				Dëmi ekonomik	Kushte penale	Gjoba	Zgjidhje kontrate
2024	17 Rajone	184	Inventar dhe Tematik	1,993,927	52,400	22,000	
2023	17 Rajone	183	Inventar dhe Tematik	1,592,181	4,000	250,200	

b) Për subjektet Depo Farmaceutike

Sektori i Kontrollit të Depove Farmaceutike gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2024 ka kryer kontrolle me inventar në 15 Depo Farmaceutike Importuese dhe në 12 farmacitë e spitalit për barnat e shtrenjta, ku u konstatuan mungesa të barnave të listës së rimbursueshme.

Rezultatet e kontrolleve praqiten si më poshtë:

Kontrolli	Sanksione		
	Dëm ekonomik	Kusht Penal	Gjobë
Kontroll i plotë me inventarizim		56,011.96	100,000
Kontroll i Farmacive te Spitaleve Rajonale	2,128	30,367.04	
Totali	2,128	86,379	100,000

Problematikat kryesore të evidentuara nga kontrollet janë si më poshtë vijnë:

- Nga kontrolli me inventar i farmacive të spitalit dhe të depove importuese rezultuan mangësi në lidhje me barnat e listës së rimbursueshme.

Krahasimi i kontrolleve si 12 mujor, si dhe masat e marra për vitin 2024 krahasuar me vitin 2023:

Viti	Depo	Subjekte të kontrolluara	Lloji i kontrollit	Sanksione			
				Dëm ekonomik	Kusht penal	Gjobë	Zgjidhje kontrate
2024	Depo	27	12 farmaci të spitaleve Rajonale, 15 depo me inventar	2,128	86,379	100,000	
2023	Depo	31	9 farmaci të spitaleve Rajonale, 3 depo për disponibilitet dhe 19 depo me inventar	315,030.04	2,000,000		

9.4 Monitorimi i zbatimit të kontratave me Spitalet

Nga Sektori i Kontrollit Spitalor, për vitin 2024, janë kryer kontrolle të plota në Spitalet: Qendra Spitalore Rajonale “Shefqet Ndroqi” + Kavajë, Spitali Rajonal Lezhë, Spitali Rajonal Berat, Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”, Spitali Rajonal Fier, Spitali Bashkiak Pukë, Spitali Bashkiak Mat, Spitali Bashkiak Lushnje, Spitali Bashkiak Mallakastër, Spitali Rajonal Korçë, Spitali Bashkiak Gramsh, Spitali Bashkiak Librazhd, Spitali Bashkiak Tropojë, Spitali Bashkiak Pogradec, Spitali Rajonal Vlorë, Spitali Rajonal Shkodër, Spitali Rajonal Elbasan, Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”, si edhe kontroll tematik në Spitalin Bashkiak të Krujës.

Në tabelën e mëposhtme pasqyrohen të dhënat e detajuara mbi kontrollet në Spitalet Universitare, Rajonale dhe Bashkiake:

Nr	Spitalet	Masa organizative	Masa disiplinore	Masa administrative (gjoha)	Masa detyrim për shpërblim dëmi (Vlerë)	Kushte Penale	Ndërprerje kontrate
1	QSU "Nene Tereza" Tiranë	6	0	0	0	0	0
2	S.U.Trauma	11	0	0	0	0	0
3	Q.S.R."Shefqet Ndroqi" + Kavajë	12 + 9 Kavajë	0	0	98,512	0	0
4	S.B.Krujë (Tematik)	2	0	0	0	0	0
5	S.R.Lezhë	14	0	1 Pagë	0	35,000	0
6	S.R.Berat	14	0	0	0	320,000	0
7	S.U.Obs.Gjin Koço Gliozheni	7	0	0	0	0	0
8	S.R.Fier	18	0	0	45,115	20,000	0
9	S.B.Pukë	9	0	0	76,244	25,000	0
10	S.B.Mat	15	0	0	755,396	0	0
11	S.B.Lushnje	3	0	0	13,764	45,000	0
12	S.B.Mallakastër	8	0	0	0	0	0
13	S.R.Korçë	12	0	0	8,283	45,000	0
14	S.B.Gramsh	9	0	0	32,754	25,000	0
15	S.B.Librazhd	9	0	0	0	5,000	0
16	S.B.Tropojë	15	0	0	85,716	10,000	0
17	S.B.Pogradec	5	0	0	0	0	0
18	S.R.Vlorë	36	6	0	85,506	25,000	0
19	S.R.Shkodër	22	0	0	7,341	140,000	0
20	S.R.Elbasan	Në proces					
21	S.U.Obs.Gjin "Mbretëresha Geraldinë"	Në proces					
	Total	236	6	1 Pagë	1,208,631	695,000	0

Siç vërehet në tabelën e mësipërme shkeljet e konstatuara për vitin 2024 janë:

- Masa detyrim shpërblim dëmi në vlerën 1,208,631 lekë.
- Kushte penale në vlerën 695,000 lekë.
- Masa organizative 236 masa.
- Masa Disiplinore 6.
- Masa administrative 1 pagë

Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë dhe Spitali Universitar i Traumës janë planifikuar dhe realizuar në vitin 2023, por Vendimi për këto spitale ka dalë në vitin 2024 dhe për këtë arsye dhe masat organizative, disiplinore, administrative dhe kushtet penale janë pasqyruar në tabelën e mësipërme.

9.5 Problematikat Kryesore

- Kushti penal është vendosur për mosplotësimin e kartelave sipas elementeve, në kundërshtim me Nenin 6 “Detyrime të spitalit në shërbimet me shtretër”, pika 5 citohet si vijon: “Të përdorë kartelat klinike tip të miratuara nga MSHMS. Plotësimi i tyre nga mjeku specialist të bëhet me shkrim të qartë dhe konform të gjitha rubrikave që kartela përmban. Vendosja e diagnozës klinike të bëhet brenda afateve kohore të kërkuara, si dhe të shkruhet e plotë”.
- Dëmi ekonomik është vënë për mangësitë e konstatuara në dokumentacionin e bankës, kontrollin e pagave, të shpenzimeve për udhëtime e dieta, shpenzimeve të karburantit, si dhe në farmacinë e spitalit për barnat e skaduara dhe diferenca. Në bazë të Nenit 17 “Dëmi ekonomik”, pika 4, gërma a. citohet si vijon: “Spitali zhdëmton Fondin/DRF në vlerën përkatëse kur në rast se: a) lejon skadencën e barnave, reagentëve, filmave, materialeve për përdorim spitalor dhe mallrave të ndryshëm ushqimor dhe/ose industrial për shkak të mosruajtjes së tyre në parametrat e duhur, si dhe keqadministrimit të tyre si dhe mangësi në moszbatimin e kontratës”.

Në tabelën e mëposhtme paraqiten të dhënat e detajuara për vitet 2023 dhe 2024 për spitalet Universitarë, Rajonalë, Bashkiakë dhe Spitalet privatë:

Viti	Numri i subjekteve të kontrolluara	Sanksione				
		Dëm ekonomik	Kusht penal	Masa disiplinore	Masa administrative	Masa organizative
2024	21	1,208,631	695,000	6	1	236
2023	32	845,830	605,000	2	1	234

10. Përmirësimi i Administrimit të Fondit

Veprimtaria audituese e vitit 2024 ka funksionuar në përputhje me aktet ligjore që rregullojnë shërbimin e auditimit të brendshëm me fokus përgjegjshmërinë e realizimit të programit të miratuar në pajtueshmëri me standardet e përcaktuara si dhe komunikimin e rezultateve përfundimtare.

Veprimtaria audituese përfshin Drejtorinë e Përgjithshme, Drejtoritë Rajonale, Degët, Spitalin Rajonal Durrës dhe Spitalin Memorial Fier.

Në përfundim të vitit 2024 rezulton se janë kryer 20 (njëzet) misione angazhim auditimi të kombinuara dhe 1 (një) mision për zbatim rekomandimesh të lëna nga auditimet e realizuara në vitin 2023. Gjatë vitit 2024, veprimtaria audituese nuk ka patur problematika të qënësishme përveç synimit të vazhdueshëm e të pandërprerë, në rritjen e performancës së këtij shërbimi duke

i dhënë siguri objektive titullarit në funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm, në arritjen e objektivave strategjike të institucionit.

10.1 Misioni i auditimit të brendshëm

Misioni i auditimit është kryerja e çdo angazhimi në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi, standardet ndërkombëtare të auditimit të brendshëm të shpallura dhe pranuar, në Planin Strategjik e Vjetor të veprimtarisë së auditimit të brendshëm.

Auditimi i brendshëm ka asistuar të gjitha nivelet e menaxhimit, nëpërmjet analizave, vlerësimeve, këshillimeve dhe rekomandimeve.

Objekti i veprimtarisë është kryerja e auditimit të brendshëm i të gjitha strukturave, programeve, veprimtarive dhe proceseve të Fondit dhe të strukturave vartëse, me qëllim rritjen e besimit të publikut tek institucioni, realizuar përmes:

- Forcimit të pavarësisë në përmbushjen e misionit dhe objektivave ligjorë, në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga procesi i përafrimit gradual të legjislacionit dhe politikave tona me legjislacionin e BE-së;
- Adoptimin e standardeve më të mira të kontabilitetit dhe auditimit, publikimin e raporteve të rregullta, si dhe sigurimin e integritetit të proceseve të auditimit të brendshëm, si elemente kyçe të llogaridhënies publike;
- Rritjes së transparencës mbi veprimtarinë e DAB përmes një komunikimi të hapur dhe të qartë me publikun.

10.2 Aktiviteti i auditimit të brendshëm të Fondit

Aktiviteti i auditimit të brendshëm është realizuar nga njësia e auditit të brendshëm e organizuar në nivel Drejtorie me mision mbështetjen e menaxhimit të lartë në realizimin e objektivave në zbatim të Planit Strategjik dhe Vjetor të miratuar nga titullari, ku përcaktohen qartë objektivat për t'u arritur, kapacitetet në dispozicion si dhe vlerësimi e menaxhimi i riskut.

Misionet e auditimit të realizuara mbi bazë sistemi kanë qenë të kombinuara dhe verifikimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme.

Për vitin 2024, Drejtoria e Auditit të Brendshëm është e organizuar në tre sektorë dhe ka në strukturën organike 13 (trembëdhjetë) punonjës.

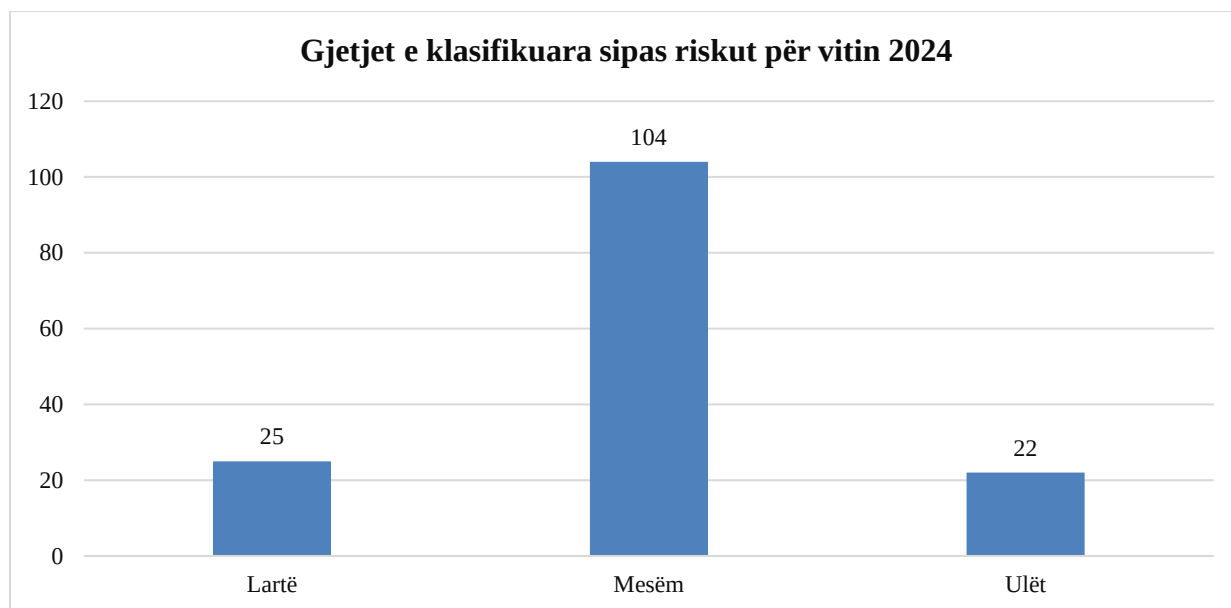
10.3 Fushat me risk të lartë dhe trajtimi i tyre

Metodologjia e përdorur për vlerësimin e riskut është ajo përcaktuar në Ligjin për Auditimin e Brendshëm dhe Manualin e Auditimit të Brendshëm dhe pikërisht bazuar në këtë sistem të vlerësimit të riskut, është programuar dhe auditimi i fushave dhe subjekteve që paraqiten me një nivel të lartë apo të mesëm risku.

Nga analiza e të dhënave vjetore sipas subjekteve të audituara, nga struktura e auditimit përcaktimi i nivelit të riskut është bërë duke marrë në konsideratë faktorët e riskut, të cilët në mënyrë të përmbledhur do ti përgjithësonim në kategoritë e mëposhtme:

- Organizimi dhe kompleksiteti i subjekteve.
- Kuadri ligjor dhe rregullator.
- Kërkesat e raportimit financiar.
- Mjedisi i kontrollit.
- Shkalla e ndryshimeve organizative dhe të sistemit të menaxhimit.
- Materialiteti sipas natyrës, çështje ndaj të cilave ka interes të lartë publik.
- Risku i brendshëm i fushës apo subjektit që auditohet.
- Mbulimi i pamjaftueshëm me auditime në të kaluarën.

Në auditimet e vitit 2024 janë konstatuar 151 gjetje, nga të cilat: 25 gjetje janë me risk të lartë, 104 gjetje janë me risk të mesëm dhe 22 gjetje janë me risk të ulët, sikurse paraqiten në grafikun në vijim:



Drejtorja e Auditit të Brendshëm që në fazën e planifikimit vjetor është mbështetur në auditimin e sistemeve apo subjekteve që kanë risk të lartë dhe risk të mesëm. Është kërkuar që gjatë vitit 2024 të gjitha drejtoritë në qendër dhe rajone të përditësojnë listat e proceseve, regjistrin e riskut dhe gjurmët e auditit.

Mbi bazën e përvojës së fituar janë vlerësuar risqet sipas sistemeve dhe subjekteve. Nisur nga fakti që strukturat e Fondit duke përfshirë dhe Drejtorinë e Përgjithshme përdorin fonde të konsiderueshme publike, niveli i riskut është vlerësuar si i lartë, i mesëm dhe i ulët.

10.4 Rekomandime

Një aspekt mjaft i rëndësishëm i aktivitetit auditues është dhënia e rekomandimeve në përfundim të çdo misioni angazhim auditimi. Rekomandimet janë mbështetur në gjetjet e rezultuara dhe kanë si qëllim përmirësimin e punës së subjekteve të audituara.

Në përfundim të auditimeve gjatë vitit 2024, DAB ka rekomanduar 151 masa organizative. Analiza e detajuar e rekomandimeve sipas sistemeve, nënsistemeve të audituara për vitin 2024 paraqitet në tabelën në vijim:

Sistemi	Nënsistemi	Numri
Aktivet e qëndrueshme	Amortizimi	1
	Inventaret	5
Menaxhimi i burimeve njerëzore	Etika	1
	Largimi apo lirimi	1
	Rekrutimi	2
Pagat e shpërblimet	Efektiviteti kohës punës	1
Planifikimi e buxhetimi	Monitorimi zbatimit buxhetit	8
	Planifikimi buxhetor	4
	Zbatimi buxhetit	1
Prokurimi	Dorëzimi	2
	Planifikimi	3
	Procesi tenderimit	4
Qeverisja e administrimi	Menaxhimi riskut	4
	Vendimarrja dhe mbikqyrja	1
Raportimi financiar e kontabiliteti	Kontrollet, rregullat e procedurat e angazhimit	4
	Pagesat	2
	Regjistrimet në kontabilitet	3
	Saktësia e raportimit	1
Sisteme specifike operacionale	Drejtoria operacionale, Laboratori	2
	Drejtoria operacionale, Sterilizimi	2
	Drejtoria operacionale, Farmaceutika	12
	Drejtoria operacionale, Kujdesi Parësor	40
	Drejtoria operacionale, Rimbursimi	2
	Drejtoria operacionale, Shërbimi Spitalor	39
	Drejtoria operacionale, Shërbimi Spitalor Universitar	4
Të tjera	Zbatim i rekomandimeve të lëna	2
Total		151

Në zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme

Për vitin 2024 është verifikuar niveli i zbatimit të 211 rekomandimeve të lëna nga viti 2023. Analiza e detajuar e nivelit të zbatimit të rekomandimeve evidentohet në tabelën në vijim:

Statusi i rekomandimit	Numri rekomandimeve	Pesha specifike
I zbatuar plotësisht	188	89.10
Në proces zbatimi	22	10.43
I pazbatuar	1	0.47

10.5 Konkluzione

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor ka të organizuar sistemin e kontrollit të brendshëm, por ky sistem duhet përmirësuar në drejtimet e mëposhtme:

- Përgatitjen e metodologjisë për hartimin e listës së barnave të rimbursueshme, mënyrën e hartimit të kufizimeve të listës së barnave, hartimin e kontratave tip të veçanta për qendrat shëndetësore.
- Përgatitjen e rregulloreve e udhëzimeve për kontrollin e subjekteve jo publike (shpenzimeve konçensionare të sterilizimit të pajisjeve mjekësore e dializës, kontrollit mjekësor bazë, laboratorit dhe paketave të shërbimeve shëndetësore) të kontraktuara.
- Analizën e riskut dhe përqëndrimin e kontrolleve në subjektet me risk të lartë.
- Përmirësimin e cilësisë së supervizimeve e kontrolleve në të gjitha hallkat duke zbatuar me rigorizitet udhëzimet si dhe duke kërkuar zbatimin e pikave të kontratave me ofruesit e shërbimeve.
- Përmirësimin e cilësisë të kontrollit në spitale, dhe mbulimi me kontroll i të gjitha problematikave të aktivitetit të spitalit.
- Rritjen e nivelit të realizimit të detyrave të lëna nga auditimi i mëparshëm.

Opinion i përgjithshëm

Bazuar në vlerësimin e fushave apo sistemeve të njësisë publike në zbatim të standardeve, Drejtoria e Auditit të Brendshëm në Fond, ka marrë në konsideratë strategjitë, objektivat dhe risqet e njësisë publike, si dhe pritshmëritë e menaxhimit të lartë dhe palëve të tjera të interesuara. Opinioni i përgjithshëm mbështetet në informacionin e mjaftueshëm, të besueshëm, të duhur dhe të dobishëm trajtuar në këtë raport. Të gjitha gjetjet dhe rekomandimet i janë raportuar menaxhimit si një pjesë e rëndësishme e procesit të auditimit të brendshëm për të përmirësuar funksionimin e njësisë në të ardhmen. Sistemi i kontrollit të brendshëm funksionon në mënyrë efektive, por ka disa mangësi, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim të moderuar në objektivat e njësisë publike. Ka nevojë për marrjen e veprimeve për përmirësime në disa drejtime.

11. Komunikimi dhe Informimi i Publikut

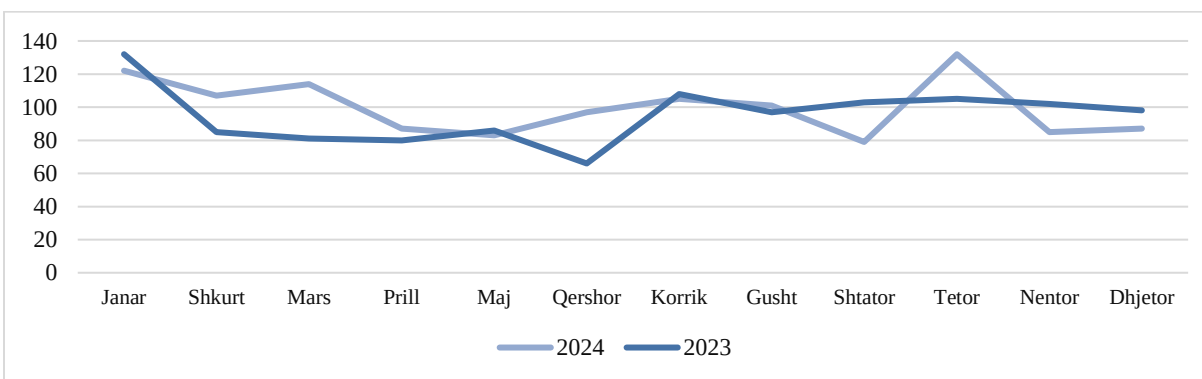
Njësia e marrëdhënieve me publikun, gjatë angazhimit të saj në zbatim të detyrave brenda përgjegjësisë dhe fushëveprimit të saj, është angazhuar edhe në çdo aspekt tjetër të komunikimit me qëllimin e vetëm që publiku, mediat dhe palët e interesuara për veprimtarinë e Fondit, të jenë të informuar në kohë dhe me transparencë.

Komunikimi dhe informimi për shërbimet e institucionit, është zhvilluar nëpërmjet kanaleve të informacionit, si vijojnë:

- *Adresa elektronike* info@fsdksh.gov.al - Në zbatim të VKM nr. 252, dt. 29.04.2022 "Për Procedurat e Shërbimit Online", gjatë vitit 2024, komunikimi me publikun është kryer nëpërmjet adresës elektronike info@fsdksh.gov.al, ku janë pranuar dhe shqyrtuar pjesa më e madhe e kërkesave/ankesave nga qytetarët, si edhe është përcjellë informacioni i nevojshëm. Gjithashtu, përmes postës elektronike zyrtare, janë ndjekur edhe të gjitha rastet e përcjella nga Platforma e Bashkëqeverisjes, të cilat janë shqyrtuar me transparencë dhe brenda afateve kohore ligjore.
- *Koordinatori për të drejtën për informim* - Nëpërmjet adresës elektronike të Koordinatorit për të Drejtën për Informim, në zbatim të Ligjit nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit", janë pranuar dhe shqyrtuar të gjitha kërkesat për informacion, të dërguara kryesisht nga media, shoqëria civile, e të tjerë.
- *Webfaqja zyrtare* www.fsdks.gov.al – Është administruar me në fokus publikimin e një informacioni të plotë mbi veprimtarinë dhe shërbimet që ofron institucioni. Në faqen zyrtare është pasqyruar me transparencë çdo aktivitet, informacion apo njoftim, me interes për publikun e të tjerë, përmes publikimeve të përditësuara në koherencë me punën e Fondit dhe në zbatim të Ligjit nr. 119/2014 "Për të Drejtën e Informimit" dhe të Programit të Transparencës, si pjesë e tij.
- *Rrjetet sociale* - Është bërë administrimi, monitorimi dhe prezantimi i punës së Fondit në kanalet zyrtare sociale specifikisht në: Facebook, Instagram dhe Twitter.

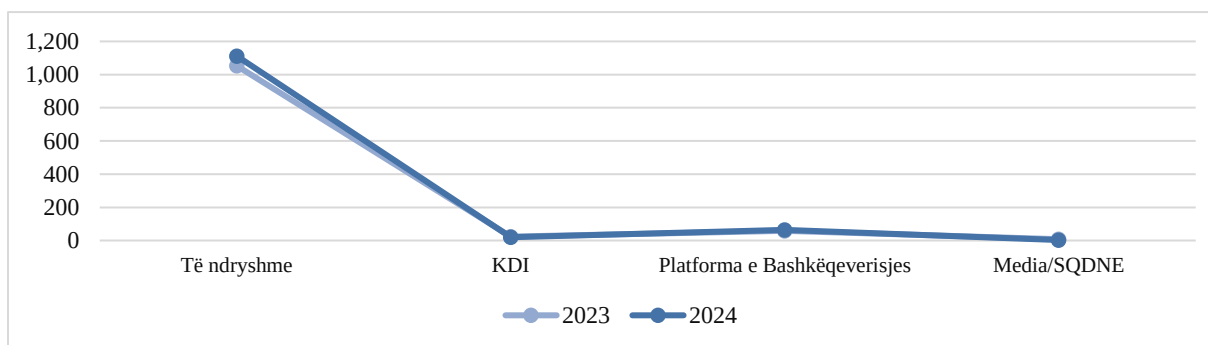
Gjatë vitit 2024 janë pritur gjithsej 1,199 raste, të cilat janë trajtuar dhe ndjekur me përgjegjësi dhe në respektim të afateve kohore ligjore, në bashkëpunim me njësitë teknike në Fond. Të dhënat e mbledhura në regjistrat përkatës, janë përpunuar dhe paraqitur në grafikët në vijim.

Grafik 1 Numri total i rasteve për vitet 2023, 2024



*SMP- Sektori i Marrëdhënieve me Publikun

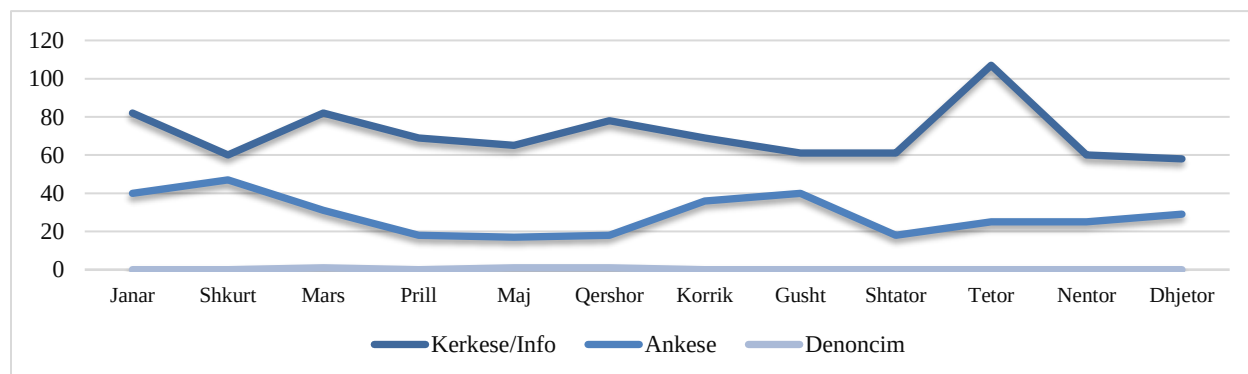
Grafik 2 Raportim i problematikave sipas mediumit, të krahasuara për vitet 2023, 2024



*KDI- Kordinatori për të Drejtën e Informimit; *SQDNE- Sistemi i Qarkullimit të Dokumentave me Nënshkrim Elektronik

Pas hyrjes në fuqi të VKM nr. 252, dt.29.04.2022 "Për Proçedurat e Shërbimit Online", gjatë vitit 2024 komunikimi me qytetarët për problematika të ndryshme si edhe dhënia e informacionit, është realizuar tërësisht nëpërmjet adresës elektronike, Ky proces ka përmirësuar procedimin zyrtar të raportimit, shqyrtimit dhe përmbylljes së rasteve në tërësi.

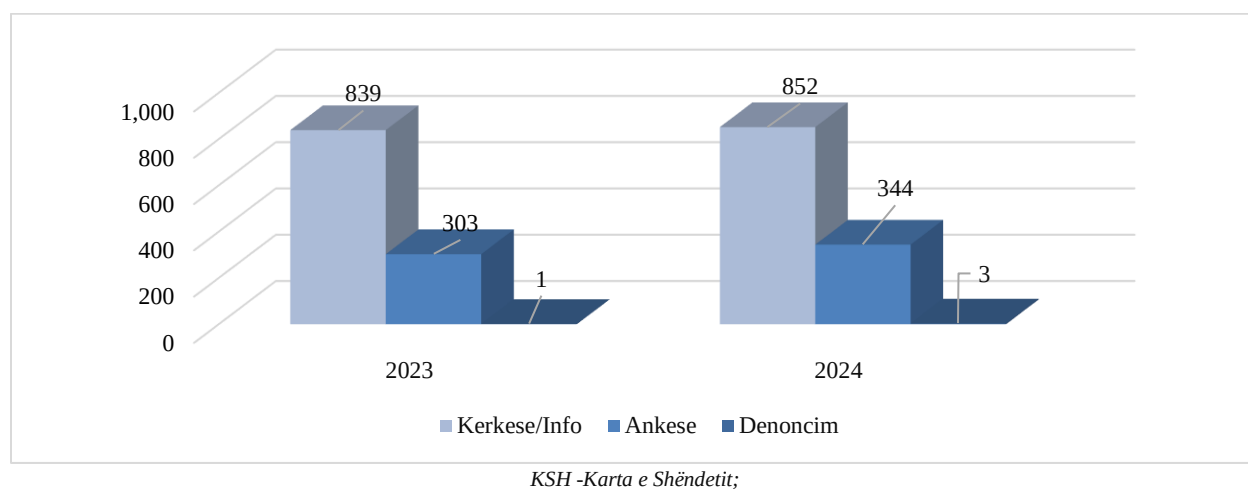
Grafik 3 Tipologjia e raportimeve për vitin 2024



*KSH -Karta e Shëndetit;

Duke analizuar tipologjinë e raportimeve, gjatë vitit 2024 konstatohen më të shpeshta rastet lidhur me informacione e të dhëna për LBR-në si: informacion mbi monitorimin e disponibilitetit të barnave; ankesa lidhur me disponibilitetin e barnave ne treg; problematika të lidhura me mospërfitimin e barnave me rimbursim. Si edhe: problematika të hasura në procesin e ndryshimit të mjekut të përgjithshëm dhe të familjes; kërkesë për asistencë për procesin e pajisjes me nënshkrim elektronik; kërkesë për pajisje me formularë, në zbatim të marrëveshjeve në fushën e mbrojtjes shoqërore; raportime për problematika lidhur me eRx; problematika lidhur me procesin e lidhjes së kontratës me subjektet farmaceutike, etj.

Grafik 4 Tipologjitë e raportimeve, të krahasuara për vitin 2023 dhe për vitin 2024



Nga krahasimi i të dhënave, frekuencë më të lartë kanë kërkesat për informacion, të cilat konsistojnë kryesisht në orientim apo asistencë lidhur me përfitimin apo përdorimin e shërbimeve dhe të produkteve që ofron Fondi. Në vitin 2024, vihet re një rritje e numrit të ankesave, gjë që përkon me problematikat shoqëruese me hyrjen në fuqi të Listës së Barnave të Rimbursueshme.

12. Bashkëpunimi me Institucionet

12.1 Bashkëpunimi ndërinstitucional

FSDKSH bashkëpunon institucionalisht me MSHMS-në për politikat dhe strategjitë që kanë lidhje me sistemin shëndetësor, për të dhënat e gjendjes shëndetësore, si dhe informacione të tjera që kanë lidhje me funksionimin e FSDKSH-së.

Këshilli i Ministrave është organi i cili përcakton institucionet ose organizmat e tjerë që duhet të ofrojnë të dhëna rregullisht, sipas nevojave të FSDKSH. Në këtë kuadër bashkëpunohet me Ministrinë e Financave për treguesit e zhvillimit makroekonomik, të dhënat për prodhimin e përgjithshëm bruto dhe informacione të tjera financiare për funksionimin e FSDKSH.

Gjithashtu, në realizimin e veprimtarisë së tij institucionale, FSDKSH lidh marrëveshje ndërinstitucionale për shkëmbimin, në mënyrë të vazhdueshme, të informacionit të hollësishëm me entet private dhe publike duke marrë dhe duke analizuar informacionin e tyre, lidhur me kategoritë e të siguruarve dhe të dhëna të tjera të domosdoshme për zbatimin e skemës së sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor.

Përmendim këtu:

- Memorandumin e Mirëkuptimit midis FSDKSH dhe Institutit të Statistikave (INSTAT), i cili rregullon marrëdhënien midis dy institucioneve lidhur me llojin dhe mënyrën e raportimit të të dhënave zyrtare. Mbi këtë bazë bashkëpunohet për përgatitjen dhe dërgimin e të dhënave sipas standarteve të dakortësuara.
- Nënshkrimi i Marrëveshjes së lidhur midis Shërbimit Informativ të Shtetit dhe FSDKSH, për regjistrimin e punonjësve të SHISH në regjistrin elektronik të të siguruarve.
- Nënshkrimi i Marrëveshjes me Ambasadën Amerikane për regjistrimin e punonjësve të kësaj Ambasade në regjistrin elektronik të të siguruarve.
- Raportimi dhe përgatitja për procesin screening mbi zhvillimin e skemës së sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor për kapitujt e PKIE 2024-2026 dhe Raportimet në Kuadër të Proçesit të Integritimit Evropian. FSDKSH raporton për Kapitujt 2, 19, 28.
- Bashkëpunim me AKSHI-n, në lidhje me Sistemin e Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik.”

12.2. Marrëveshjet Ndërkombëtare

Në kuadër të rekomandimeve të Komisionit Evropian, Qeveria Shqiptare ka negociuar dhe lidhur një sërë marrëveshjesh, të cilat konsistojnë në ofrimin e mbrojtjes shoqërore, duke përfshirë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Në zbatim të marrëveshjeve, Fondi është institucioni përgjegjës për ndjekjen e procedurave administrative duke aplikuar lëshimin e formularëve të sigurimit shëndetësor.

Me **Republikën e Turqisë**, marrëveshja është ratifikuar me ligjin nr. 9066, datë 15.05.2003 “Për ratifikimin e Marrëveshjes midis Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë për Mbrojtjen Shoqërore”. Si pjesë e zbatimit të kësaj marrëveshjeje janë 19 formularë.

Me **Mbretërinë e Belgjikës**, marrëveshja është ratifikuar me ligjin nr. 35/2014, datë 03.04.2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Belgjikës

për Mbrojtjen Shoqërore”. Fondi zbaton Marrëveshjen nëpërmjet aplikimit të 14 formularëve të miratuar. Kjo Marrëveshje ka hyrë në fuqi në 01 Janar 2016.

Me **Dukatin e Madh të Luksemburgut**, marrëveshja është ratifikuar me ligjin nr. 42/2015, datë 16.04.2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Dukatit të Madh të Luksemburgut për Mbrojtjen Shoqërore”. Kjo Marrëveshje ka hyrë në fuqi në 01 Korrik 2016. Në këtë marrëveshje, është vendosur vetëm pranimi i sigurimit vullnetar ndërmjet dy Shteteve Kontraktuese.

Me **Republikën e Maqedonisë**, marrëveshja është ratifikuar me ligjin nr. 123/2015, datë 12.11.2015 “Për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë për Mbrojtjen Shoqërore”. Me zbatimin e kësaj marrëveshjeje janë miratuar në mënyrë reciproke 18 formularë. Kjo marrëveshje ka hyrë në fuqi në 01 Qershor 2016.

Me **Republikën e Hungarisë**, marrëveshja është ratifikuar me ligjin nr. 151/2015, datë 21.12.2015 “Për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Hungarisë për mbrojtjen shoqërore”. Fondi zbaton Marrëveshjen nëpërmjet aplikimit të 6 formularëve të miratuar. Kjo Marrëveshje ka hyrë në fuqi në 01 Korrik 2016.

Me **Republikën e Çekisë** marrëveshja është ratifikuar me ligjin nr. 34/2016, datë 24.03.2016 “Për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Çeke për mbrojtjen shoqërore”. Fondi zbaton marrëveshjen nëpërmjet 6 formularëve të miratuar. Kjo marrëveshje ka hyrë në fuqi në 01 Shkurt 2017.

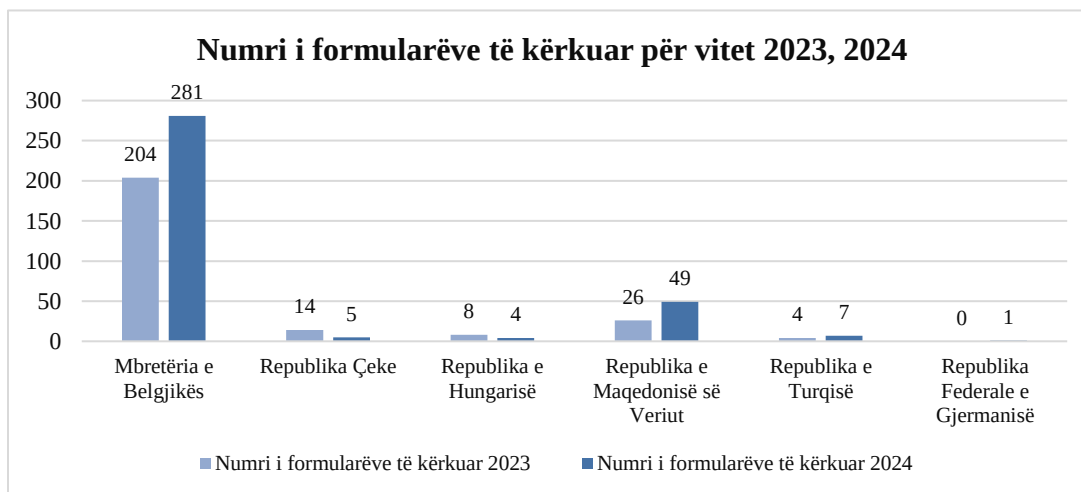
Me **Republikën Federale të Gjermanisë** marrëveshja është ratifikuar me ligjin nr. 23/2016, datë 10.03.2016 “Për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë për Mbrojtjen Shoqërore dhe të Protokollit Përfundimtar të saj”. Fondi zbaton marrëveshjen nëpërmjet 1 formulari të miratuar.

Me **Republikën e Rumanisë**, marrëveshja është ratifikuar me ligjin nr. 42/2016, datë 14.04.2016 “Për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Rumanisë për mbrojtjen shoqërore”.

Me **Malin e Zi**, marrëveshja është ratifikuar me ligjin nr. 70/2023, “Për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Malit të Zi për sigurimet shoqërore”.

Me **Republikën e Kroacisë** marrëveshja është ratifikuar me ligjin nr. 11/2024, “Për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kroacisë për mbrojtjen shoqërore”.

Në grafikun më poshtë paraqitet numri i formularëve të kërkuar nga Fondi për vitet 2023 dhe 2024:



13. Prioritetet Strategjike dhe Objektivat

13.1 Prioritetet strategjike

Synimi i prioriteteve strategjike të FSDKSH është vazhdimi i përpjekjeve për të përmirësuar dhe zgjeruar skemën e sigurimeve shëndetësore, në funksion të shëndetit dhe mirëqënies së popullatës duke respektuar të drejtat e tyre për shëndet të mirë.

Synohet të arrihen objektivat për përmirësimin e nevojave të popullatës për shërbime shëndetësore cilësore, duke adresuar nevojat dhe kërkesat kryesore për shërbime shëndetësore dhe për përmirësimin e shëndetit të popullatës.

Në përputhje me Strategjinë Kombëtare të Shëndetësisë, FSDKSH në bazë të misionit të tij, ka si prioritete kryesore strategjike:

- Zhvillimin dhe përmirësimin e skemës së sistemit shëndetësor, duke vendosur në qendër qytetarët;
- Fuqizimin e mekanizmave dhe kapaciteteve të planifikimit strategjik për financimin e kujdesit shëndetësor;
- Monitorimin më efektiv të financimit të kujdesit shëndetësor dhe optimizimin e përdorimit të burimeve;
- Sigurimin e shëndetit të popullatës gjatë gjithë ciklit të jetës dhe mundësimin financiar të Mbulimit Shëndetësor Universal për të gjithë;

- Fuqizimin e mëtejshëm të kujdesit shëndetësor parësor, si porta e parë hyrëse e qytetarit dhe përmirësimin e aksesit në barna dhe pajisje mjekësore të sigurta e cilësore;
- Ofrimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët nëpërmjet financimit të paketave standarde të shërbimeve në të gjitha nivelet e sistemit shëndetësor;
- Përmirësimin e cilësisë së sistemeve të teknologjisë shëndetësore të informacionit, të shtrirë gjerësisht në mbarë vendin; dhe lehtësimin e aksesit për dhënësit e shërbimit dhe qytetarët;
- Përmirësimin e qeverisjes institucionale dhe bashkëpunimit ndërsektorial për shëndetin;
- Rritjen e transparencës së veprimtarisë së Fondit dhe përmirësimin e aksesit dhe cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve në informacion dhe shërbime;
- Bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë, për realizimin me sukses të reformës në fushën e sigurimeve shëndetësore, sipas direktivave të BE-së.

13.2 Objektivat vjetore 2025

- Qëndrueshmëria dhe përmirësimi i situatës financiare të skemës, nëpërmjet përdorimit me efektivitet të burimeve të financimit, forcimit të kontrollit të shpenzimeve.
- Realizimi i marrëdhënieve kontraktuale korrekte midis FSDKSH dhe ofruesve të shërbimit shëndetësor në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj popullatës.
- Përmirësimi i mënyrës së financimit të institucioneve shëndetësore publike të dhënësve të shërbimit shëndetësor, bazuar në rezultate të matshme dhe të targetuara bazuar në indikatorët e performancës.
- Financimi i paketave të miratuara të shërbimit spitalor në spitalet publike e jopublike, duke mbajtur nën kontroll kapacitetet financiare të Fondit.
- Rritja e kosto-efektivitetit të listës së barnave e pajisjeve të rimbursueshme dhe sigurimi i trajtimeve të efektshme për pacientët, bazuar në udhërrëfyesit dhe protokollet e praktikës klinike të miratuara.
- Zgjerimi i listës së barnave të rimbursuara, duke siguruar rritjen e përfitimeve të popullatës.
- Monitorimi i shpenzimeve të rimbursimit për barnat e Listës së rimbursuar, duke respektuar tavanet buxhetore të miratuara me ligj.
- Sigurimi i disponibilitetit të barnave të rimbursuara në rrjetin e hapur farmaceutik dhe në farmacitë e spitaleve.
- Realizimi i procedurave të lidhjes/rilidhjes së kontratave me farmacitë, agjencitë farmaceutike, importuesit dhe shpërndarësit farmaceutikë, importuesit e pajisjeve mjekësore të rimbursuara, si dhe institucionet shëndetësore jo publike, nëpërmjet platformës e-Albania.

- Përmirësimi dhe zhvillimi i sistemeve informatike si ai i Regjistrimit të të Siguruarve AHIS, përmirësimi i rrjetit (WAN/LAN) dhe analizimi dhe vlerësimi i sistemeve dhe rrjetit informatik të Fondit me qëllim përcaktimin e ecurisë së tyre.
- Përmirësimi i metodologjisë së kontrollit në funksion të zbatimit të kontratave që Fondi lidh me ofruesit e shërbimeve shëndetësore.
- Përditësimi i kuadrit ligjor në përputhje me legjislacionin e skemës së sigurimeve shëndetësore dhe të akteve të tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.
- Realizimi i negociatave dhe zbatimi i marrëveshjeve të reja bilaterale në fushën e mbrojtjes shoqërore, veçanërisht me vendet e BE dhe sigurimi i asistencës, shkëmbimit të përvojës dhe bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtarë.
- Informimi i publikut për veprimtarinë dhe shërbimet e Fondit, në kuadër të rritjes së transparencës në marrëdhëniet me qytetarët.